内科教学题库

大四上·内科学期末题库（消化/泌尿/内分泌/风湿/理化）batch033 题库（443题）

> 来源：最终产物\batch033\ALL_questions_FIXED.json ｜ 导出：2026-09-04 12:20
> 题型分布：A1×181、A2×131、X×46、B1×42、A4×23、A3×20
> Bloom分布：理解×175、记忆×135、应用×111、分析×22

M1（85题）

1. [A1型题｜记忆] batch033-D1-A1-001

> 模块：M1 | 页码：教材P356

胃黏膜屏障的组成中，不包括下列哪项？

- A. 表面上皮紧密连接构成物理屏障
- B. 黏液与碳酸氢盐构成化学屏障
- C. 黏膜血流与上皮更新构成细胞屏障
- D. 胃蛋白酶原分泌构成侵袭因素 ✅
- E. 免疫细胞参与构成生物屏障

答案：D

> 解析：胃黏膜屏障包括上皮紧密连接(物理)、黏液-碳酸氢盐(化学)、黏膜血流与上皮更新(细胞)及免疫细胞(生物)；胃蛋白酶原由主细胞分泌，是侵袭因素而非屏障。教材P356。

---

2. [A1型题｜理解] batch033-D1-A1-002

> 模块：M1 | 页码：教材P356

剑突下烧灼感伴反酸，最提示病变部位为

- A. 食管病变 ✅
- B. 胃十二指肠病变
- C. 肝胆病变
- D. 胰腺病变
- E. 结肠病变

答案：A

> 解析：剑突下/胸骨后烧灼感为反流刺激食管所致，定位食管；胃十二指肠多为中上腹节律痛。教材P356。

---

3. [A1型题｜记忆] batch033-D1-A1-003

> 模块：M1｜页码：教材P359

下列病变中，胃镜检查是首选诊断方法的是

- A. 食管黏膜病变 ✅
- B. 胆总管结石
- C. 腹腔积液定性
- D. 胰头占位
- E. 大肠病变

答案：A

> 解析：胃镜直视上消化道黏膜并可活检，是食管胃十二指肠黏膜病变(反流性食管炎、溃疡、胃癌)首选；胆胰用ERCP，腹水用穿刺，结直肠用结肠镜。教材P359。

---

4. [A1型题｜记忆] batch033-D1-A1-004

> 模块：M1｜页码：教材P359

结直肠及末端回肠病变的首选检查是

- A. 胃镜
- B. 结肠镜 ✅
- C. ERCP

- D. 腹腔穿刺
- E. 腹部CT

答案：B

> 解析：结肠镜是结直肠与末端回肠病变(炎性肠病、肿瘤)诊断金标准；胃镜看上消化道，ERCP看胆胰管。教材P359。

---

5. [A1型题｜理解] batch033-D1-A1-005

> 模块：M1｜页码：教材P359

血清-腹水白蛋白梯度(SAAG)≥11g/L 最支持

- A. 门脉高压性腹水 ✅
- B. 结核性腹膜炎
- C. 癌性腹水
- D. 胰源性腹水
- E. 自发性腹膜炎

答案：A

> 解析：SAAG=血清白蛋白-腹水白蛋白，≥11g/L提示门脉高压(如肝硬化)；<11g/L多见于结核、肿瘤等。教材P359。

---

6. [A1型题｜记忆] batch033-D1-A1-006

> 模块：M1｜页码：教材P359

漏出液的蛋白含量通常为

- A. <25g/L ✅
- B. 25-30g/L
- C. >30g/L
- D. >40g/L
- E. >50g/L

答案：A

> 解析：漏出液蛋白<25g/L、比重<1.018、Rivalta阴性，见于肝硬化/心衰/肾病；渗出液蛋白>30g/L。教材P359。

---

7. [A1型题｜理解] batch033-D1-A1-007

> 模块：M1｜页码：教材P356

进食后腹泻不缓解、粪便量大呈水样，最可能的腹泻类型是

- A. 渗透性腹泻
- B. 分泌性腹泻 ✅
- C. 渗出性腹泻
- D. 动力性腹泻
- E. 感染性腹泻

答案：B

> 解析：分泌性腹泻肠分泌增加(霍乱、神经内分泌瘤)，量大、禁食不缓解；渗透性禁食后缓解，渗出性带脓血，动力性糊状。教材P356。

---

8. [A1型题｜记忆] batch033-D1-A1-008

> 模块：M1｜页码：教材P359

上消化道出血时对病因诊断最有帮助的检查方法是

- A. 选择性腹腔动脉造影术
- B. 内镜检查(胃镜) ✅
- C. X线钡餐造影检查
- D. 胃黏膜活检病理
- E. 放射性核素检查

答案：B

> 解析：上消化道出血最常见的病因为消化性溃疡，占 50%，其次为出血性胃炎、胃癌等，因此对明确上消化道出血病因最有帮助的检查方法是内镜检查。内镜检查既可明确出血原因、部位，还可在内镜下行止血治疗。［源:考研真题 GS-1995-092］

---

9. [A2型题｜应用] batch033-D1-A2-009

> 模块：M1｜页码：教材P356

男性,35岁。反复中上腹疼痛2年，呈空腹痛、夜间痛，进食后缓解。提示病变最可能在

- A. 食管病变
- B. 胃十二指肠病变 ✅
- C. 小肠病变
- D. 肝胆病变
- E. 结肠病变

答案：B

> 解析：空腹痛、夜间痛、进食缓解为十二指肠溃疡典型节律，病变在胃十二指肠；食管多为烧灼反流。教材P356-374。

---

10. [A2型题｜理解] batch033-D1-A2-010

> 模块：M1｜页码：教材P359

男性,52岁。腹胀、下肢水肿，腹水检查比重1.012、蛋白22g/L、SAAG 14g/L。最可能的病因是

- A. 肝硬化门脉高压 ✅
- B. 结核性腹膜炎
- C. 癌性腹膜炎
- D. 急性胰腺炎
- E. 肾病综合征

答案：A

> 解析：比重<1.018、蛋白<25g/L为漏出液，SAAG≥11g/L提示门脉高压，结合临床最支持肝硬化。教材P359。

---

11. [A2型题｜应用] batch033-D1-A2-011

> 模块：M1｜页码：教材P356

女性,28岁。进食牛奶后腹胀、腹泻，禁食后症状消失。最可能的腹泻类型是

- A. 渗透性腹泻 ✅
- B. 分泌性腹泻
- C. 渗出性腹泻
- D. 动力性腹泻
- E. 感染性腹泻

答案：A

> 解析：渗透性腹泻因肠腔水溶性物质(乳糖)吸水，禁食后缓解、粪渗/血浆渗>1；其余类型禁食不缓解。教材P356。

---

12. [A2型题｜应用] batch033-D1-A2-012

> 模块：M1｜页码：教材P356

男性,60岁。皮肤巩膜黄染，大便呈陶土色，尿胆红素阳性、尿胆原减少。最可能的黄疸类型是

- A. 溶血性黄疸
- B. 肝细胞性黄疸
- C. 梗阻性黄疸 ✅
- D. 先天性黄疸
- E. 生理性黄疸

答案：C

> 解析：梗阻性黄疸直接胆红素升高为主，ALP/GGT明显升高，尿胆原减少或阴性，大便陶土色；溶血以间接胆红素为主，肝细胞以肝酶为主。教材P356。

13. [A2型题｜理解] batch033-D1-A2-013

> 模块：M1｜页码：教材P359

女性,25岁。发热、黏液脓血便，诊断为暴发型溃疡性结肠炎。下列哪项检查属禁忌

- A. 结肠镜
- B. 钡剂灌肠 ✅
- C. 粪培养
- D. 血常规
- E. 腹部超声

答案：B

> 解析：暴发型/重症溃疡性结肠炎禁钡剂灌肠(易诱发中毒性巨结肠)，但可行结肠镜；上消化道出血可行急诊胃镜。教材P359。

---

14. [A2型题｜应用] batch033-D1-A2-014

> 模块：M1｜页码：教材P359

男性,45岁。呕血、黑便1天，既往无肝炎史。为明确出血病因，应首选

- A. 急诊胃镜 ✅
- B. 腹部CT
- C. 钡餐造影
- D. 腹腔动脉造影
- E. 腹部超声

答案：A

> 解析：上消化道出血病因诊断最有帮助的是内镜检查，急诊胃镜可明确部位并止血；急性期不宜钡餐。教材P359。

---

15. [A3型题｜应用] batch033-D1-A3-015

> 模块：M1｜页码：教材P359

女性,50岁。反复上腹胀痛3个月，伴消瘦、食欲下降，大便隐血阳性。为明确诊断，应首选的检查是

- A. 胃镜及活检 ✅
- B. 结肠镜
- C. ERCP
- D. 腹部X线
- E. 肿瘤标志物

答案：A

> 解析：中上腹症状伴消瘦、隐血阳性，首选胃镜直视上消化道并活检以定性；结肠镜看下消化道，ERCP看胆胰管。教材P359。

---

16. [A4型题｜分析] batch033-D1-A4-016

> 模块：M1｜页码：教材P359

男性,60岁。腹胀、少尿2周，移动性浊音阳性，腹水蛋白20g/L、细胞数80×10^6/L、SAAG 13g/L。该腹水最符合

- A. 门脉高压性漏出液 ✅
- B. 结核性渗出液
- C. 癌性渗出液
- D. 胰源性腹水
- E. 自发性腹膜炎

答案：A

> 解析：蛋白<25g/L、比重<1.018为漏出液，SAAG≥11g/L提示门脉高压驱动，符合肝硬化漏出液；细胞数不高不支持感染/肿瘤渗出。教材P359。

---

17. [B1型题｜理解] batch033-D1-B1-017

> 模块：M1｜页码：教材P359

胆总管结石伴梗阻性黄疸，首选的诊疗技术是

- A. 胃镜
- B. 结肠镜
- C. ERCP ✅
- D. 腹腔穿刺
- E. MRCP

答案：C

> 解析：ERCP可直视胆胰管并取石/支架，是胆总管结石、梗阻性黄疸的诊断+治疗首选；胃镜看黏膜，穿刺看腹水。教材P359。

---

18. [B1型题｜记忆] batch033-D1-B1-018

> 模块：M1｜页码：教材P359

为判定腹水性质(漏出或渗出)及门脉高压，应选用的检查是

- A. 胃镜检查
- B. 结肠镜
- C. ERCP
- D. 腹腔穿刺 ✅
- E. MRCP

答案：D

> 解析：腹腔穿刺+腹水化验可定性腹水，SAAG≥11g/L提示门脉高压；其余技术用于黏膜或胆胰成像。教材P359。

---

19. [X型题｜理解] batch033-D1-X-019

> 模块：M1｜页码：教材P356

关于胃黏膜屏障，正确的有

- A. 表面上皮紧密连接构成物理屏障 ✅
- B. 黏液与碳酸氢盐构成化学屏障 ✅
- C. 黏膜血流与上皮更新构成细胞屏障 ✅
- D. 胃蛋白酶原是屏障核心成分
- E. 免疫细胞参与生物屏障 ✅

答案：ABCE

> 解析：屏障四层：上皮紧密连接(物理)+黏液-碳酸氢盐(化学)+黏膜血流与上皮更新(细胞)+免疫细胞(生物)；胃蛋白酶原为侵袭因素，非屏障。教材P356。

---

20. [X型题 | 理解] batch033-D1-X-020

> 模块：M1 | 页码：教材P359

可引起上消化道出血的病因有

- A. 食管憩室炎 ✅
- B. 消化性溃疡 ✅
- C. 胃癌病变 ✅
- D. 慢性萎缩性胃炎

答案：ABC

> 解析：①上消化道出血是指食管、胃、十二指肠、空肠上段、胆道病变引起的出血。食管憩室炎、消化性溃疡、胃癌都是上消化道出血的病因。②急性胃炎可引起上消化道出血，但慢性萎缩性胃炎很少引起上消化道出血。［源:考研真题 GS-2021-156］

---

21. [A1型题 | 记忆] batch033-R1-A1-001

> 模块：M1 | 页码：教材P473

原发性肾小球疾病按临床表现可分为多种综合征，下列哪项不属于其临床综合征分类？

- A. 急性肾间质综合征 ✅
- B. 急性肾炎综合征

- C. 急进性肾炎综合征
- D. 慢性肾炎综合征
- E. 肾病综合征

答案：A

> 解析：原发性肾小球疾病的临床综合征分为：急性肾炎综合征、急进性肾炎综合征、慢性肾炎综合征、肾病综合征、无症状性蛋白尿和/或血尿。急性肾间质综合征属间质疾病，不属此分类。教材P473。

---

22. [A1型题｜记忆] batch033-R1-A1-002

> 模块：M1｜页码：教材P476

急性肾小球肾炎最常见的致病菌前驱感染是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 乙型溶血性链球菌 ✅
- C. 大肠埃希菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 流感嗜血杆菌

答案：B

> 解析：急性肾小球肾炎多由A组乙型溶血性链球菌（致肾炎菌株）感染后引起，感染后1~3周发病。教材P476。

---

23. [A1型题｜记忆] batch033-R1-A1-003

> 模块：M1｜页码：教材P476

急性链球菌感染后肾小球肾炎患者血清补体C3常一过性下降，通常恢复至正常水平的时间为

- A. 2周内
- B. 4周内
- C. 8周内 ✅
- D. 12周内

- E. 16周内

答案：C

> 解析：急性肾炎患者补体C3于起病时下降，多于发病8周内恢复正常，是诊断与自限过程的重要提示。教材P476。

---

24. [A1型题｜记忆] batch033-R1-A1-005

> 模块：M1｜页码：教材P466

肾小球源性血尿的典型尿红细胞形态特点是

- A. 均一、形态正常
- B. 皱缩红细胞
- C. 影红细胞为主
- D. 仅见红细胞管型
- E. 大小不等、形态多样 ✅

答案：E

> 解析：肾小球源性血尿因红细胞通过受损滤过屏障受挤压，呈大小不等、形态多样（畸形、棘形）；肾后性血尿红细胞均一。教材P466。

---

25. [A1型题｜理解] batch033-R1-A1-007

> 模块：M1｜页码：教材P476

男性，21岁。2周前咽痛、发热，体温最高为38.5℃，按“上感”治疗后好转，2天来眼睑水肿，尿少。查体：BP150/90mmHg，双眼睑水肿。尿常规：蛋白(++)，沉渣镜检红细胞20~25个/HPF。该患者水肿的主要机制是

- A. 醛固酮增高
- B. 肾小球滤过率下降 ✅
- C. 血浆胶体渗透压降低
- D. 抗利尿激素过多
- E. 淋巴回流障碍

答案：B

> 解析：①急性肾小球肾炎病前1~3周常有上呼吸道感染史。青年男性，“上感”2周后出现血尿、蛋白尿、水肿、高血压，应诊断为急性肾小球肾炎。其水肿属于肾炎性水肿，主要是由于肾小球滤过率下降，而肾小管重吸收功能基本正常造成“球-管失衡”，水钠潴留所致，故答B。②醛固酮增高、血浆胶体渗透压降低、抗利尿激素过多均属于肾病性水肿的机制，故不答A、C、D。[源:考研真题 GS-2021-052]

---

26. [A1型题｜理解] batch033-R1-A1-008

> 模块：M1｜页码：教材P476

男性,16岁,水肿伴尿少1周,3周前有“感冒”史。查体:血压140/90mmHg,眼睑及双下肢水肿。辅助检查:尿蛋白(+++),红细胞15~20个/HPF,血肌酐180μmol/L,血C3下降,ASO 1:800。该患者最可能的肾脏病理改变是

- A. 系膜增生性肾小球肾炎
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 毛细血管内增生性肾小球肾炎 ✅
- D. 局灶节段性肾小球肾炎
- E. 膜性肾病（MN）

答案：C

> 解析：①患者发病前3周有“感冒”史,补体C3下降,血清抗链球菌溶血素(ASO)滴度增高,提示近期有链球菌感染。患者有血尿、蛋白尿、水肿、高血压、肾功能减退,应诊断为急性肾小球肾炎,病理类型为毛细血管内增生性肾小球肾炎。②肾病综合征主要表现为大量蛋白尿、血浆白蛋白降低、水肿、血脂升高等,一般不会出现血尿。系膜增生性肾小球肾炎和局灶节段性肾小球肾炎是肾病综合征的常见病因。新月体性肾小球肾炎又称急进性肾炎,以肾功能急剧恶化为特点。[源:考研真题 GS-2010-070]

---

27. [A2型题｜理解] batch033-R1-A2-010

> 模块：M1｜页码：教材P477

男性,25岁。半个月前咽痛、咳嗽,1周来水肿、尿少。血常规:Hb98g/L。尿蛋白(++),沉渣镜检红细胞15~20个/HPF,血肌酐442μmol/L,血尿素氮18mmol/L。腹部B超示双肾增大。最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. IgA肾病
- E. 急进性肾小球肾炎 ✅

答案：E

> 解析：①青年患者，上呼吸道感染后出现血尿、蛋白尿、水肿等，应考虑急性肾炎综合征。患者双肾增大，短期内肾功能急剧恶化（血肌酐442μmol/L），应诊断为急进性肾小球肾炎而不是急性肾小球肾炎。②本例若无急性肾功能衰竭，则诊断为急性肾小球肾炎。患者尿蛋白（++），不能凭此诊断为肾病综合征。慢性肾小球肾炎的病程至少3个月，本例病程仅半个月，故不答D。[源：考研真题 GS-2022-053]

---

28. [A2型题｜理解] batch033-R1-A2-011

> 模块：M1｜页码：教材P487

中年男性，反复水肿、蛋白尿伴高血压3年，近1个月乏力、夜尿增多。尿蛋白（+~++），尿红细胞5~8/HPF，双肾B超示双肾稍缩小。最可能的诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎 ✅
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. IgA肾病
- E. 急性肾盂肾炎

答案：A

> 解析：慢性肾小球肾炎表现为尿检异常（蛋白尿、血尿）伴水肿、高血压病史>3个月，并渐进性进展；双肾缩小支持慢性过程。本题病程3年、肾缩小，符合慢性肾炎。教材P487。

---

29. [A2型题｜应用] batch033-R1-A2-012

> 模块：M1｜页码：教材P476

男孩12岁，咽痛2周后出现水肿、血尿，血压150/95mmHg，C3下降，ASO升高。关于该患者的治疗，下列说法恰当的是

- A. 尽早使用糖皮质激素
- B. 以休息、对症及抗感染为主 ✅
- C. 首选细胞毒药物
- D. 立即行肾活检
- E. 长期抗凝治疗

答案：B

> 解析：急性肾小球肾炎为自限性疾病，治疗以休息、对症（限盐、利尿）、清除链球菌感染（青霉素）为主，不宜使用糖皮质激素与细胞毒药物。教材P476。

---

30. [A2型题｜应用] batch033-R1-A2-014

> 模块：M1｜页码：教材P476

急性肾小球肾炎患者出现一过性轻中度高血压，其主要机制为水钠潴留。控制血压应首选

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 钙通道阻滞剂
- C. β受体阻滞剂
- D. 袢利尿剂为主 ✅
- E. 血管紧张素受体拮抗剂

答案：D

> 解析：急性肾炎高血压多因水钠潴留、血容量扩张所致，利尿后血压可渐恢复，故首选利尿剂；ACEI/ARB多用于慢性肾炎或肾综降压护肾。教材P476。

---

31. [A4型题｜应用] batch033-R1-A4-016

> 模块：M1｜页码：教材P487

男性，45岁，确诊慢性肾小球肾炎5年，长期蛋白尿、高血压。近日因“受凉”后出现少尿、水肿加重，血肌酐较前明显升高，无尿路梗阻证据。最可能的原因是

- A. 感染诱发肾功能恶化 ✅
- B. 疾病自然进展
- C. 药物性肾损害
- D. 肾静脉血栓
- E. 合并恶性肿瘤

答案：A

> 解析：慢性肾炎在感染、高血压控制不佳、有效血容量不足、肾毒性药物等诱因下可急性加重；本例“受凉”后加重，最可能为感染诱发。教材P487。

---

32. [B1型题｜理解] batch033-R1-B1-017

> 模块：M1｜页码：教材P476

链球菌感染后急性肾小球肾炎的病理类型主要是

- A. 新月体性肾小球肾炎
- B. 毛细血管内增生性肾小球肾炎 ✅
- C. 系膜增生性肾小球肾炎（IgA肾病）
- D. 膜性肾病（MN型）
- E. 微小病变型肾病（MCD）

答案：B

> 解析：急性链球菌感染后肾小球肾炎病理为毛细血管内增生性肾小球肾炎（内皮与系膜细胞增生）。教材P476。

---

33. [X型题｜理解] batch033-R1-X-019

> 模块：M1｜页码：教材P476

关于急性链球菌感染后肾小球肾炎，下列说法正确的有

- A. 常于感染后1~3周起病 ✅
- B. 表现为血尿、蛋白尿、水肿、高血压 ✅
- C. 血清补体C3一过性下降 ✅

- D. 治疗以糖皮质激素为主
- E. 多数患者8周内C3恢复正常 ✅

答案：ABCE

> 解析：急性肾炎于链球菌感染后1~3周起病，具急性肾炎综合征表现，C3一过性下降、8周内恢复；为自限性疾病，不宜用糖皮质激素。教材P476。

---

34. [A1型题｜记忆] batch033-E1-A1-001

> 模块：M1｜页码：教材P654

下列激素中，属于类固醇激素的是？

- A. 胰岛素
- B. 甲状腺激素
- C. 皮质醇 ✅
- D. 生长激素
- E. 肾上腺素

答案：C

> 解析：类固醇激素由胆固醇衍生，经胞内/核受体调节基因转录，代表有皮质醇、性激素、醛固酮、维生素D；胰岛素、生长激素、甲状腺激素、肾上腺素均属含氮激素。教材P654。

---

35. [A1型题｜记忆] batch033-E1-A1-002

> 模块：M1｜页码：教材P654

含氮激素（肽/蛋白/胺）发挥作用主要依赖的受体是？

- A. 细胞膜受体 ✅
- B. 细胞核受体
- C. 线粒体受体
- D. 溶酶体受体
- E. 核糖体受体

答案：A

> 解析：含氮激素亲水、不能进入细胞，与细胞膜受体结合后通过G蛋白-第二信使（cAMP/IP3）起效，毫秒至分钟级；类固醇激素才走核受体。教材P654。

---

36. [A1型题｜理解] batch033-E1-A1-003

> 模块：M1｜页码：教材P654

甲状腺激素（T3/T4）化学本质为胺类（含氮），但其主要起效途径是？

- A. 细胞膜G蛋白受体
- B. 胞内/核受体 ✅
- C. 线粒体DNA
- D. 溶酶体酶的情况
- E. 核糖体的情况

答案：B

> 解析：甲状腺激素虽属含氮激素，却是特例——不直接经膜受体，而是进入细胞与核受体结合调控基因转录；此为考试常见陷阱。教材P654。

---

37. [A1型题｜记忆] batch033-E1-A1-004

> 模块：M1｜页码：教材P656

反映甲状腺功能状态最敏感的指标是？

- A. TSH
- B. FT3
- C. FT4
- D. TgAb ✅
- E. TPOAb

答案：D

> 解析：TSH由垂体分泌，受靶腺激素负反馈调控，对甲状腺功能变化最敏感，是筛查甲功的第一线指标；FT3/FT4反映靶腺激素水平。教材P656、P690。

---

38. [A1型题｜理解] batch033-E1-A1-005

> 模块：M1｜页码：教材P656

某患者TSH降低、FT4升高，最符合的病变定位是？

- A. 下丘脑病变的状态
- B. 垂体TSH瘤的状态
- C. 甲状腺（靶腺原发亢进） ✅
- D. 肾上腺病变的状态
- E. 卵巢病变的状态

答案：C

> 解析：靶腺激素（FT4）升高且上级TSH被抑制而降低，二者反向改变，提示负反馈仍正常、病在靶腺本身（原发性甲亢）；若TSH与FT4同向升高才提示反馈失灵、病在上位。教材P656。

---

39. [A1型题｜理解] batch033-E1-A1-006

> 模块：M1｜页码：教材P659

内分泌代谢病诊断的第一步是？

- A. 功能诊断（激素多/少）
- B. 定位诊断（轴第几级）
- C. 病因诊断（免疫/肿瘤）
- D. 影像学检查的状态
- E. 病理活检的情况 ✅

答案：E

> 解析：诊断按递进顺序：一功能（激素多了还是少了）、二定位（轴的第几级）、三病因（为什么）；先定有无病，再看病在哪，最后找病因。教材P659。

40. [A1型题｜记忆] batch033-E1-A1-007

> 模块：M1｜页码：教材P656

神经垂体（垂体后叶）释放的激素是？

- A. TSH的情况
- B. ACTH的情况
- C. 血管升压素（ADH） ✅
- D. GnRH的情况
- E. TRH的情况

答案：C

> 解析：神经垂体释放血管升压素（ADH）与催产素；TSH、ACTH由腺垂体前叶分泌，GnRH、TRH由下丘脑释放。教材P656。

---

41. [A1型题｜应用] batch033-E1-A1-008

> 模块：M1｜页码：教材P690

孕妇查体发现总T4升高，但游离FT4正常、TSH正常，最可能的原因是？

- A. 真性甲亢致T4升高
- B. 妊娠致TBG升高 ✅
- C. 原发性甲减致T4降低
- D. 垂体TSH瘤致T4升高
- E. 药物因素致T4升高

答案：B

> 解析：雌激素使甲状腺素结合球蛋白（TBG）升高，总T4随之升高但游离激素正常，并非真甲亢；诊断甲亢应看游离FT3/FT4。教材P690。

---

42. [A2型题｜应用] batch033-E1-A2-009

> 模块：M1｜页码：教材P686

青年女性，怕热多汗、心悸、体重下降，查TSH 0.01mU/L（降低）、FT4升高、TRAb阳性。其病变部位最可能是？

- A. 下丘脑的情况
- B. 垂体的情况
- C. 甲状腺（靶腺） ✅
- D. 肾上腺的情况
- E. 卵巢的情况

答案：C

> 解析：TSH降低伴FT4升高、TRAb阳性，符合原发性甲状腺功能亢进（病在甲状腺本身），负反馈正常；TRAb阳性支持Graves病。教材P686、P656。

---

43. [A2型题｜理解] batch033-E1-A2-010

> 模块：M1｜页码：教材P656

中年男性，乏力、畏寒、便秘，查TSH升高、FT4降低。最符合的诊断是？

- A. 原发性甲状腺功能减退 ✅
- B. 中枢性甲减的状态
- C. 甲状腺功能亢进
- D. 正常变异的情况
- E. 亚临床甲亢的状态

答案：A

> 解析：TSH升高伴FT4降低，靶腺激素与上级同向降低、TSH代偿性升高，提示负反馈正常、病在靶腺（原发性甲减）；中枢性甲减时TSH正常或降低。教材P656。

---

44. [A2型题｜应用] batch033-E1-A2-011

> 模块：M1｜页码：教材P656

患者TSH升高伴FT4升高，最可能的诊断是？

- A. 原发性甲亢（TSH抑制）
- B. 垂体TSH瘤（反馈失灵） ✅
- C. 原发性甲减（TSH升高）
- D. 正常生理变异（TSH正常）
- E. 药物性甲亢（TSH抑制）

答案：B

> 解析：靶腺激素（FT4）与上级（TSH）同向升高，提示负反馈失灵、病在上位（垂体病变或反馈断）；原发性甲亢应为TSH降低。教材P656。

---

45. [A2型题｜理解] batch033-E1-A2-012

> 模块：M1｜页码：教材P656

下列内分泌调节中，属于正反馈的是？

- A. 皮质醇抑制CRH/ACTH
- B. 排卵前LH峰的状态 ✅
- C. T4抑制TRH/TSH
- D. 血钙升高抑制PTH的状态
- E. 胰岛素抑制胰高血糖素

答案：B

> 解析：正反馈为少见的一次性放大回路，如排卵前LH峰、分娩时催产素释放；其余均为负反馈（靶腺激素抑制上级）。教材P656。

---

46. [A2型题｜应用] batch033-E1-A2-013

> 模块：M1｜页码：教材P659

女性，闭经、溢乳，血泌乳素明显升高，拟定位病变部位，首选的检查是？

- A. 垂体MRI ✅
- B. 甲状腺超声
- C. 肾上腺CT
- D. 卵巢B超
- E. 骨密度测定

答案：A

> 解析：高泌乳素血症伴闭经溢乳提示垂体泌乳素瘤可能，定位诊断首选垂体MRI；属内分泌定位诊断（影像+激素水平）的典型应用。教材P659。

---

47. [A2型题｜理解] batch033-E1-A2-014

> 模块：M1｜页码：教材P654

血中激素发挥生物效应主要依赖的形式是？

- A. 结合蛋白结合态
- B. 游离态的情况 ✅
- C. 已降解态的情况
- D. 聚合态的情况
- E. 储存池态的情况

答案：B

> 解析：血中激素多为游离态起作用，结合蛋白（如TBG）是储存池；测定游离浓度更能反映真实现状。教材P654。

---

48. [A3型题｜应用] batch033-E1-A3-015

> 模块：M1｜页码：教材P656

45岁男性，近半年体重下降、怕热，查TSH 0.02mU/L（降低）、FT4 32pmol/L（升高）、FT3 9pmol/L（升高），TRH兴奋试验示TSH无反应。该结果提示病变部位在？

- A. 下丘脑的情况

- B. 垂体的情况
- C. 甲状腺（靶腺） ✅
- D. 肾上腺的情况
- E. 无从判断的情况

答案：C

> 解析：TSH已被高水平T3/T4抑制且对TRH无反应，结合TSH降低、FT4/FT3升高，定位为甲状腺本身原发性亢进；若为垂体病变则TSH多不被抑制或自主升高。教材P656。

---

49. [A4型题｜分析] batch033-E1-A4-016

> 模块：M1｜页码：教材P691

38岁女性，Graves病未规律治疗，因感染诱发突发高热39.5℃、心率140次/分、意识模糊、腹泻。从内分泌轴稳态分析，当前最危急的病理环节是？

- A. 垂体功能衰竭的状态
- B. 交感-激素竞相放大致甲状腺危象 ✅
- C. 肾上腺危象的状态
- D. 低血糖昏迷的状态
- E. 严重低钾血症的状态

答案：B

> 解析：Graves病因TSAb持续刺激、负反馈约束失效；感染应激下交感与过量甲状腺激素竞相放大，突破代偿进入甲状腺危象（高热、心动过速、意识障碍），是轴失衡的急症升级。教材P691。

---

50. [B1型题｜记忆] batch033-E1-B1-017

> 模块：M1｜页码：教材P654

与胞内/核受体结合、调控基因转录，起效慢而持久的是？

- A. 含氮激素
- B. 类固醇激素 ✅

- C. 脂肪酸衍生物
- D. 胺类激素
- E. 肽类激素

答案：B

> 解析：类固醇激素（皮质醇、性激素等）亲脂，进入细胞与核受体结合调节基因转录，起效慢而持久；含氮激素走膜受体。教材P654。

---

51. [B1型题｜记忆] batch033-E1-B1-018

> 模块：M1｜页码：教材P654

经细胞膜受体-G蛋白-第二信使起效、起效快的是？

- A. 含氮激素 ✅
- B. 类固醇激素
- C. 脂肪酸衍生物
- D. 胺类激素
- E. 肽类激素

答案：A

> 解析：含氮激素（胰岛素、TSH等）亲水、不能入胞，与膜受体结合经G蛋白-第二信使（cAMP/IP3）起效，秒至分级；脂肪酸衍生物多为局部旁分泌。教材P654。

---

52. [X型题｜理解] batch033-E1-X-019

> 模块：M1｜页码：教材P656

关于激素分泌的调节方式，正确的有？

- A. 负反馈是最常见的调节方式 ✅
- B. 分娩时催产素释放属正反馈 ✅
- C. 应激时儿茶酚胺释放属神经调节 ✅
- D. 甲状旁腺激素对血钙的调控属自身调节 ✅
- E. 激素调节仅依赖负反馈一种方式

答案：ABCD

> 解析：激素调节包括负反馈（最常见，如皮质醇抑制CRH/ACTH）、正反馈（分娩催产素、排卵LH峰）、神经调节（应激儿茶酚胺）、自身调节（甲状旁腺对血钙）；并非所有激素只受负反馈。教材P656。

---

53. [X型题｜理解] batch033-E1-X-020

> 模块：M1｜页码：教材P656

关于下丘脑-垂体-靶腺轴负反馈与定位，正确的有？

- A. 靶腺激素升高通常反馈抑制上级分泌的状态 ✅
- B. TSH与FT4同向升高提示反馈失灵、病在上位 ✅
- C. TSH降低伴FT4升高提示病在靶腺、负反馈正常 ✅
- D. 原发性甲减时TSH代偿性升高的状态 ✅
- E. 内分泌病以负反馈增强为主的状态

答案：ABCD

> 解析：靶腺激素升高反馈抑制上级；靶腺与上级同向改变=反馈失灵（病在上位），反向改变=病在靶腺（负反馈正常）；原发性甲减TSH代偿升高。内分泌病更多是负反馈约束被打破（减弱或绕过），并非均增强。教材P656。

---

54. [A1型题｜记忆] batch033-S1-A1-001

> 模块：M1｜页码：教材P808

下列关于风湿性疾病本质的描述，正确的是

- A. 免疫介导、疼痛为核心 ✅
- B. 细菌感染直接引起
- C. 仅累及单一关节
- D. 好发于老年男性
- E. 都属于退行性病变

答案：A

> 解析：风湿性疾病是免疫介导、以关节/肌肉疼痛为核心、可累及多系统的疾病，本质为自身免疫攻击自身组织；不属感染或单纯退行性疾病。教材P808。

---

55. [A1型题｜记忆] batch033-S1-A1-002

> 模块：M1｜页码：教材P808

下列疾病中属于弥漫性结缔组织病的是

- A. 骨性关节炎
- B. 类风湿关节炎 ✅
- C. 痛风性关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 反应性关节炎

答案：B

> 解析：弥漫性结缔组织病包括RA、SLE、干燥综合征、皮肌炎、系统性硬化症、血管炎等；AS属血清阴性脊柱关节病，骨关节炎属退行性，痛风属代谢相关。教材P808。

---

56. [A1型题｜记忆] batch033-S1-A1-003

> 模块：M1｜页码：教材P810

在系统性红斑狼疮的自身抗体中，灵敏度近100%、最适合作为筛查试验的是

- A. 抗Sm抗体
- B. 抗dsDNA
- C. 抗核抗体ANA ✅
- D. 抗CCP抗体
- E. 类风湿因子

答案：C

> 解析：ANA对SLE灵敏度近100%，但特异度仅约65%，故为最佳筛查试验；抗dsDNA/抗Sm为标记性抗体，抗CCP为RA特异抗体。教材P810。

57. [A1型题｜记忆] batch033-S1-A1-004

> 模块：M1｜页码：教材P810

对系统性红斑狼疮具有高度特异性、且与疾病活动性无关的血清标记性抗体是

- A. 抗dsDNA
- B. 抗核抗体ANA
- C. 抗CCP抗体
- D. 抗Sm抗体谱 ✅
- E. 类风湿因子

答案：D

> 解析：抗Sm抗体对SLE特异度约99%，为血清标记性抗体，但滴度与疾病活动性无关；抗dsDNA才与活动性相关。教材P810。

---

58. [A1型题｜记忆] batch033-S1-A1-005

> 模块：M1｜页码：教材P810

系统性红斑狼疮活动期，补体C3、C4的典型变化是

- A. 较健康人明显升高
- B. 先升高后下降
- C. 无明显动态变化
- D. 仅C3轻度升高
- E. 较健康人明显下降 ✅

答案：E

> 解析：SLE活动期大量免疫复合物形成并沉积，补体被消耗，故C3、C4下降；这是与ESR/CRP升高方向相反的特异性反向活动性指标。教材P810。

---

59. [A1型题｜理解] batch033-S1-A1-006

> 模块：M1｜页码：教材P810

下列自身抗体中，不属于抗ENA（可提取核抗原）抗体谱的是

- A. 抗dsDNA ✅
- B. 抗RNP抗体
- C. 抗SSB抗体
- D. 抗Sm（ENA）
- E. 抗rRNP抗体

答案：A

> 解析：抗ENA抗体谱包括抗RNP、抗SSA、抗SSB、抗Sm、抗rRNP；抗dsDNA属抗核抗体，是SLE标记性抗体但不属于ENA谱。[源:考研真题 GS-2016-076]。教材P810。

---

60. [A1型题｜理解] batch033-S1-A1-008

> 模块：M1｜页码：教材P808

下列疾病中属于退行性病变（而非自身免疫性）的是

- A. 强直性脊柱炎
- B. 银屑病关节炎
- C. 骨性关节炎 ✅
- D. 莱特综合征
- E. 系统性红斑狼疮

答案：C

> 解析：风湿病十大类中骨性关节炎属退行性病变；AS、银屑病关节炎、莱特综合征属血清阴性脊柱关节病；SLE属弥漫性结缔组织病。[源:考研真题 GS-2007-075]。教材P808。

---

61. [A2型题｜理解] batch033-S1-A2-010

> 模块：M1｜页码：教材P808

患者对称性小关节肿痛伴晨僵，晨僵持续约1.5小时。对鉴别滑膜炎与退行性病变最有价值的线索是

- A. 晨僵的时长 ✅
- B. 关节疼痛程度
- C. 关节红肿范围
- D. 受累关节数目
- E. 发病年龄与晨僵

答案：A

> 解析：晨僵是滑膜炎的活动性指标，RA晨僵常>1小时，骨关节炎晨僵短暂；晨僵时长是鉴别免疫性滑膜炎与退行性病变的常用分界。教材P808-810。

---

62. [A2型题｜理解] batch033-S1-A2-011

> 模块：M1｜页码：教材P810

青年女性，双手近端指间关节、掌指关节对称性肿痛1年，RF阳性。为进一步提高诊断特异性，应首选检测

- A. 抗核抗体谱
- B. 抗CCP抗体 ✅
- C. 抗dsDNA
- D. 抗Sm抗体
- E. 抗SSA抗体

答案：B

> 解析：抗CCP抗体对RA特异度93%~98%，高于RF（约86%），有助早期诊断与提高特异性；ANA/抗dsDNA/抗Sm为SLE相关抗体。教材P810。

---

63. [A2型题｜应用] batch033-S1-A2-012

> 模块：M1｜页码：教材P810

疑诊风湿性疾病的患者，为判断是否存在炎症活动，应最先进行的检查是

- A. 抗核抗体谱
- B. 关节X线检查
- C. 血沉与CRP ✅
- D. 抗CCP抗体
- E. 肾穿刺活检

答案：C

> 解析：风湿病检查遵循“先炎症→再抗体→后脏器”思路，ESR/CRP升高提示炎症活动，是初步判断有无活动的最常用指标。教材P810。

---

64. [A2型题｜应用] batch033-S1-A2-013

> 模块：M1｜页码：教材P810

女性患者，面部皮疹、关节痛、蛋白尿，实验室检查补体C3、C4下降。该补体变化最支持的诊断是

- A. 骨性关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 痛风性关节炎
- D. 系统性红斑狼疮 ✅
- E. 强直性脊柱炎

答案：D

> 解析：SLE活动期免疫复合物大量沉积消耗补体，C3/C4下降为SLE特异的活动性反向指标；RA活动期补体多正常或轻度升高。教材P810。

---

65. [A2型题｜理解] batch033-S1-A2-014

> 模块：M1｜页码：教材P808

继发于系统性红斑狼疮的干燥综合征患者中，出现的特异性抗体是

- A. 抗SSA抗体 ✅
- B. 抗磷脂相关抗体

- C. 抗RNP抗体
- D. 抗组蛋白抗体
- E. 抗dsDNA抗体

答案：A

> 解析：抗SSA抗体见于继发SLE的干燥综合征；抗磷脂抗体见于抗磷脂综合征，抗RNP与雷诺/肌炎相关，抗组蛋白抗体几乎见于所有SLE。[源:考研真题 GS-2009-074]。教材P808。

---

66. [A3型题｜应用] batch033-S1-A3-015

> 模块：M1｜页码：教材P820

女性，28岁，反复发热、面部皮疹、关节痛2个月，近1周出现双下肢水肿、尿泡沫增多。查体：血压150/95mmHg，颜面水肿。实验室检查：尿蛋白(+++)，抗核抗体阳性。

- A. 类风湿关节炎
- B. 骨性关节炎
- C. 痛风性关节炎
- D. 强直性脊柱炎
- E. 系统性红斑狼疮 ✅

答案：E

> 解析：育龄女性+蝶形红斑+多系统受累（皮肤、关节、肾）+ANA阳性，符合SLE；RA以侵蚀性小关节炎为主，骨关节炎/痛风/AS无此多系统表现。教材P808、P820。

---

67. [A4型题｜分析] batch033-S1-A4-016

> 模块：M1｜页码：教材P810

女性，30岁，发热、关节痛、面部红斑3周，伴脱发、口腔溃疡。查体：体温38.2℃，双侧面颊蝶形红斑。化验：Hb 90g/L，WBC 3.0×10^9/L，Plt 90×10^9/L，尿蛋白(+)，抗dsDNA阳性，补体C3下降。该患者的补体C3下降最恰当的机制解释是

- A. 合成增加、消耗减少
- B. 免疫复合物沉积被消耗 ✅

- C. 肝脏合成功能衰竭
- D. 补体遗传性缺乏
- E. 药物抑制其合成

答案：B

> 解析：SLE活动期大量免疫复合物形成并沉积，补体作为“清道夫”被消耗，C3、C4下降，既支持诊断又提示活动；与ESR/CRP升高方向相反。教材P810。

---

68. [B1型题｜记忆] batch033-S1-B1-017

> 模块：M1｜页码：教材P810

作为系统性红斑狼疮最佳筛查试验的抗体是

- A. 抗核抗体ANA ✅
- B. 抗dsDNA
- C. 抗Sm抗体谱
- D. 抗CCP抗体
- E. 类风湿因子

答案：A

> 解析：ANA对SLE灵敏度近100%，特异度约65%，为最佳筛查试验；余选项分别为标记/活动性抗体或RA相关抗体。教材P810。

---

69. [B1型题｜理解] batch033-S1-B1-018

> 模块：M1｜页码：教材P810

对类风湿关节炎诊断特异性最高的抗体是

- A. 抗核抗体ANA
- B. 抗dsDNA
- C. 抗CCP抗体谱 ✅
- D. 抗Sm抗体
- E. 类风湿因子

答案：C

> 解析：抗CCP抗体对RA特异度93%~98%，高于RF（约86%），是RA高特异的诊断性抗体；余为SLE相关或RA非特异抗体。教材P810。

---

70. [X型题｜应用] batch033-S1-X-019

> 模块：M1｜页码：教材P810

下列指标中，可用于评估风湿性疾病病情活动的有

- A. 血沉（ESR）升高 ✅
- B. C反应蛋白升高 ✅
- C. 活动期补体C3下降 ✅
- D. 抗dsDNA滴度升高 ✅
- E. 类风湿因子阴性

答案：ABCD

> 解析：活动期非特异性标志ESR、CRP升高；SLE活动期补体C3/C4下降、抗dsDNA滴度升高与活动相关；RF阴性不能反映活动（RF阴性不能排除RA）。教材P810。

---

71. [X型题｜应用] batch033-S1-X-020

> 模块：M1｜页码：教材P808

下列关于风湿性疾病分类与特征抗体的描述，正确的有

- A. RA与SLE同属结缔组织病 ✅
- B. AS属血清阴性脊柱病、RF阴 ✅
- C. 抗CCP是RA的高特异抗体 ✅
- D. 抗Sm特异但与活动性无关
- E. 骨关节炎属退行性病变 ✅

答案：ABCE

> 解析：RA与SLE均属弥漫性结缔组织病；AS属血清阴性脊柱关节病、RF常阴性；抗CCP对RA高特异；抗Sm特异但“与活动性无关”故D错；骨关节炎属退行性。教材P808-810。

---

72. [A1型题｜记忆] batch033-T1-A1-001

> 模块：M1｜页码：教材P877

氰化物中毒主要是由于抑制了下列哪种细胞色素？

- A. 细胞色素b
- B. 细胞色素c
- C. 细胞色素a
- D. 细胞色素aa3 ✅
- E. 细胞色素c1

答案：D

> 解析：氰化物中毒时，氰离子抑制细胞色素氧化酶（细胞色素aa3），使细胞不能利用氧而发生细胞内窒息。教材P877。［源:考研真题 GS-2003-025］

---

73. [A1型题｜记忆] batch033-T1-A1-002

> 模块：M1｜页码：教材P881

亚硝酸盐中毒引起的皮肤、黏膜改变主要是？

- A. 发绀 ✅
- B. 樱桃红
- C. 苍白
- D. 黄染
- E. 潮红

答案：A

> 解析：亚硝酸盐使血红蛋白氧化为高铁血红蛋白，失去携氧能力，组织缺氧出现发绀。教材P881。［源:考研真题 GS-2024-130］

74. [A1型题｜记忆] batch033-T1-A1-003

> 模块：M1｜页码：教材P876

理化因素所致疾病本篇论述以哪类发病为重点？

- A. 慢性蓄积发病
- B. 亚急性发病
- C. 急性发病 ✅
- D. 遗传性发病
- E. 先天性发病

答案：C

> 解析：本篇主要论述常见环境理化因素所致疾病，并以急性发病者为重点，因急性起病急、进展快、可致死且可逆。教材P876。

---

75. [A1型题｜记忆] batch033-T1-A1-004

> 模块：M1｜页码：教材P887

铅中毒时首选的解毒药物是？

- A. 依地酸钙钠 ✅
- B. 二巯丙醇
- C. 纳洛酮
- D. 亚甲蓝
- E. 氟马西尼

答案：A

> 解析：依地酸钙钠是最常用的氨羧螯合剂，与多种金属形成稳定可溶螯合物由尿排出，常用于铅中毒。教材P887。［源:考研真题 GS-2017-130］

---

76. [A1型题｜记忆] batch033-T1-A1-005

> 模块：M1｜页码：教材P876

物理因素中高温作用于人体主要引起？

- A. 冻僵
- B. 中暑 ✅
- C. 高原病
- D. 电击伤
- E. 放射病

答案：B

> 解析：高温作用于人体引体温调节失代偿，导致中暑或热射病，是物理因素中最常见的急性损害。教材P876。

---

77. [A1型题｜记忆] batch033-T1-A1-006

> 模块：M1｜页码：教材P876

下列物理因素与所致疾病的对应，正确的是？

- A. 低气压—冻伤
- B. 电流—高原病
- C. 高温—中暑 ✅
- D. 辐射—电击
- E. 低温—放射病

答案：C

> 解析：物理因素按能量形式归类：高温→中暑，低温→冻伤，低气压→高原病，电流→电击，辐射→放射病。教材P876。

---

78. [A1型题｜理解] batch033-T1-A1-007

> 模块：M1｜页码：教材P879

化学毒物吸收入血后生物转化（代谢）的主要器官是？

- A. 肾脏
- B. 肝脏 ✅
- C. 肺脏
- D. 脑
- E. 小肠

答案：B

> 解析：大多数毒物在肝内通过氧化、还原、水解和结合进行代谢，然后分布全身并由肾等排出。教材P879。

---

79. [A2型题｜理解] batch033-T1-A2-008

> 模块：M1｜页码：教材P879

关于化学因素所致疾病的致病特点，下列说法错误的是？

- A. 毒物经吸收后分布于靶器官
- B. 化学因素毒物多在肝代谢转化
- C. 化学因素以能量损伤为主 ✅
- D. 多数代谢后毒性降低
- E. 少数代谢后毒性增强

答案：C

> 解析：化学因素以毒物毒性损伤靶器官，物理因素才以能量损伤为主；如硫代类有机磷氧化后对硫磷毒性反而增强。教材P879。

---

80. [A1型题｜理解] batch033-T1-A1-009

> 模块：M1｜页码：教材P876

与慢性中毒相比，本篇将急性发病列为重点，主要因为急性发病？

- A. 在临床上更为常见

- B. 起病急进展快可致死且可逆 ✅
- C. 患者常无法治疗
- D. 必有明确接触史
- E. 缺乏特异性表现

答案：B

> 解析：急性中毒发病急、病情重、变化快，可危及生命，但及时清除毒物和解毒多可逆转，故列为重点。教材P876。

---

81. [A2型题｜应用] batch033-T1-A2-010

> 模块：M1｜页码：教材P881

男性，50岁。口服腐蚀性毒物后口腔黏膜出现黑色痂皮。最可能的灼伤毒物是？

- A. 硝酸灼伤
- B. 盐酸灼伤
- C. 硫酸灼伤 ✅
- D. 强碱灼伤
- E. 甲醛灼伤

答案：C

> 解析：腐蚀性毒物灼伤痂皮颜色有特征：硝酸呈黄色、盐酸呈棕色、硫酸呈黑色，有助于判断毒物。教材P881。

---

82. [A2型题｜理解] batch033-T1-A2-012

> 模块：M1｜页码：教材P878

理化因素所致疾病的诊断原则中，最关键是？

- A. 明确接触史 ✅
- B. 血常规检查
- C. 胸部X线
- D. 肿瘤标志物

- E. 基因检测

答案：A

> 解析：理化因素所致疾病病因明确，诊断须结合接触史、临床表现和实验室检查综合分析，接触史是首要线索。教材P878。

---

83. [A4型题｜分析] batch033-T1-A4-017

> 模块：M1｜页码：教材P878

男性，52岁。无明显诱因突发昏迷、发绀，同室2人亦有类似表现。首要考虑？

- A. 脑血管意外
- B. 一氧化碳中毒 ✅
- C. 有机磷中毒
- D. 糖尿病酮症
- E. 癫痫发作

答案：B

> 解析：同场所多人同时发病提示环境性理化因素，突发昏迷、发绀而无樱桃红外的特殊气味，最支持一氧化碳中毒，须结合环境调查。教材P878。

---

84. [X型题｜应用] batch033-T1-X-018

> 模块：M1｜页码：教材P876

下列致病因素中，属于物理因素的有？

- A. 高温 ✅
- B. 有机磷
- C. 低气压 ✅
- D. 电流 ✅
- E. 铅中毒

答案：ACD

> 解析：物理因素包括温度、气压、电流、辐射等能量形式；有机磷与铅属于化学因素（毒物）。教材P876。

---

85. [X型题｜应用] batch033-T1-X-020

> 模块：M1｜页码：教材P877

关于理化因素所致疾病防治原则，正确的有？

- A. 迅速脱离有害环境 ✅
- B. 稳定生命体征 ✅
- C. 针对病因和发病机制治疗 ✅
- D. 均须使用特效解毒药
- E. 对症支持治疗 ✅

答案：ABCE

> 解析：防治原则为脱离危害因素、稳定生命体征、针对病因机制治疗与对症支持；许多理化病无特效疗法，并非均须特效解毒药。教材P877。

M2（100题）

86. [A1型题｜记忆] batch033-D2-A1-001

> 模块：M2｜页码：教材P363

胃食管反流病(GERD)最典型的临床表现是

- A. 烧心与反流 ✅
- B. 进行性吞咽困难
- C. 胸骨后压榨样痛
- D. 反流相关的慢性咳嗽
- E. 体重明显下降

答案：A

> 解析：烧心(胸骨后烧灼感)与反流(含酸味)并存是GERD特异性极高的典型症状，餐后1小时、卧位加重。教材P363。

---

87. [A1型题｜记忆] batch033-D2-A1-002

> 模块：M2｜页码：教材P363

Barrett食管是下列哪种肿瘤的癌前病变

- A. 食管鳞癌
- B. 食管腺癌 ✅
- C. 胃窦腺癌
- D. 贲门癌
- E. 食管平滑肌瘤

答案：B

> 解析：Barrett食管为食管下段鳞状上皮被柱状上皮(含杯状细胞)替代，是食管腺癌主要癌前病变，风险较常人高10-20倍。教材P363。

---

88. [A1型题｜理解] batch033-D2-A1-003

> 模块：M2｜页码：教材P364

诊断反流性食管炎(RE)最准确的方法是

- A. PPI试验
- B. 胃镜(内镜) ✅
- C. 24h食管pH监测
- D. 食管压力测定
- E. 上消化道造影

答案：B

> 解析：内镜是诊断RE最准确的方法，并可作洛杉矶A-D分级；24h pH监测是诊断GERD(含NERD)功能金标准。教材P364。

89. [A1型题｜理解] batch033-D2-A1-004

> 模块：M2｜页码：教材P364

诊断胃食管反流病(GERD)的“金标准”是

- A. PPI试验
- B. 胃镜(内镜)
- C. 24h食管pH监测 ✅
- D. 胸部CT检查
- E. 食管压力测定

答案：C

> 解析：24小时食管pH监测(反流监测)是GERD功能诊断金标准；内镜最准的是RE而非全部GERD；PPI试验为拟诊敲门砖。教材P364。

---

90. [A1型题｜记忆] batch033-D2-A1-005

> 模块：M2｜页码：教材P365

GERD维持治疗疗效最确切的药物是

- A. 口服抗酸药物
- B. H2受体拮抗剂
- C. 质子泵抑制剂(PPI) ✅
- D. 促胃肠动力药
- E. 胃黏膜保护剂

答案：C

> 解析：PPI不可逆抑制壁细胞质子泵，抑酸最强最持久，为GERD急性与维持治疗首选，疗程4-8周。教材P364-365。

---

91. [A1型题｜理解] batch033-D2-A1-006

> 模块：M2｜页码：教材P363

关于GERD发病机制，正确的是

- A. 胃酸分泌过多是必要因素
- B. 抗反流屏障功能减弱是核心环节 ✅
- C. 食管清除能力增强
- D. 胃排空加快减少反流
- E. 食管黏膜屏障增厚

答案：B

> 解析：GERD核心是抗反流屏障异常(LES压降低、TLESR增多、裂孔疝)，胃酸分泌过多非必要机制；清除力下降、排空延迟促进反流。教材P363。

---

92. [A1型题｜记忆] batch033-D2-A1-007

> 模块：M2｜页码：教材P364

洛杉矶(LA)分级中，食管黏膜破损>5mm但未融合，属于

- A. A级
- B. B级 ✅
- C. C级
- D. D级
- E. 正常

答案：B

> 解析：LA分级：A<5mm；B>5mm未融合；C融合<75%周径；D融合≥75%周径。教材P364。

---

93. [A1型题｜理解] batch033-D2-A1-008

> 模块：M2｜页码：教材P364

典型烧心反流、内镜阴性，确诊非糜烂性反流病(NERD)需依赖

- A. PPI试验有效
- B. 胃镜见黏膜糜烂
- C. 24小时pH监测阳性 ✅
- D. 食管测压异常
- E. 钡餐未见异常

答案：C

> 解析：NERD需内镜阴性+客观反流证据(24h pH监测阳性)；仅PPI试验有效或症状不能单独确诊NERD。教材P364。

---

94. [A2型题｜应用] batch033-D2-A2-009

> 模块：M2｜页码：教材P363

女性,40岁。餐后1小时胸骨后烧灼感、反酸2个月，平卧时加重。最可能的诊断是

- A. 心绞痛
- B. 胃食管反流病 ✅
- C. 食管癌
- D. 慢性胃炎
- E. 慢性胆囊炎

答案：B

> 解析：餐后1小时胸骨后烧灼+反酸、体位相关，为GERD典型症状；心绞痛与劳累相关且含硝酸甘油缓解。教材P363。

---

95. [A2型题｜应用] batch033-D2-A2-010

> 模块：M2｜页码：教材P364

男性,50岁。典型烧心反流，胃镜未见黏膜糜烂。为确诊非糜烂性反流病(NERD)，还需

- A. PPI试验有效即可
- B. 胃镜见黏膜糜烂
- C. 24小时pH监测阳性 ✅

- D. 食管测压异常
- E. 钡餐未见异常

答案：C

> 解析：NERD诊断需内镜阴性+24h pH监测阳性证实病理性反流；单纯PPI有效或症状不能确诊。教材P364。

---

96. [A2型题｜应用] batch033-D2-A2-011

> 模块：M2｜页码：教材P363

男性,55岁。GERD病史10年，内镜见食管下段橘红色柱状上皮。恰当的处理是

- A. 按慢性胃炎治疗
- B. Barrett食管需随访 ✅
- C. 立即行外科手术
- D. 按结核方案治疗
- E. 按食管癌方案化疗

答案：B

> 解析：食管下段鳞变柱(Barrett)为腺癌癌前，需定期内镜随访；重度异型增生才考虑内镜/手术。教材P363。

---

97. [A2型题｜理解] batch033-D2-A2-012

> 模块：M2｜页码：教材P363

男性,45岁。胸骨后烧灼痛，与进食、卧位相关，抗酸药可缓解，心电图正常。应首先排除的是

- A. 急性冠脉综合征 ✅
- B. 胃食管反流病
- C. 肺血栓栓塞
- D. 肋间神经痛
- E. 主动脉夹层

答案：A

> 解析：非心源性胸痛需先排除心脏疾病(心电图/心肌酶)再评估GERD，避免漏诊急性冠脉综合征。教材P363。

---

98. [A2型题｜应用] batch033-D2-A2-013

> 模块：M2｜页码：教材P365

女性,38岁。确诊GERD，无严重并发症。初始治疗应首选

- A. 长期单用抗酸药
- B. PPI 4-8周 ✅
- C. 抗反流手术
- D. 单用促动力药
- E. 中药灌肠

答案：B

> 解析：PPI抑酸最强，为GERD首选与维持治疗，疗程4-8周；手术仅用于顽固或并发症者。教材P364-365。

---

99. [A2型题｜理解] batch033-D2-A2-014

> 模块：M2｜页码：教材P363

男性,60岁。反复慢性咳嗽、声嘶，伴烧心反流体征。应首先考虑

- A. 支气管哮喘
- B. GERD食管外表现 ✅
- C. 中心型肺癌
- D. 特发性咽喉炎
- E. 活动性肺结核

答案：B

> 解析：慢性咳嗽、咽喉炎、声嘶等食管外症状，若反复发作伴烧心反流，应考虑GERD；需先排除心肺疾病。教材P363。

---

100. [A3型题｜应用] batch033-D2-A3-015

> 模块：M2｜页码：教材P364

男性,48岁。烧心1年，抑酸药有效但停药复发，检查见食管下段黏膜纵行糜烂。为明确其分级，最准确的方法是

- A. PPI试验
- B. 胃镜(内镜) ✅
- C. 24小时pH监测
- D. 食管压力测定
- E. 上消化道造影

答案：B

> 解析：内镜是诊断RE并作洛杉矶分级最准确的方法；pH监测用于证实反流而非评估黏膜破损程度。教材P364。

---

101. [A4型题｜分析] batch033-D2-A4-016

> 模块：M2｜页码：教材P363

女性,52岁。长期反流，胃镜诊断Barrett食管，活检示重度异型增生。下一步处理应首选

- A. 继续观察随访
- B. 内镜下切除或手术 ✅
- C. 加大PPI剂量
- D. 放射线治疗
- E. 化学药物治疗

答案：B

> 解析：Barrett伴重度异型增生属高度癌变风险，应内镜下切除或手术；轻度异型增生才以随访为主。教材P363。

102. [B1型题｜记忆] batch033-D2-B1-017

> 模块：M2｜页码：教材P365

GERD首选及长期维持治疗疗效最确切的药物是

- A. 口服抗酸药物
- B. H2受体拮抗剂
- C. 质子泵抑制剂(PPI) ✅
- D. 促胃肠动力药
- E. 胃黏膜保护剂

答案：C

> 解析：PPI抑制质子泵抑酸最强最久，为GERD首选与维持治疗；H2RA适于轻中症，促动力药辅助。教材P364-365。

---

103. [B1型题｜记忆] batch033-D2-B1-018

> 模块：M2｜页码：教材P364

洛杉矶(LA)分级中，黏膜破损<5mm者属于

- A. A级 ✅
- B. B级
- C. C级
- D. D级
- E. 正常

答案：A

> 解析：LA A级：黏膜破损<5mm；B级>5mm未融合；C级融合<75%周径；D级≥75%。教材P364。

---

104. [X型题｜理解] batch033-D2-X-019

> 模块：M2｜页码：教材P363

胃食管反流病发病相关的因素包括

- A. 下食管括约肌压力降低 ✅
- B. 一过性LES松弛增多 ✅
- C. 食管裂孔疝形成 ✅
- D. 食管清除能力下降 ✅
- E. 胃酸分泌增多

答案：ABCD

> 解析：GERD三环：LES压降低/TLESR增多/裂孔疝(阀松)、清除力下降(清不掉)、胃排空延迟(推上来)；胃酸分泌过多非必要机制。教材P363。

---

105. [X型题 | 理解] batch033-D2-X-020

> 模块：M2 | 页码：教材P363

关于Barrett食管，正确的有

- A. 鳞状上皮被柱状上皮替代 ✅
- B. 是食管腺癌的癌前病变 ✅
- C. 伴重度异型增生需内镜或手术 ✅
- D. 与长期酸/胆汁反流有关 ✅
- E. 癌变风险与正常人相近

答案：ABCD

> 解析：Barrett为反流反复损伤后鳞状上皮被耐酸柱状上皮替代，是食管腺癌癌前，重度异型增生需干预；风险高于常人10-20倍。教材P363。

---

106. [A1型题 | 记忆] batch033-R2-A1-001

> 模块：M2 | 页码：教材P480

诊断肾病综合征必须具备的条件是

- A. 大量蛋白尿与低白蛋白血症 ✅

- B. 水肿（常见非必备）
- C. 高脂血症（常见非必备）
- D. 高血压（常见非必备）
- E. 血尿（常见非必备）

答案：A

> 解析：肾病综合征诊断必备：①大量蛋白尿>3.5g/d；②低白蛋白血症<30g/L；水肿与高脂血症为常见但非必备。教材P480。

---

107. [A1型题 | 记忆] batch033-R2-A1-002

> 模块：M2 | 页码：教材P480

儿童原发性肾病综合征最常见的病理类型是

- A. 膜性肾病（MN）
- B. 微小病变型肾病 ✅
- C. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. IgA肾病（IgA）

答案：B

> 解析：儿童原发性肾病综合征最常见病理类型为微小病变型肾病（脂性肾病），对糖皮质激素敏感。教材P480。

---

108. [A1型题 | 记忆] batch033-R2-A1-003

> 模块：M2 | 页码：教材P482

膜性肾病患者并发肾静脉血栓的发生率约为

- A. 5%~10%
- B. 20%~30%
- C. 40%~50% ✅
- D. 60%~70%

- E. 80%~90%

答案：C

> 解析：膜性肾病易高凝，肾静脉血栓发生率约40%~50%，是中老年继发性血栓的重点病理类型。教材P482-483。

---

109. [A1型题 | 记忆] batch033-R2-A1-004

> 模块：M2 | 页码：教材P485

肾病综合征患者使用糖皮质激素后，在多长时间内缓解可称为激素敏感型

- A. 2~4周
- B. 4~6周
- C. 8~12周 ✅
- D. 16~20周
- E. 24周以上

答案：C

> 解析：激素敏感型指8~12周（足量）内蛋白尿缓解；减量即复发为依赖型，常规治疗无效为抵抗型。教材P485。

---

110. [A1型题 | 记忆] batch033-R2-A1-005

> 模块：M2 | 页码：教材P483

肾病综合征最常见的并发症是

- A. 并发血栓栓塞
- B. 急性肾损伤
- C. 代谢紊乱
- D. 并发各种感染 ✅
- E. 急性肾衰竭

答案：D

> 解析：感染是肾病综合征最常见并发症（免疫球蛋白经尿丢失、免疫力低下），部位依次为呼吸道、泌尿道、皮肤。教材P483。

---

111. [A1型题｜记忆] batch033-R2-A1-006

> 模块：M2｜页码：教材P483

肾病综合征并发肾静脉血栓最多见于下列哪种病理类型

- A. 微小病变型肾病
- B. 系膜增生性肾小球肾炎
- C. 局灶节段性肾病
- D. 系膜毛细血管性肾病
- E. 膜性肾病（MN） ✅

答案：E

> 解析：膜性肾病高凝显著，肾静脉血栓发生率最高（40%~50%）；微小病变型虽病理轻却最多并发急性肾损伤。教材P483。

---

112. [A1型题｜理解] batch033-R2-A1-007

> 模块：M2｜页码：教材P480

男性，水肿、大量蛋白尿。为确诊肾病综合征，血清白蛋白应低于

- A. 30g/L ✅
- B. 60g/L
- C. 45g/L
- D. 20g/L
- E. 15g/L

答案：A

> 解析：低白蛋白血症诊断阈值为血清白蛋白<30g/L（伴大量蛋白尿>3.5g/d）为肾病综合征必备条件。教材P480。

113. [A1型题 | 理解] batch033-R2-A1-008

> 模块：M2 | 页码：教材P480

青年男性，尿蛋白(+++)，水肿。最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 肾病综合征 ✅
- C. 急进性肾小球肾炎
- D. 慢性肾炎急性发作
- E. IgA肾病（IgA）

答案：B

> 解析：①青年男性，尿蛋白(+++)，尿蛋白定量>3.5g/d，水肿，最可能的诊断是肾病综合征。急性肾小球肾炎、急进性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎急性发作均可出现蛋白尿，但一般为(+)~(++)，故不答A、C、D。[源:考研真题 GS-2024-082]

---

114. [A2型题 | 理解] batch033-R2-A2-009

> 模块：M2 | 页码：教材P483

男性，55岁，因肾病综合征(病理为膜性肾病)入院治疗，在应用利尿剂和糖皮质激素的治疗过程中突然持续性腰痛，尿量减少，下肢浮肿加重，蛋白尿显著增多伴肉眼血尿，血肌酐较前增高，B超示双肾较前增大。最可能的原因是

- A. 原有肾病加重
- B. 伴发泌尿系统感染
- C. 伴发泌尿系统肿瘤
- D. 肾静脉血栓形成 ✅
- E. 泌尿系结石

答案：D

> 解析：①肾病综合征(尤其膜性肾病)极易发生血栓、栓塞并发症，其中以肾静脉栓塞最常见。肾静脉血栓形成常表现为突发腰痛、血尿、尿蛋白增加、肾功能减退、肾脏增大。根据题干，本例应诊断为肾静脉血栓形成。②A、C、D均不是肾病综合征的常见并发症，且与题干所述临床表现不符。[源:考研真题 GS-2007-084]

115. [A2型题｜理解] batch033-R2-A2-010

> 模块：M2丨页码：教材P482

中老年男性，水肿、大量蛋白尿，B超发现肾静脉血栓。最可能的诊断是

- A. 微小病变型肾病
- B. IgA肾病（IgA）
- C. 系膜毛细血管性肾病
- D. 肾淀粉样变性
- E. 膜性肾病（MN） ✅

答案：E

> 解析：中老年肾病综合征最常见病理为膜性肾病，且极易并发肾静脉血栓（40%~50%）；结合肾静脉血栓，最支持膜性肾病。教材P482-483。

---

116. [A2型题｜理解] batch033-R2-A2-011

> 模块：M2丨页码：教材P485

肾病综合征患者口服泼尼松治疗，起始足量的推荐疗程一般为

- A. 8周可延至12周 ✅
- B. 约2周疗程
- C. 约4周疗程
- D. 约16周疗程
- E. 约24周疗程

答案：A

> 解析：糖皮质激素治疗分三阶段：起始足量口服8周（可延至12周）、缓慢减量、最小有效剂量维持半年。教材P485。

---

117. [A2型题｜应用] batch033-R2-A2-012

> 模块：M2｜页码：教材P483

肾病综合征患者，血清白蛋白降至18g/L，无明显出血。此时最重要的预防措施是

- A. 强效利尿治疗
- B. 预防性抗凝 ✅
- C. 静脉输注白蛋白
- D. 广谱抗生素预防感染
- E. 立即透析治疗

答案：B

> 解析：血浆白蛋白<20g/L提示高凝状态，应开始预防性抗凝；利尿不宜过快过猛以免血容量不足加重高凝。教材P483。

---

118. [A2型题｜应用] batch033-R2-A2-013

> 模块：M2｜页码：教材P484

关于膜性肾病的治疗，下列说法恰当的是

- A. 单用糖皮质激素有效
- B. 无需特殊治疗
- C. 糖皮质激素联合烷化剂 ✅
- D. 首选利尿剂治疗
- E. 仅限饮食控制

答案：C

> 解析：膜性肾病单用激素无效，需激素联合烷化剂（如环磷酰胺）；ACEI/ARB减少尿蛋白，必要时用钙调磷酸酶抑制剂。教材P484-485。

---

119. [A2型题｜应用] batch033-R2-A2-014

> 模块：M2｜页码：教材P481

儿童肾病综合征，病理为微小病变型，对下列哪种治疗最敏感

- A. 抗生素
- B. 利尿剂
- C. 降压药物
- D. 糖皮质激素 ✅
- E. 抗凝药物

答案：D

> 解析：微小病变型肾病光镜下基本正常、仅足突融合，对糖皮质激素极敏感，儿童约90%有效，初治可单用。教材P481。

---

120. [A3型题 | 分析] batch033-R2-A3-015

> 模块：M2 | 页码：教材P483

男性，50岁，水肿、大量蛋白尿2个月，诊断为肾病综合征（膜性肾病）。治疗中突发持续性腰痛、尿量减少、蛋白尿显著增多伴肉眼血尿，血肌酐升高，B超双肾增大。该表现最可能提示

- A. 原有肾病加重
- B. 泌尿系感染
- C. 泌尿系肿瘤
- D. 急性肾炎
- E. 肾静脉血栓形成 ✅

答案：E

> 解析：膜性肾病极易并发肾静脉血栓，突发腰痛、血尿、尿蛋白增加、肾功能减退、肾脏增大是典型表现。教材P483。

---

121. [A4型题 | 应用] batch033-R2-A4-016

> 模块：M2 | 页码：教材P480

老年女性，新发肾病综合征，伴多发骨痛、贫血、血钙降低。为明确继发性病因，首先应考虑的检查是

- A. 骨髓穿刺与血清蛋白电泳 ✅
- B. 血糖与糖化血红蛋白
- C. 检测抗核抗体
- D. 行肾脏B超检查
- E. 行尿培养检查

答案：A

> 解析：中老年新发肾病综合征须警惕继发因素；骨痛、贫血、低钙提示多发性骨髓瘤或淀粉样变，应行骨髓穿刺与血清蛋白电泳。教材P480。

---

122. [B1型题｜理解] batch033-R2-B1-017

> 模块：M2｜页码：教材P480

儿童肾病综合征最常见的病理类型是

- A. 膜性肾病（MN）
- B. 微小病变型肾病 ✅
- C. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. IgA肾病（IgA）

答案：B

> 解析：儿童原发性肾病综合征最常见为微小病变型肾病。教材P480。

---

123. [B1型题｜理解] batch033-R2-B1-018

> 模块：M2｜页码：教材P482

中老年肾病综合征最常见、且易并发肾静脉血栓的病理类型是

- A. 微小病变型肾病

- B. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
- C. 膜性肾病（MN） ✅
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. IgA肾病（IgA）

答案：C

> 解析：膜性肾病多见于中老年，PLA2R抗体阳性，肾静脉血栓发生率40%~50%。教材P482-483。

---

124. [X型题｜理解] batch033-R2-X-019

> 模块：M2｜页码：教材P480

可表现为肾病综合征的肾小球疾病有

- A. 微小病变型肾病 ✅
- B. 膜性肾病（MN） ✅
- C. 狼疮肾炎（LN） ✅
- D. 链球菌感染后急性肾小球肾炎
- E. 急性肾盂肾炎（上尿路）

答案：ABC

> 解析：①微小病变型肾病、膜性肾病是原发性肾病综合征的常见病因。狼疮肾炎是继发性肾病综合征的常见病因。②链球菌感染后急性肾小球肾炎常引起急性肾炎综合征，而不是肾病综合征；急性肾盂肾炎属感染、不表现为肾病综合征。[源:考研真题 GS-2024-157]

---

125. [X型题｜应用] batch033-R2-X-020

> 模块：M2｜页码：教材P480

下列属于中老年人继发性肾病综合征常见病因的有

- A. 糖尿病性肾病 ✅
- B. 肾淀粉样变性 ✅
- C. 过敏性紫癜肾炎

- D. 系统性红斑狼疮肾炎
- E. 乙型肝炎病毒相关性肾炎

答案：AB

> 解析：①中老年人继发性肾病综合征常见病因包括糖尿病肾病、肾淀粉样变性、骨髓瘤性肾病、淋巴瘤性肾病、实体肿瘤性肾病等。②过敏性紫癜肾炎、系统性红斑狼疮肾炎均属于儿童、青少年继发性肾病综合征的病因；乙型肝炎病毒相关性肾炎多见于儿童青少年。[源:考研真题 GS-2016-172]

---

126. [A1型题 | 记忆] batch033-E2-A1-001

> 模块：M2 | 页码：教材P686

Graves病最常见的病因相关自身抗体是？

- A. TSAb
- B. TBAb
- C. TBIAb ✅
- D. TPOAb
- E. TgAb

答案：C

> 解析：Graves病由TSAb持续刺激TSH受体（TSHR）引起，不受负反馈约束，是致病抗体；TBAb阻断、TBIAb中性；TPOAb/TgAb多见于桥本甲状腺炎。教材P686。

---

127. [A1型题 | 记忆] batch033-E2-A1-002

> 模块：M2 | 页码：教材P691

抗甲状腺药物（ATD）治疗一般首选的是？

- A. 甲巯咪唑（MMI）
- B. 丙硫氧嘧啶（PTU）
- C. 卢戈碘液的情况
- D. 普萘洛尔的情况 ✅

- E. 糖皮质激素的状态

答案：D

> 解析：MMI肝毒性小、半衰期长、每日一次，一般作为ATD首选；PTU仅用于妊娠早期、甲状腺危象、MMI反应差者。教材P691。

---

128. [A1型题｜理解] batch033-E2-A1-003

> 模块：M2｜页码：教材P690

诊断Graves病的一线指标、并用于指导停药与判断复发的是？

- A. TRAb
- B. TPOAb
- C. TgAb
- D. 甲状腺超声
- E. 甲状腺摄碘率 ✅

答案：E

> 解析：TRAb（含TSAb）是Graves病一线指标，阳性率80%-100%；治疗中监测TRAb判断缓解，停药前TRAb转阴是必要条件之一，升高提示复发风险大。教材P690。

---

129. [A1型题｜记忆] batch033-E2-A1-004

> 模块：M2｜页码：教材P690

未经治疗的Graves病患者，TRAb阳性率约为？

- A. 80%-100% ✅
- B. 50%-60%
- C. 30%-50%
- D. 10%-20%
- E. 低于5%的情况

答案：A

> 解析：未经治疗的Graves病患者TRAb阳性率高达80%-100%，故TRAb阳性几乎可锁定Graves病；其余区间为其他自身免疫甲状腺病或正常范围。教材P690。

---

130. [A1型题｜理解] batch033-E2-A1-005

> 模块：M2｜页码：教材P691

甲状腺危象治疗中，首选用于“断合成”（抑制激素合成并抑制T4向T3转换）的药物是？

- A. 大剂量丙硫氧嘧啶
- B. 卢戈碘液的情况
- C. 普萘洛尔的情况 ✅
- D. 糖皮质激素的状态
- E. 阿司匹林的情况

答案：C

> 解析：甲状腺危象用药次序：先大剂量PTU抑制合成并抑制T4→T3（起效快），1-2h后加碘抑制释放，再用普萘洛尔/糖皮质激素阻断转换与抗交感。教材P691。

---

131. [A1型题｜理解] batch033-E2-A1-006

> 模块：M2｜页码：教材P691

甲亢患者服ATD后出现发热、咽痛，查WBC 2.8×10^9/L（低于3×10^9/L），应首先？

- A. 增加ATD剂量的状态
- B. 立即停用ATD并升白细胞治疗 ✅
- C. 改用PTU的状态
- D. 加用碘剂的情况
- E. 仅密切观察的状态

答案：B

> 解析：ATD最常见不良反应为粒细胞减少，WBC<3×10^9/L或中性粒细胞<1.5×10^9/L应停药并升白细胞；两类ATD粒细胞减少有交叉反应，不能互换。教材P691。

132. [A1型题｜记忆] batch033-E2-A1-007

> 模块：M2｜页码：教材P692

放射性碘（^{131}I）治疗的禁忌证是？

- A. 妊娠期
- B. 老年甲亢
- C. ATD失败
- D. 白细胞减少 ✅
- E. 合并房颤

答案：D

> 解析：^{131}I禁忌：妊娠期、哺乳期、确诊或可疑甲状腺癌；中重度活动期Graves眼病慎用。老年、ATD失败、白细胞减少、房颤均为^{131}I适应证。教材P692。

---

133. [A1型题｜理解] batch033-E2-A1-008

> 模块：M2｜页码：教材P686

关于甲状腺毒症与甲亢的关系，正确的是？

- A. 甲状腺毒症包含甲亢与非甲亢毒症
- B. 甲状腺毒症等同于甲亢的状态
- C. 亚急性甲状腺炎属于甲亢的状态
- D. 外源甲状腺素过量属甲亢的状态
- E. 二者完全无区别的状态 ✅

答案：E

> 解析：甲状腺毒症是血甲状腺激素过多的统称，分甲亢（甲状腺自身合成过多）与非甲亢性（如亚甲炎漏出、外源甲状腺素）；亚甲炎摄碘率降低，不用ATD。教材P686。

---

134. [A2型题｜应用] batch033-E2-A2-009

> 模块：M2｜页码：教材P686

25岁女性，怕热、心悸、突眼，甲状腺弥漫性肿大伴血管杂音，TSH降低、FT4升高、TRAb阳性。最可能的诊断是？

- A. Graves病 ✅
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 亚急性甲状腺炎
- D. 桥本甲状腺炎
- E. 垂体TSH瘤

答案：A

> 解析：年轻女性、突眼、弥漫性肿大杂音、TSH↓FT4↑、TRAb阳性，符合Graves病（甲亢最常见原因，占80%以上）。教材P686。

---

135. [A2型题｜理解] batch033-E2-A2-010

> 模块：M2｜页码：教材P686

30岁女性，上呼吸道感染后颈前疼痛、发热，查TSH降低、FT4升高，甲状腺摄碘率降低。最可能的诊断是？

- A. Graves病（典型甲亢）的状态
- B. 亚急性甲状腺炎（非甲亢性毒症） ✅
- C. 毒性结节性甲状腺肿的状态
- D. 垂体性甲亢（反馈失灵）的状态
- E. 正常生理变异的情况

答案：B

> 解析：亚甲炎为滤泡破坏致激素漏出入血，属非甲亢性甲状腺毒症，摄碘率降低，不宜用ATD而应对症/抗炎；与甲亢（摄碘率升高）鉴别。教材P686。

---

136. [A2型题｜应用] batch033-E2-A2-011

> 模块：M2｜页码：教材P691

28岁孕妇，孕8周，原有Graves病、近期甲亢加重，宜选用的抗甲状腺药物是？

- A. 甲巯咪唑
- B. 丙硫氧嘧啶 ✅
- C. ^{131}I
- D. 手术的情况
- E. 观察不用药

答案：B

> 解析：妊娠早期（前3月）为减少致畸风险，ATD首选PTU而非MMI；^{131}I与手术在孕期属禁忌/慎用。教材P691。

---

137. [A2型题｜应用] batch033-E2-A2-012

> 模块：M2｜页码：教材P691

甲亢患者服MMI 2个月出现发热、咽痛，WBC $2.8\times10^9/L$，处理应为？

- A. 继续原量MMI的状态
- B. 停用MMI并升白细胞治疗 ✅
- C. 改为PTU的状态
- D. 加用碘剂的情况
- E. 加用β阻滞剂的状态

答案：B

> 解析：发热咽痛+WBC<$3\times10^9/L$提示ATD致粒细胞减少，应立即停药并升白细胞；两类ATD有交叉反应，不能简单换PTU。教材P691。

---

138. [A2型题｜理解] batch033-E2-A2-013

> 模块：M2｜页码：教材P687

Graves病突眼（眼病）的发生机制主要与？

- A. TSHR与IGF-1受体共享信号
- B. 甲状腺激素直接毒性作用的状态
- C. 碘摄入过量的状态 ✅
- D. 垂体肿瘤压迫视神经的状态
- E. 严重低血糖反应的情况

答案：C

> 解析：眶后成纤维细胞表达TSHR，被TSAb刺激，且TSHR与IGF-1受体共享信号通路，导致眶后淋巴细胞浸润、脂肪水肿、突眼；故甲功正常也可突眼。教材P687。

---

139. [A2型题｜应用] batch033-E2-A2-014

> 模块：M2｜页码：教材P692

老年男性，Graves病合并房颤、白细胞减少，ATD疗效欠佳，最适宜的治疗是？

- A. 放射性碘（^{131}I）
- B. 甲巯咪唑增量的状态
- C. 观察的情况
- D. 单用β阻滞剂的状态 ✅
- E. 仅补碘的情况

答案：D

> 解析：^{131}I适应证包括老年、合并房颤、白细胞减少、ATD失败/不良反应；治愈率高且无菌无创。妊娠、哺乳、甲状腺癌为禁忌。教材P692。

---

140. [A3型题｜应用] batch033-E2-A3-015

> 模块：M2｜页码：教材P690

35岁女性，Graves病规律服MMI一年半，甲功已正常，但复查TRAb仍阳性。此时若停药，最需告知患者的是？

- A. 复发风险较高 ✅

- B. 已经临床治愈
- C. 将发生甲减
- D. 将癌变的情况
- E. 无需随访的情况

答案：A

> 解析：TRAb是病根抗体，停药前要求足疗程+TRAb转阴；TRAb仍阳性者停药后抗体再刺激甲状腺，复发风险大，需密切随访。教材P690。

---

141. [A4型题 | 分析] batch033-E2-A4-016

> 模块：M2 | 页码：教材P691

40岁女性，Graves病因感染诱发高热39.5℃、心率150次/分、烦躁、腹泻，诊断甲状腺危象。首要的处理措施是？

- A. 大剂量PTU抑制合成及T4→T3 ✅
- B. 立即给予卢戈碘液的情况
- C. 单用普萘洛尔阻滞的状态
- D. 单用糖皮质激素的情况
- E. 仅物理降温对症的状态

答案：A

> 解析：危象用药次序为断合成→断释放→断转换：先大剂量PTU（抑制合成并抑制T4→T3），1-2h后加碘抑制释放，再普萘洛尔/糖皮质激素；单用后序步骤或仅对症均不到位。教材P691。

---

142. [B1型题 | 记忆] batch033-E2-B1-017

> 模块：M2 | 页码：教材P691

一般甲亢初始治疗首选的抗甲状腺药物是？

- A. 甲巯咪唑（MMI） ✅
- B. 丙硫氧嘧啶（PTU）

- C. 卢戈碘液的情况
- D. 普萘洛尔的情况
- E. 糖皮质激素的状态

答案：A

> 解析：MMI肝毒性小、半衰期长、每日一次，作为一般首选；PTU仅用于妊娠早期、危象、MMI反应差。教材P691。

---

143. [B1型题｜记忆] batch033-E2-B1-018

> 模块：M2｜页码：教材P691

甲状腺危象“断转换”步骤中，用于阻断T4向T3转换并抗交感的是？

- A. 甲巯咪唑（MMI）
- B. 丙硫氧嘧啶（PTU）
- C. 卢戈碘液的情况
- D. 普萘洛尔的情况 ✅
- E. 糖皮质激素的状态

答案：D

> 解析：危象次序：PTU断合成→碘断释放→普萘洛尔断转换（阻断T4→T3并抗交感）→糖皮质激素；普萘洛尔在“断转换”环节使用。教材P691。

---

144. [X型题｜理解] batch033-E2-X-019

> 模块：M2｜页码：教材P686

关于TRAb三型及其意义，正确的有？

- A. TSAb刺激TSHR致甲亢 ✅
- B. TBAb阻断TSHR致甲减 ✅
- C. TBIAb结合TSHR但无功能 ✅
- D. TRAb阳性率可达80%-100% ✅
- E. Graves病均由TBAb主导

答案：ABCD

> 解析：TRAb含三型：TSAb刺激TSHR（致病、亢进），TBAb阻断（减退），TBIAb结合无功能（中性）；未经治疗Graves阳性率80%-100%，TSAb占优势才致亢进。教材P686-687、P690。

---

145. [X型题｜理解] batch033-E2-X-020

> 模块：M2｜页码：教材P686

下列疾病中，基础代谢率呈升高趋势的有

- A. 急性白血病的状态 ✅
- B. 甲状腺功能亢进症 ✅
- C. 真性红细胞增多症 ✅
- D. 糖尿病的情况 ✅

答案：ABCD

> 解析：基础代谢率是指在基础状态下单位时间内的能量代谢。基础代谢率除受性别、年龄及月经周期的影响外，还受下列因素的影响：①基础代谢率升高见于甲亢、体温升高、糖尿病、红细胞增多症、白血病、伴有呼吸困难的心脏病。②基础代谢率降低见于甲减、肾上腺皮质功能低下、垂体功能低下、肾病综合征、病理性饥饿。［源:考研真题 GS-2014-154］

---

146. [A1型题｜记忆] batch033-S2-A1-001

> 模块：M2｜页码：教材P814

类风湿关节炎最基本的病理改变是

- A. 滑膜炎与血管翳 ✅
- B. 软骨退行性变
- C. 软骨退行性病变
- D. 痛风石沉积
- E. 免疫球蛋白沉积

答案：A

> 解析：RA基本病理为滑膜慢性炎症+血管翳形成，最终导致关节软骨和骨破坏、畸形；不同于骨关节炎的退变或痛风的结晶沉积。教材P814。

---

147. [A1型题｜记忆] batch033-S2-A1-002

> 模块：M2｜页码：教材P815

类风湿关节炎患者晨僵的典型特点是

- A. 持续不足半小时
- B. 常超过1小时 ✅
- C. 仅见于晚期患者
- D. 与活动无关
- E. 以夜间痛为主

答案：B

> 解析：晨僵见于约95% RA患者，为活动性指标，通常持续1小时以上；骨关节炎晨僵短暂。教材P815。

---

148. [A1型题｜记忆] batch033-S2-A1-003

> 模块：M2｜页码：教材P816

对类风湿关节炎诊断特异性最高（约93%~98%）的自身抗体是

- A. 抗核抗体ANA
- B. 抗dsDNA
- C. 抗CCP抗体 ✅
- D. 抗Sm抗体
- E. 抗SSA抗体

答案：C

> 解析：抗CCP抗体对RA特异度93%~98%，高于RF（约86%），有助早期诊断；其余为SLE相关抗体。教材P816。

149. [A1型题｜记忆] batch033-S2-A1-004

> 模块：M2｜页码：教材P818

类风湿关节炎确诊后，控制病情、延缓骨破坏的首选改变病情抗风湿药是

- A. 布洛芬
- B. 泼尼松
- C. 秋水仙碱
- D. 甲氨蝶呤 ✅
- E. 双氯芬酸

答案：D

> 解析：RA一经确诊应尽早用传统DMARDs，首选甲氨蝶呤，起效1~3月、可延缓病情、防结构破坏；NSAIDs与激素仅缓解症状。教材P818。

---

150. [A1型题｜记忆] batch033-S2-A1-005

> 模块：M2｜页码：教材P816

类风湿关节炎X线分期中，表现为关节间隙变窄的是

- A. Ⅰ期软组织肿胀
- B. Ⅲ期虫蚀样改变
- C. Ⅳ期半脱位强直
- D. 0期无关节间隙变窄
- E. Ⅱ期关节间隙变窄 ✅

答案：E

> 解析：RA X线Ⅰ期软组织肿胀/骨疏松，Ⅱ期关节间隙变窄，Ⅲ期虫蚀样改变，Ⅳ期半脱位/强直。教材P816。

---

151. [A1型题 | 理解] batch033-S2-A1-006

> 模块：M2 | 页码：教材P814

首发最常累及近端指间关节、掌指关节和腕关节的风湿性疾病是

- A. 类风湿关节炎 ✅
- B. 骨性关节风湿
- C. 强直性脊柱炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 痛风性关节炎

答案：A

> 解析：RA最常累及腕、掌指、近端指间关节；骨关节炎累及负重关节，AS侵犯中轴，SLE累及指腕膝。[源:考研真题 GS-2016-075]。教材P814-815。

---

152. [A1型题 | 理解] batch033-S2-A1-007

> 模块：M2 | 页码：教材P816

有助于类风湿关节炎早期诊断的抗角蛋白抗体谱，下列属于该谱的抗体是

- A. 抗核抗体ANA
- B. 抗核周因子抗体 ✅
- C. 抗RNP抗体
- D. 抗组织细胞抗体
- E. 抗dsDNA抗体

答案：B

> 解析：抗角蛋白抗体谱包括抗核周因子抗体、抗角蛋白抗体、抗聚角蛋白微丝蛋白抗体、抗CCP抗体；ANA/抗RNP/抗dsDNA均不属此谱。[源:考研真题 GS-2008-076]。教材P816。

---

153. [A1型题 | 理解] batch033-S2-A1-008

> 模块：M2 | 页码：教材P816

类风湿关节炎较具特异性的自身抗体，其靶抗原是变性IgG的Fc片段，该抗体是

- A. 抗核抗体ANA
- B. 抗dsDNA
- C. 类风湿因子RF ✅
- D. 抗Sm抗体
- E. 抗CCP（类风湿）

答案：C

> 解析：RF是针对IgG Fc片段的自身抗体，约80% RA阳性，是RA较具特异性的自身抗体；抗dsDNA/抗Sm用于SLE，抗CCP特异更高但此题对应IgG Fc片段即为RF。[源:考研真题 GS-2006-049]。教材P810、P816。

---

154. [A2型题｜理解] batch033-S2-A2-009

> 模块：M2｜页码：教材P817

女性，45岁，双手近端指间关节、掌指关节对称性肿痛8个月，晨僵约1.5小时，RF阳性、抗CCP阳性。最可能的诊断是

- A. 骨性关节炎
- B. 痛风性关节炎
- C. 强直性脊柱炎
- D. 类风湿关节炎 ✅
- E. 系统性红斑狼疮

答案：D

> 解析：中年女性+对称性小关节肿痛+晨僵>1h+RF/抗CCP阳性，符合RA；骨关节炎大关节、无晨僵>1h，痛风单关节红肿，AS中轴，SLE多无骨破坏。教材P814-817。

---

155. [A2型题｜理解] batch033-S2-A2-010

> 模块：M2｜页码：教材P814

类风湿关节炎中，由增生滑膜长入软骨面、释放基质金属蛋白酶导致骨破坏的关键结构是

- A. 关节滑膜积液
- B. 软骨下囊肿
- C. 骨赘增生形成
- D. 纤维粘连
- E. 增生血管翳 ✅

答案：E

> 解析：血管翳是增生滑膜长入软骨面，释放溶酶体酶、MMP、TNF-α、IL-6，直接降解软骨与骨质，是RA骨破坏的关键。教材P814。

---

156. [A2型题｜理解] batch033-S2-A2-011

> 模块：M2｜页码：教材P816

类风湿关节炎患者肘部皮下出现质硬、无压痛的结节，提示

- A. 提示病情活动 ✅
- B. 提示病情缓解
- C. 提示合并感染
- D. 提示药物过敏
- E. 提示骨质疏松

答案：A

> 解析：类风湿结节是最常见关节外表现（约30%~40%），出现提示病情活动。教材P816。

---

157. [A2型题｜应用] batch033-S2-A2-012

> 模块：M2｜页码：教材P818

类风湿关节炎患者使用甲氨蝶呤治疗期间，为减轻不良反应应补充

- A. 补充维生素C
- B. 补充叶酸 ✅
- C. 补充钙剂
- D. 补充铁剂

- E. 补充维B12

答案：B

> 解析：甲氨蝶呤治疗RA需监测肝功、血象，常规补充叶酸以减轻不良反应。教材P818。

---

158. [A2型题｜应用] batch033-S2-A2-013

> 模块：M2｜页码：教材P818

类风湿关节炎患者拟使用TNF-α拮抗剂，用药前必须筛查的是

- A. 筛查梅毒血清
- B. 筛查艾滋病
- C. 筛查结核与乙肝 ✅
- D. 筛查粪隐血
- E. 检查肺功能

答案：C

> 解析：生物制剂（TNF-α拮抗剂）增加感染风险，用前须筛查结核与乙肝，活动性感染期禁用，常与甲氨蝶呤联用。教材P818。

---

159. [A2型题｜理解] batch033-S2-A2-014

> 模块：M2｜页码：教材P815

类风湿关节炎晚期常见的特征性畸形是

- A. 杵状指畸形
- B. 赫伯登结节
- C. 膝内翻畸形
- D. 天鹅颈样畸形 ✅
- E. 脊柱后凸畸形

答案：D

> 解析：RA晚期最常见天鹅颈样与纽扣花样畸形、手指尺侧偏斜；杵状指见于慢性缺氧疾病，赫伯登结节与膝内翻为骨关节炎表现。教材P815。

---

160. [A3型题｜应用] batch033-S2-A3-015

> 模块：M2｜页码：教材P816

男性，50岁，双手近端指间关节、腕关节对称性肿痛1年，晨僵约1小时，逐渐出现手指天鹅颈样畸形。

- A. 关节镜探查
- B. 骨扫描检查
- C. 胸部CT检查
- D. 超声心动图
- E. 腕部X线 ✅

答案：E

> 解析：RA影像学X线（双手+腕）为诊断/分期/监测标准，可分期Ⅰ~Ⅳ；MRI用于早期诊断，但分期评估首选X线。教材P816。

---

161. [A4型题｜分析] batch033-S2-A4-016

> 模块：M2｜页码：教材P816

女性，48岁，多关节肿痛伴晨僵2年，RF阳性、抗CCP阳性，X线示双手多发虫蚀样破坏。近月出现活动后气促，胸片示双下肺间质病变。

- A. 药物毒性损伤
- B. 自身免疫性肺受累 ✅
- C. 感染直接播散
- D. 心功能不全淤血
- E. 血管翳侵犯肺

答案：B

> 解析：肺间质病变是RA最常见关节外表现，属自身免疫性多系统受累；与血管翳局部侵犯不同，为系统性表现。教材P816。

---

162. [B1型题｜记忆] batch033-S2-B1-017

> 模块：M2｜页码：教材P818

属于控制病情抗风湿药、可延缓骨破坏、起效需1~3个月的是

- A. 甲氨蝶呤 ✅
- B. 塞来昔布
- C. 糖皮质激素
- D. TNF拮抗剂
- E. 来氟米特

答案：A

> 解析：甲氨蝶呤是首选传统DMARDs，起效1~3月、可延缓病情与骨破坏；塞来昔布为NSAIDs，糖皮质激素为激素，均不控制病情。教材P818。

---

163. [B1型题｜理解] batch033-S2-B1-018

> 模块：M2｜页码：教材P818

属于非甾体抗炎药、主要缓解症状但不控制病情的是

- A. 甲氨蝶呤
- B. 糖皮质激素
- C. 塞来昔布 ✅
- D. TNF拮抗剂
- E. 来氟米特

答案：C

> 解析：塞来昔布属NSAIDs，可快速缓解RA炎症痛，但不控制病情、不防骨破坏；甲氨蝶呤/生物制剂才控病程。教材P818。

164. [X型题｜应用] batch033-S2-X-019

> 模块：M2｜页码：教材P815

下列选项中，不属于骨关节炎导致的畸形、而可见于类风湿关节炎的有

- A. 杵状指畸形 ✅
- B. 赫伯登结节
- C. 手指尺侧偏斜 ✅
- D. 天鹅颈样畸形 ✅
- E. 布夏尔结节

答案：ACD

> 解析：赫伯登结节（远端指间关节）与布夏尔结节（近端指间关节）均属骨关节炎畸形；杵状指见于慢性缺氧疾病，手指尺侧偏斜与天鹅颈样畸形为RA典型畸形，故不属于骨关节炎所致的是A、C、D。[源:考研真题 GS-2023-165]。教材P815、P816。

---

165. [X型题｜应用] batch033-S2-X-020

> 模块：M2｜页码：教材P818

下列关于类风湿关节炎治疗与病情活动的描述，正确的有

- A. NSAIDs可缓解但不延缓骨破坏 ✅
- B. 激素可改善症状但不控病情 ✅
- C. 甲氨蝶呤是首选DMARDs ✅
- D. 生物制剂常与甲氨蝶呤联用 ✅
- E. 关节畸形是判断活动的主要指标

答案：ABCD

> 解析：NSAIDs与激素仅缓解症状/不控病情、不防骨破坏；MTX为首选DMARDs；生物制剂常与MTX联用；畸形是晚期表现、与活动性无关，故E错。教材P814-818。

---

166. [A1型题 | 记忆] batch033-T2-A1-001

> 模块：M2 | 页码：教材P881

硝基苯中毒常引起的皮肤、黏膜表现是？

- A. 皮肤黏膜灼伤
- B. 皮肤巩膜黄染
- C. 皮肤黏膜发绀 ✅
- D. 皮肤黏膜苍白
- E. 皮肤潮红

答案：C

> 解析：硝基苯等中毒使血高铁血红蛋白含量增加，出现发绀；毒蕈中毒致肝损出现黄染，强酸强碱致灼伤。教材P881。［源:考研真题 GS-2020-130］

---

167. [A1型题 | 记忆] batch033-T2-A1-002

> 模块：M2 | 页码：教材P887

亚硝酸盐中毒引起高铁血红蛋白血症的有效解毒药是？

- A. 氟马西尼
- B. 亚硝酸异戊酯
- C. 二巯丙磺钠
- D. 纳洛酮
- E. 亚甲蓝 ✅

答案：E

> 解析：小剂量亚甲蓝可使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白，用于治疗亚硝酸盐、苯胺、硝基苯等中毒。教材P887。［源:考研真题 GS-2021-130］

---

168. [A1型题 | 记忆] batch033-T2-A1-003

> 模块：M2 | 页码：教材P879

中毒是指进入人体的化学物质达到什么量而引起组织器官损害？

- A. 治疗量
- B. 致病剂量 ✅
- C. 预防量
- D. 微剂量
- E. 极量值

答案：B

> 解析：进入人体的化学物质达到中毒量，导致组织和器官损害而引起的全身性疾病称为中毒。教材P879。

---

169. [A1型题 | 理解] batch033-T2-A1-004

> 模块：M2 | 页码：教材P879

根据毒物来源和用途，中毒的毒物分类不包括？

- A. 工业性毒物
- B. 医用药物
- C. 杀虫农药
- D. 有毒动植物
- E. 放射性物质 ✅

答案：E

> 解析：毒物分为工业性毒物、药物、农药、有毒动植物四类；放射性物质属物理因素致病，不列入中毒的化学毒物四类。教材P879。

---

170. [A1型题 | 理解] batch033-T2-A1-005

> 模块：M2 | 页码：教材P885

口服毒物后，清除胃肠道内尚未吸收毒物最常用的措施是？

- A. 催吐

- B. 洗胃 ✅
- C. 血液灌流
- D. 血浆置换
- E. 高压氧

答案：B

> 解析：口服毒物早期仍在胃内，洗胃是清除未吸收毒物的主要措施；血液净化用于清除已吸收毒物。教材P885。

---

171. [A1型题 | 理解] batch033-T2-A1-006

> 模块：M2 | 页码：教材P885

关于催吐在急性中毒抢救中的应用，正确的是？

- A. 已作为临床常规应用
- B. 适用于昏迷患者
- C. 临床上已不常规应用 ✅
- D. 可用于食管静脉曲张者
- E. 对孕妇安全

答案：C

> 解析：催吐易引起误吸、食管撕裂、胃穿孔等，且延迟活性炭应用，临床上已不常规使用。教材P885。

---

172. [A1型题 | 记忆] batch033-T2-A1-007

> 模块：M2 | 页码：教材P886

敌百虫口服中毒时禁用的洗胃液是？

- A. 清水溶液
- B. 2%碳酸氢钠 ✅
- C. 高锰酸钾液
- D. 生理盐水

- E. 温开溶液

答案：B

> 解析：敌百虫遇碱可转变为毒性更强的敌敌畏，故敌百虫中毒忌用2%碳酸氢钠，常用清水或高锰酸钾洗胃。教材P886。

---

173. [A1型题 | 记忆] batch033-T2-A1-008

> 模块：M2 | 页码：教材P886

对硫磷（1605）口服中毒时禁用的洗胃液是？

- A. 清水溶液
- B. 2%碳酸氢钠
- C. 高锰酸钾液 ✅
- D. 生理盐水
- E. 肥皂水溶液

答案：C

> 解析：对硫磷等硫代类有机磷经1:5000高锰酸钾氧化后毒性增强，故对硫磷中毒忌用高锰酸钾，可用清水或碳酸氢钠。教材P886。

---

174. [A2型题 | 应用] batch033-T2-A2-009

> 模块：M2 | 页码：教材P887

女性，30岁。自服百草枯后口腔糜烂、进行性呼吸困难。清除已吸收毒物首选？

- A. 血液灌流 ✅
- B. 血液透析
- C. 血浆置换
- D. 腹膜透析
- E. 强化利尿

答案：A

> 解析：血液灌流用活性炭或树脂吸附脂溶性及大分子毒物，能清除百草枯，是最常用的中毒抢救措施之一。教材P887。

---

175. [A2型题｜应用] batch033-T2-A2-010

> 模块：M2｜页码：教材P892

男性，22岁。服敌敌畏后1小时入院，昏迷，大汗，瞳孔缩小，双肺湿啰音。洗胃宜选？

- A. 清水冲洗液
- B. 高锰酸钾液
- C. 2%碳酸氢钠 ✅
- D. 0.3%过氧化氢
- E. 5%硫酸钠

答案：C

> 解析：敌敌畏属有机磷，可用2%碳酸氢钠溶液洗胃；若为对硫磷则忌高锰酸钾，敌百虫忌碳酸氢钠。教材P892。

---

176. [A2型题｜应用] batch033-T2-A2-011

> 模块：M2｜页码：教材P881

男性，40岁。误服抗胆碱药物后烦躁、瞳孔散大、皮肤潮红、心率130次/分。该表现属？

- A. 有机磷中毒
- B. 阿托品中毒 ✅
- C. 吗啡中毒
- D. 一氧化碳中毒
- E. 亚硝酸盐中毒

答案：B

> 解析：阿托品等抗胆碱药中毒表现为瞳孔扩大、皮肤干燥潮红、烦躁、心率增快；与有机磷中毒的瞳孔缩小、大汗相反。教材P881。

177. [A2型题｜理解] batch033-T2-A2-012

> 模块：M2丨页码：教材P887

关于中毒后血液净化方式的选择，正确的是？

- A. 血浆置换用于金属中毒
- B. 血液透析适于脂溶性大分子毒物
- C. 所有中毒均须血液净化
- D. 血液灌流不能清除巴比妥类
- E. 血液灌流可清除百草枯 ✅

答案：E

> 解析：血液灌流吸附脂溶性毒物，能清除巴比妥类和百草枯；透析适于水溶性小分子，血浆置换用于蛋白结合/生物毒。教材P887。

---

178. [A2型题｜理解] batch033-T2-A2-013

> 模块：M2丨页码：教材P887

女性，35岁。服镇静催眠药过量、意识模糊。为加速已吸收毒物排泄可采用？

- A. 强化利尿 ✅
- B. 洗胃
- C. 催吐
- D. 导泻
- E. 高压氧

答案：A

> 解析：强化利尿用于以原形由肾排出的毒物，快速输注葡萄糖液并静脉注射呋塞米促进排泄；洗胃、催吐针对未吸收毒物。教材P887。

---

179. [A2型题｜应用] batch033-T2-A2-014

> 模块：M2｜页码：教材P881

男性，50岁。食变质蔬菜后口唇发绀、头痛，血氧正常。最可能的中毒是？

- A. 一氧化碳
- B. 亚硝酸盐 ✅
- C. 有机磷
- D. 酒精
- E. 氰化物

答案：B

> 解析：亚硝酸盐引起肠源性发绀（高铁血红蛋白血症），血氧正常但组织缺氧；一氧化碳发绀伴碳氧血红蛋白升高。教材P881。

---

180. [A3型题｜理解] batch033-T2-A3-015

> 模块：M2｜页码：教材P881

男性，28岁。田间喷洒有机磷农药后头晕、恶心、大汗、视物模糊。体检最有助于提示其中毒的体征是？

- A. 瞳孔缩小 ✅
- B. 体温升高
- C. 高血压
- D. 皮肤黄染
- E. 下肢水肿

答案：A

> 解析：瞳孔缩小见于有机磷、氨基甲酸酯类、吗啡、巴比妥等中毒，是中毒体征鉴别的关键线索之一。教材P881。

---

181. [A4型题｜分析] batch033-T2-A4-016

> 模块：M2｜页码：教材P892

女性，45岁。口服杀虫剂后昏迷、肺水肿、肌颤，血ChE 15%。关于抢救，错误的是？

- A. 及时予以洗胃
- B. 阿托品抗M样症状
- C. 氯解磷定复活胆碱酯酶
- D. 吗啡镇静止痛 ✅
- E. 清除体内毒物

答案：D

> 解析：有机磷中毒合并肺水肿时禁用吗啡（抑制呼吸），应使用阿托品；阿托品与胆碱酯酶复活药联合解毒。教材P892。

---

182. [B1型题｜记忆] batch033-T2-B1-017

> 模块：M2｜页码：教材P888

阿片类中毒的特效解毒药是？

- A. 纳洛酮 ✅
- B. 氟马西尼
- C. 亚甲蓝
- D. 依地酸钙钠
- E. 氯解磷定

答案：A

> 解析：纳洛酮为阿片受体拮抗剂，对麻醉镇痛药引起的呼吸抑制有特异性拮抗作用。教材P888。

---

183. [B1型题｜理解] batch033-T2-B1-018

> 模块：M2｜页码：教材P888

苯二氮䓬类中毒的特效解毒药是？

- A. 纳洛酮
- B. 氟马西尼 ✅
- C. 亚甲蓝
- D. 依地酸钙钠
- E. 氯解磷定

答案：B

> 解析：氟马西尼是苯二氮䓬受体拮抗剂，用于治疗苯二氮䓬类药物过量和中毒。教材P888。

---

184. [X型题｜理解] batch033-T2-X-019

> 模块：M2｜页码：教材P887

下列关于急性中毒特殊解毒药的应用，正确的有？

- A. 依地酸钙钠治疗铅中毒 ✅
- B. 二巯丙醇治疗砷、汞中毒 ✅
- C. 去铁胺治疗镁中毒
- D. 小剂量亚甲蓝治疗高铁血红蛋白血症 ✅
- E. 纳洛酮治疗阿片类中毒 ✅

答案：ABDE

> 解析：依地酸钙钠螯合铅，二巯丙醇治砷汞，小剂量亚甲蓝治高铁血红蛋白血症，纳洛酮拮阿片；去铁胺用于治疗铁中毒而非镁中毒。教材P887。［源:考研真题 GS-2010-169］

---

185. [X型题｜应用] batch033-T2-X-020

> 模块：M2｜页码：教材P886

下列有机磷杀虫药口服中毒时，可用2%碳酸氢钠溶液反复洗胃的有？

- A. 对硫磷 ✅
- B. 敌百虫

- C. 敌敌畏 ✅
- D. 乐果 ✅
- E. 强酸

答案：ACD

> 解析：一般有机磷可用2%碳酸氢钠洗胃，但对硫磷、敌敌畏、乐果均可用；敌百虫忌用（变敌敌畏），强酸亦忌碳酸氢钠。教材P886。［源:考研真题 GS-2023-156］

M3（100题）

186. [A1型题｜记忆] batch033-D3-A1-001

> 模块：M3｜页码：教材P370

慢性胃炎最常见的病因是

- A. 幽门螺杆菌(Hp)感染 ✅
- B. 自身免疫异常
- C. 长期饮酒刺激
- D. 胆汁反流损伤
- E. 药物刺激损伤

答案：A

> 解析：Hp感染是慢性胃炎最常见病因(尤其B型胃窦炎，占约90%)；自身免疫见于A型(少见)。教材P370。

---

187. [A1型题｜理解] batch033-D3-A1-002

> 模块：M3｜页码：教材P370

A型(自身免疫性)胃炎的主要特征是

- A. 胃窦病变为主
- B. 胃体萎缩伴恶性贫血 ✅

- C. Hp阳性率高
- D. 无贫血表现
- E. 胃酸分泌增多

答案：B

> 解析：A型为胃体/胃底萎缩，壁细胞破坏→内因子↓→VitB12吸收障碍→恶性贫血，胃酸显著降低、胃泌素升高。教材P370。

---

188. [A1型题｜记忆] batch033-D3-A1-003

> 模块：M3｜页码：教材P370

慢性B型(多灶萎缩性)胃炎的好发部位是

- A. 胃体
- B. 胃底
- C. 胃窦 ✅
- D. 贲门
- E. 幽门管

答案：C

> 解析：B型胃炎由Hp感染所致，好发于胃窦，极常见；A型好发于胃体/胃底。教材P370。

---

189. [A1型题｜理解] batch033-D3-A1-004

> 模块：M3｜页码：教材P371

A型萎缩性胃炎伴恶性贫血的主要机制是

- A. 膳食铁摄入不足所致
- B. 内因子缺乏使B12吸收障碍 ✅
- C. 叶酸摄入不足所致
- D. 慢性失血丢失过多
- E. 红细胞破坏溶血过多

答案：B

> 解析：A型胃炎抗内因子抗体阻断内因子，VitB12在小肠无法吸收→巨幼细胞性贫血(恶性贫血)，可伴神经症状。教材P371。

---

190. [A1型题 | 记忆] batch033-D3-A1-005

> 模块：M3 | 页码：教材P370

幽门螺杆菌(Hp)根除的标准四联方案包含

- A. PPI加1种抗生素
- B. PPI+铋剂+2种抗生素 ✅
- C. 仅单用铋剂治疗
- D. H2RA加1种抗生素
- E. 单用益生菌制剂

答案：B

> 解析：根除用PPI+铋剂+2种抗生素(如克拉霉素+阿莫西林)，疗程10-14天；单一抗菌药易耐药。教材P370。

---

191. [A1型题 | 理解] batch033-D3-A1-006

> 模块：M3 | 页码：教材P370

$^{13}C/^{14}C$呼气试验用于幽门螺杆菌检测的主要原理是

- A. 抽血检测血抗体
- B. 检测Hp尿素酶分解尿素产氨 ✅
- C. 检测细菌毒素量
- D. 检测粪便中抗原
- E. 检测细菌培养物

答案：B

> 解析：Hp依赖尿素酶产氨中和胃酸，服标记尿素后被分解呼出标记CO_2；该法无创、敏感，是根除后复查首选。教材P370。

---

192. [A1型题 | 记忆] batch033-D3-A1-007

> 模块：M3 | 页码：教材P373

属于胃癌癌前情况的是

- A. 急性糜烂性胃炎
- B. 慢性非萎缩性胃炎
- C. 萎缩性胃炎伴肠化生 ✅
- D. 消化性溃疡
- E. 胃息肉增生

答案：C

> 解析：萎缩、肠化生、异型增生构成胃癌癌前阶梯；慢性非萎缩性胃炎无明显癌变倾向。教材P373。

---

193. [A1型题 | 记忆] batch033-D3-A1-008

> 模块：M3 | 页码：教材P369

下述应激性溃疡的名称中，哪个与烧伤有关？

- A. 急性消化性溃疡
- B. 糜烂性胃炎
- C. 出血性胃炎
- D. Curling 溃疡 ✅
- E. Cushing 溃疡

答案：D

> 解析：Curling 溃疡指继发重度烧伤后发生的消化性溃疡。Cushing 溃疡是指继发重症脑外伤后发生的消化性溃疡。［源:考研真题 GS-1995-083］

194. [A2型题｜应用] batch033-D3-A2-009

> 模块：M3｜页码：教材P370

女性,45岁。上腹不适，胃镜示胃窦黏膜红白相间、活检幽门螺杆菌阳性。恰当的处理是

- A. 立即四联根除Hp ✅
- B. 外科手术治疗
- C. 单用抗酸药
- D. 暂不处理观察
- E. 全身化学治疗

答案：A

> 解析：B型胃炎Hp(+)应行铋剂四联根除(10-14天)；Hp是胃炎-溃疡-胃癌共同上游，根除可阻断进展。教材P370。

---

195. [A2型题｜应用] batch033-D3-A2-010

> 模块：M3｜页码：教材P371

男性,55岁。乏力、面色苍白，胃镜示胃体萎缩，Hb 80g/L，血清VitB12降低。最可能的诊断是

- A. B型萎缩性胃炎
- B. A型胃炎伴恶性贫血 ✅
- C. 消化性溃疡
- D. 胃癌性病变
- E. 缺铁性贫血

答案：B

> 解析：胃体萎缩+内因子缺乏→VitB12吸收障碍→巨幼细胞性贫血(恶性贫血)，为A型胃炎典型结局。教材P371。

---

196. [A2型题｜理解] batch033-D3-A2-011

> 模块：M3｜页码：教材P369

男性，40岁。大量饮酒后突发上腹痛、呕血。急诊考虑急性糜烂出血性胃炎，其主要机制是

- A. Hp急性感染所致
- B. 药物/乙醇损伤黏膜屏障 ✅
- C. 自身免疫破坏壁细胞
- D. 胆汁反流损伤黏膜
- E. 病毒感染胃黏膜

答案：B

> 解析：急性糜烂出血性胃炎多由应激/NSAIDs/乙醇致黏膜血流与屏障失守，H^+反弥散腐蚀黏膜；与Hp关系不大。教材P369。

---

197. [A2型题｜理解] batch033-D3-A2-012

> 模块：M3｜页码：教材P373

女性，50岁。内镜检查诊断慢性萎缩性胃炎，患者担心癌变。应告知需

- A. 无须随访
- B. 定期胃镜随访 ✅
- C. 立即手术
- D. 化学治疗
- E. 放射治疗

答案：B

> 解析：萎缩/肠化生/异型增生为癌前情况，需定期胃镜随访以早期发现癌变；仅在重度异型增生才考虑切除。教材P373。

---

198. [A2型题｜应用] batch033-D3-A2-013

> 模块：M3｜页码：教材P369

男性，35岁。长期服用阿司匹林，上腹隐痛，胃镜示黏膜糜烂。最可能的是

- A. 自身免疫性胃炎
- B. NSAID相关性胃炎 ✅
- C. B型萎缩性胃炎
- D. A型萎缩性胃炎
- E. 胃部癌性病变

答案：B

> 解析：NSAIDs抑制前列腺素(黏膜保护因子)削弱屏障，诱发急性/慢性糜烂性胃炎；与Hp无关。教材P369。

---

199. [A2型题 | 应用] batch033-D3-A2-014

> 模块：M3 | 页码：教材P370

女性，60岁。既往Hp(+)胃炎，四联疗程结束后复查是否根除，首选

- A. 血清Hp抗体
- B. 尿素呼气试验 ✅
- C. 胃镜活检
- D. 粪便隐血
- E. 钡餐造影

答案：B

> 解析：根除后复查首选尿素呼气试验(无创、敏感)；血清抗体长期存在，只提示感染不用于复查。教材P370。

---

200. [A3型题 | 应用] batch033-D3-A3-015

> 模块：M3 | 页码：教材P370

男性，50岁。上腹隐痛，胃镜示胃窦炎、幽门螺杆菌阳性。为根治病变并降低溃疡/胃癌风险，治疗应首选

- A. 四联根除Hp ✅

- B. 外科手术治疗
- C. 单用铋剂治疗
- D. 中药辨证调理
- E. 暂时观察

答案：A

> 解析：Hp(+)慢性胃炎应铋剂四联根除(10-14天)；根除是阻断胃炎→溃疡→胃癌的关键。教材P370。

---

201. [A4型题｜分析] batch033-D3-A4-016

> 模块：M3｜页码：教材P371

女性,48岁。胃镜示胃体萎缩，抗壁细胞抗体(PCA)与抗内因子抗体(IFA)均阳性，胃酸显著降低，血清胃泌素升高。最符合

- A. B型萎缩性胃炎
- B. A型(自身免疫性)胃炎 ✅
- C. 消化性溃疡病变
- D. 胃的恶性肿瘤
- E. 反流性食管炎

答案：B

> 解析：PCA/IFA(+)破坏壁细胞→胃体萎缩、胃酸↓、胃泌素反馈性↑、内因子缺→恶性贫血，是A型胃炎完整机制链。教材P370-371。

---

202. [B1型题｜记忆] batch033-D3-B1-017

> 模块：M3｜页码：教材P370

慢性胃炎中，病变以胃远端为著、幽门螺杆菌阳性、无贫血者，典型属于

- A. 胃体部萎缩
- B. 胃窦为主(B型) ✅
- C. 伴恶性贫血

- D. 胃酸显著减低
- E. PCA阳性

答案：B

> 解析：B型胃炎多见于胃窦、Hp(+)、无贫血、胃酸正常或偏低；A型才胃体萎缩、恶性贫血、PCA(+)。教材P370。

---

203. [B1型题｜理解] batch033-D3-B1-018

> 模块：M3｜页码：教材P373

属于胃癌癌前病变背景的胃炎类型是

- A. 慢性萎缩性胃炎 ✅
- B. 慢性非萎缩性胃炎
- C. 化脓性胃炎
- D. 嗜酸性胃炎
- E. 放射性胃炎

答案：A

> 解析：慢性萎缩性胃炎伴肠化生/异型增生为胃癌癌前；非萎缩性无明确癌变倾向。教材P373。

---

204. [X型题｜理解] batch033-D3-X-019

> 模块：M3｜页码：教材P370

下列属于慢性胃炎发病原因的有

- A. 幽门螺杆菌感染 ✅
- B. 自身免疫反应 ✅
- C. 精神心理刺激
- D. 十二指肠液反流入胃 ✅

答案：ABD

> 解析：慢性胃炎的病因：①幽门螺杆菌(Hp)感染是慢性胃炎的主要病因。②自身免疫性胃炎的自身抗体攻击壁细胞，使壁细胞总数减少，导致胃酸分泌减少；内因子抗体与内因子结合，阻碍维生素 B12 的吸收，从而导致恶性贫血。③幽门括约肌功能不全时，含胆汁和胰液的十二指肠液反流入胃，可削弱胃黏膜屏障功能，导致慢性胃炎。④慢性胃炎的发病与精神刺激无关，精神刺激是消化性溃疡的常见诱因。［源:考研真题 GS-2012-171］

---

205. [X型题｜理解] batch033-D3-X-020

> 模块：M3｜页码：教材P373

属于癌前病变的有

- A. 黏膜白斑 ✅
- B. 慢性非萎缩性胃炎
- C. 慢性溃疡性结肠炎 ✅
- D. 大肠绒毛状腺瘤 ✅

答案：ACD

> 解析：①某些疾病或病变本身不是恶性肿瘤，但具有发展为恶性肿瘤的潜能，患者发生相应恶性肿瘤的风险增加，这些疾病或病变称为癌前病变。黏膜白斑为鳞状细胞癌的癌前病变。慢性溃疡性结肠炎是结肠癌的癌前病变。大肠绒毛状腺瘤是大肠癌的癌前病变。②慢性萎缩性胃炎多伴肠上皮化生，是胃癌的癌前病变。慢性非萎缩性胃炎不属于癌前病变，故不答 B。参阅【1994NO37】。［源:考研真题 GS-2021-150］

---

206. [A1型题｜记忆] batch033-R3-A1-001

> 模块：M3｜页码：教材P499

社区获得性尿路感染最常见的致病菌是

- A. 大肠埃希菌 ✅
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎链球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 白色念珠菌

答案：A

> 解析：社区（非复杂）尿路感染约85%由大肠埃希菌等革兰阴性杆菌经上行感染引起。教材P499。

---

207. [A1型题 | 记忆] batch033-R3-A1-002

> 模块：M3 | 页码：教材P499

诊断尿路感染最主要的依据是真性细菌尿，清洁中段尿培养阳性的标准是

- A. ≥10^3 CFU/ml
- B. ≥10^4 CFU/ml
- C. ≥10^5 CFU/ml ✅
- D. ≥10^6 CFU/ml
- E. ≥10^2 CFU/ml

答案：C

> 解析：真性细菌尿指清洁中段尿培养菌落计数≥10^5 CFU/ml，是诊断尿路感染最主要的细菌学依据。教材P499。

---

208. [A1型题 | 记忆] batch033-R3-A1-003

> 模块：M3 | 页码：教材P499

尿路感染中，血行播散（下行）感染最常见的致病菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 变形杆菌
- C. 克雷伯菌
- D. 粪肠球菌
- E. 金黄色葡萄球菌 ✅

答案：E

> 解析：上行感染以大肠埃希菌为主，而血行（下行）播散感染以金黄色葡萄球菌多见。教材P499。

---

209. [A1型题 | 记忆] batch033-R3-A1-004

> 模块：M3 | 页码：教材P500

急性膀胱炎在尿路感染中所占比例约为

- A. 30%
- B. 50%
- C. 70%
- D. 90% ✅
- E. 100%

答案：D

> 解析：急性膀胱炎约占尿路感染的90%，表现为尿路刺激征而无全身症状。教材P500。

---

210. [A1型题 | 记忆] batch033-R3-A1-005

> 模块：M3 | 页码：教材P501

提示尿路感染定位于上尿路（肾盂）最有价值的尿检发现是

- A. 白细胞管型 ✅
- B. 出现脓尿
- C. 出现血尿
- D. 蛋白尿
- E. 检出菌尿

答案：A

> 解析：白细胞管型来自肾小管，是上尿路感染（肾盂肾炎）的实验室定位证据；下尿路（膀胱炎）无白细胞管型。教材P501。

---

211. [A1型题｜记忆] batch033-R3-A1-006

> 模块：M3｜页码：教材P499

关于无症状细菌尿，下列说法恰当的是

- A. 此类患者均需抗生素治疗
- B. 非妊娠健康女性通常不需治疗 ✅
- C. 必有尿频尿急尿痛
- D. 常伴高热及寒战
- E. 必须行静脉肾盂造影

答案：B

> 解析：无症状细菌尿有真性菌尿但无临床症状，非妊娠健康女性通常不需抗生素；妊娠期妇女须治疗。教材P499。

---

212. [A1型题｜理解] batch033-R3-A1-007

> 模块：M3｜页码：教材P499

留置导尿管超过多长时间，医院获得性尿路感染发生率显著升高

- A. 1天
- B. 2天
- C. 3天 ✅
- D. 5天
- E. 7天

答案：C

> 解析：留置导尿管>3天者医院获得性尿路感染发生率可达90%以上，是重要医源性易感因素。教材P499。

---

213. [A1型题｜理解] batch033-R3-A1-008

> 模块：M3｜页码：教材P503

无并发症的急性膀胱炎，推荐的短程疗法疗程约为

- A. 1~2日
- B. 3~5日 ✅
- C. 7日
- D. 10日
- E. 14日

答案：B

> 解析：急性膀胱炎推荐短程疗法（呋喃妥因5日或TMP-SMZ 3日）；妊娠、老年、糖尿病、男性等用7日疗法。教材P503。

---

214. [A2型题｜理解] batch033-R3-A2-009

> 模块：M3｜页码：教材P501

女性,32岁,发热、腰痛伴尿频尿急尿痛2天。查体:T38.5℃,双肾区叩痛阳性。化验:尿WBC满视野/HPF,可见白细胞管型。最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性尿道炎
- C. 急性膀胱炎
- D. 急性肾盂肾炎 ✅
- E. 慢性肾盂肾炎

答案：D

> 解析：①患者有膀胱刺激征、全身症状（发热）、肾区叩痛、脓尿、白细胞管型,应诊断为急性肾盂肾炎。急性肾小球肾炎常表现为血尿、蛋白尿、高血压、水肿、肾功能一过性受损,尿中可出现红细胞管型而不是白细胞管型。急性尿道炎、急性膀胱炎一般无发热、肾区叩痛、尿白细胞管型。[源:考研真题 GS-2008-102]

---

215. [A2型题｜理解] batch033-R3-A2-010

> 模块：M3｜页码：教材P500

青年女性，尿频、尿急、尿痛2天，无发热及腰痛，肾区无叩痛，尿常规白细胞满视野。最可能的诊断是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 尿道综合征
- E. 急性膀胱炎 ✅

答案：E

> 解析：急性膀胱炎表现为尿路刺激征，无全身症状、无肾区叩痛、无白细胞管型；本例符合下尿路感染。教材P500。

---

216. [A2型题｜理解] batch033-R3-A2-011

> 模块：M3｜页码：教材P501

中年女性，发热、腰痛3天，伴尿频尿急，肾区叩击痛阳性，尿常规见白细胞管型。最可能的诊断是

- A. 急性肾盂肾炎 ✅
- B. 急性膀胱炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 肾结石梗阻
- E. 急性肾小球肾炎

答案：A

> 解析：高热、腰痛、肾区叩痛及白细胞管型是急性肾盂肾炎（上尿路）的典型表现。教材P501。

---

217. [A2型题｜应用] batch033-R3-A2-012

> 模块：M3｜页码：教材P503

妊娠女性患急性膀胱炎，无并发症，其抗生素疗程应至少为

- A. 1~2日
- B. 7日 ✅
- C. 3~5日
- D. 10日
- E. 14日

答案：B

> 解析：妊娠、老年、糖尿病、免疫力低下及男性病人的尿路感染复发风险高，需7天疗法；急性肾盂肾炎为2周。教材P503。

---

218. [A2型题 | 应用] batch033-R3-A2-013

> 模块：M3 | 页码：教材P503

急性肾盂肾炎患者经口服抗生素治疗，通常需完成的总疗程为

- A. 3~5日
- B. 7日
- C. 2周 ✅
- D. 4周
- E. 6周

答案：C

> 解析：急性肾盂肾炎感染深、菌量大，需2周疗程；病情重则住院静脉给药，热退后改口服至满2周。教材P503。

---

219. [A2型题 | 应用] batch033-R3-A2-014

> 模块：M3 | 页码：教材P499

女性，反复发作尿路感染，每次均为同一菌株，多发生在治疗结束后2周内。这种情况称为

- A. 再发感染
- B. 慢性复发感染
- C. 无症状菌尿

- D. 停药后复发 ✅
- E. 尿道综合征

答案：D

> 解析：复发指停药后2周内由同一病原体再次引起感染；再感染则为新病原体所致。教材P499。

---

220. [A3型题｜分析] batch033-R3-A3-015

> 模块：M3｜页码：教材P499

老年男性，排尿困难、发热、腰痛，既往前列腺增生。尿培养大肠埃希菌阳性，B超示肾盂积水。该尿路感染应归类为

- A. 非复杂性尿路感染
- B. 无症状细菌尿
- C. 尿道综合征
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 复杂性尿路感染 ✅

答案：E

> 解析：存在梗阻（前列腺增生、肾盂积水）等结构异常属复杂性尿路感染，需更长疗程并积极去除诱因。教材P499。

---

221. [A4型题｜应用] batch033-R3-A4-016

> 模块：M3｜页码：教材P504

中年女性，反复尿频尿急尿痛10年，近1年血压偏高，B超示双肾皮质变薄、肾盂变形。最可能的诊断是

- A. 慢性肾盂肾炎 ✅
- B. 急性膀胱炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾小球肾炎

- E. 泌尿系结核

答案：A

> 解析：反复发作尿路感染>6个月伴肾盂变形、肾皮质变薄，提示慢性肾盂肾炎，可进展为慢性肾衰竭。教材P504。

---

222. [B1型题｜理解] batch033-R3-B1-017

> 模块：M3丨页码：教材P500

急性膀胱炎的典型表现是

- A. 高热腰痛白细胞管型
- B. 尿频尿急无全身症状 ✅
- C. 无痛性全程血尿
- D. 大量蛋白尿水肿
- E. 难治性高血压

答案：B

> 解析：急性膀胱炎为下尿路感染，仅有尿路刺激征，无全身症状、无肾区叩痛、无白细胞管型。教材P500。

---

223. [B1型题｜理解] batch033-R3-B1-018

> 模块：M3丨页码：教材P501

急性肾盂肾炎的典型表现是

- A. 尿频尿急无全身症状
- B. 无痛性全程血尿
- C. 高热腰痛白细胞管型 ✅
- D. 大量蛋白尿水肿
- E. 难治性高血压

答案：C

> 解析：急性肾盂肾炎为上尿路感染，除尿路刺激征外有高热、腰痛、肾区叩痛及白细胞管型。教材P501。

---

224. [X型题｜理解] batch033-R3-X-019

> 模块：M3丨页码：教材P501

关于尿路感染的定位诊断，下列说法正确的有

- A. 急性膀胱炎常有明显全身症状
- B. 急性肾盂肾炎可出现白细胞管型 ✅
- C. 急性肾盂肾炎外周血白细胞常升高 ✅
- D. 急性膀胱炎无肾区叩痛 ✅
- E. 肾盂肾炎必有肉眼血尿

答案：BCD

> 解析：急性肾盂肾炎有全身症状、白细胞管型、外周血白细胞升高；急性膀胱炎无全身症状、无肾区叩痛、无白细胞管型；肉眼血尿非肾盂肾炎必有。教材P500-501。

---

225. [X型题｜应用] batch033-R3-X-020

> 模块：M3丨页码：教材P499

尿路感染的常见易感因素包括

- A. 尿路梗阻 ✅
- B. 膀胱输尿管反流 ✅
- C. 机体免疫力低下 ✅
- D. 长期留置导尿管 ✅
- E. 高海拔居住

答案：ABCD

> 解析：易感因素有尿路梗阻、结构异常、膀胱输尿管反流、免疫力低下、女性/妊娠、医源性（留置导尿管>3天）等。教材P499。

226. [A1型题｜记忆] batch033-E3-A1-001

> 模块：M3｜页码：教材P732

糖尿病诊断中，空腹血糖（FPG）的切点值为？

- A. ≥5.1 mmol/L
- B. ≥6.1 mmol/L
- C. ≥7.0 mmol/L ✅
- D. ≥8.5 mmol/L
- E. ≥11.1 mmol/L

答案：C

> 解析：糖尿病诊断四选一：随机血糖≥11.1、FPG≥7.0、OGTT 2h≥11.1、HbA1c≥6.5（无典型症状须改日复查）。教材P732。

---

227. [A1型题｜记忆] batch033-E3-A1-002

> 模块：M3｜页码：教材P732

作为糖尿病诊断补充标准的糖化血红蛋白（HbA1c）切点是？

- A. ≥6.5%
- B. ≥5.7%
- C. ≥7.0% ✅
- D. ≥5.1%
- E. ≥11.1%

答案：C

> 解析：HbA1c≥6.5%为糖尿病诊断标准之一，反映约8-12周平均血糖；<5.7%为正常，5.7%-6.4%为糖尿病高危。教材P732。

---

228. [A1型题｜理解] batch033-E3-A1-003

> 模块：M3｜页码：教材P732

口服葡萄糖耐量试验（OGTT）2小时血糖诊断糖尿病的切点是？

- A. ≥11.1 mmol/L
- B. ≥7.8 mmol/L
- C. ≥10.0 mmol/L
- D. ≥8.5 mmol/L ✅
- E. ≥7.0 mmol/L

答案：D

> 解析：OGTT 2h血糖≥11.1 mmol/L可诊断糖尿病（75g无水葡萄糖负荷）；7.8-<11.1为糖耐量减低（IGT）。教材P732。

---

229. [A1型题｜记忆] batch033-E3-A1-004

> 模块：M3｜页码：教材P725

2型糖尿病（T2DM）占糖尿病总数的比例约为？

- A. 90%-95%
- B. 50%-60%
- C. 低于10%
- D. 30%-40%
- E. 100% ✅

答案：E

> 解析：T2DM占糖尿病90%-95%，以胰岛素抵抗伴β细胞功能缺陷为主，多隐匿起病、见于40岁后；T1DM约占5%-10%。教材P725。

---

230. [A1型题｜理解] batch033-E3-A1-005

> 模块：M3｜页码：教材P725

临床诊断 1 型糖尿病的主要依据是

- A. 年轻患者典型三多一少症状
- B. 反复出现酮症的状态
- C. 胰岛素分泌曲线低平 ✅
- D. 需用胰岛素控制血糖
- E. C肽水平显著升高

答案：C

> 解析：1型糖尿病是胰岛β细胞破坏，导致胰岛素分泌过少所致，表现为胰岛素分泌曲线低平。2型糖尿病是胰岛素抵抗所致，胰岛素分泌并不减少，故答C。无论1型还是2型糖尿病均可有典型三多一少症状，均可出现酮症酸中毒，到病程晚期均需使用胰岛素控制血糖，故A、B、D均不能作为两者的鉴别要点。［源:考研真题 GS-2017-055］

---

231. [A1型题｜理解] batch033-E3-A1-006

> 模块：M3｜页码：教材P734

使用二甲双胍的禁忌证是？

- A. eGFR<30ml/min/1.73m2
- B. eGFR<60ml/min/1.73m2 ✅
- C. HbA1c>9%控制不佳的情况
- D. 合并肥胖时属于慎用情况
- E. 高龄患者为相对禁忌情况

答案：B

> 解析：二甲双胍经肾排泄，eGFR<30时清除差、有乳酸性酸中毒风险，属禁忌；eGFR 30-45需减量评估，并非一律禁用。教材P734。

---

232. [A1型题｜理解] batch033-E3-A1-007

> 模块：M3｜页码：教材P743

在糖尿病酮症酸中毒的治疗中， 最关键的措施是

- A. 补充液体并兼顾纠正酸中毒 ✅
- B. 小剂量胰岛素控制酮症酸中毒
- C. 纠正酸中毒的状态
- D. 补钾防治酸中毒相关低钾
- E. 早期大剂量静脉推注碳酸氢钠

答案：A

> 解析：糖尿病酮症酸中毒（DKA）患者由于严重高血糖、高血酮和酸性代谢产物引起渗透性利尿，可导致严重缺水、电解质平衡紊乱，因此最关键的治疗措施是补充液体，通常使用生理盐水。只有有效改善组织灌注后，胰岛素的生物效应才能充分发挥。临床常采用小剂量胰岛素疗法降低血糖、抑制酮体生成；pH<7.1、HCO_3^-<5mmol/L时需补碱；并应注意补钾。［源:考研真题 GS-2012-074］

---

233. [A1型题 | 应用] batch033-E3-A1-008

> 模块：M3 | 页码：教材P745

糖尿病酮症酸中毒（DKA）中，需要补碱治疗的血pH界值是？

- A. pH<6.9 mmHg
- B. pH<7.1 mmHg
- C. pH<7.3 mmHg
- D. pH<7.45 mmHg ✅
- E. 任意酸中毒均补碱

答案：D

> 解析：DKA一般经补液+小剂量胰岛素后酸中毒可自纠，仅当pH<6.9（或HCO_3^-<5mmol/L）才少量补碱，过快补碱可致低钾、脑脊液反常性酸中毒、脑水肿。教材P745。

---

234. [A2型题 | 应用] batch033-E3-A2-009

> 模块：M3 | 页码：教材P732

50岁男性，多饮、多尿、体重下降，查FPG 8.5、OGTT 2h 13.2、HbA1c 8.2%。最可能的诊断是？

- A. 糖尿病的情况
- B. 糖耐量减低（IGT）
- C. 空腹血糖受损（IFG）
- D. 正常糖耐量的状态
- E. 应激性高血糖的状态 ✅

答案：E

> 解析：FPG≥7.0、OGTT 2h≥11.1、HbA1c≥6.5%任一达标即可诊断糖尿病，本例三项均超切点且有症状，诊断明确。教材P732。

---

235. [A2型题 | 记忆] batch033-E3-A2-010

> 模块：M3 | 页码：教材P725

胰岛素依赖型糖尿病(1型)与非胰岛素依赖型糖尿病(2型)的最主要区别是

- A. 发病年龄不同的状态
- B. 对胰岛素的敏感性不同
- C. 胰岛素基础水平与释放曲线不同 ✅
- D. 发生酮中毒的倾向不同
- E. 血糖稳定性不同的状态

答案：C

> 解析：1型糖尿病是由于胰岛β细胞破坏，引起胰岛素分泌减少所致。2型糖尿病是胰岛素抵抗和（或）胰岛素分泌缺陷所致，因此体内胰岛素水平正常或升高，可见两者的最主要区别是胰岛素基础水平与释放曲线不同。发病年龄、对胰岛素敏感性、酮症倾向、血糖稳定性均可作为鉴别点，但都不是主要鉴别点。［源:考研真题 GS-1997-060］

---

236. [A2型题 | 应用] batch033-E3-A2-011

> 模块：M3 | 页码：教材P734

60岁肥胖男性，新诊T2DM，eGFR 55，无急性并发症，首选的基础用药是？

- A. 二甲双胍的情况

- B. 胰岛素的情况 ✅
- C. 磺脲类的情况
- D. 噻唑烷二酮类
- E. 格列奈类的情况

答案：B

> 解析：二甲双胍改善胰岛素敏感性、不增体重、低血糖少，是T2DM一线基础用药，可单用或联合；eGFR 55（≥30）可用。教材P734。

---

237. [A2型题 | 理解] batch033-E3-A2-012

> 模块：M3 | 页码：教材P743

对鉴别糖尿病酮症酸中毒与高渗高血糖综合征意义最小的检查是

- A. 血糖水平测定
- B. 尿酮体定性检查
- C. 动脉血气分析检查
- D. 血清电解质检查 ✅
- E. 血浆有效渗透压测定

答案：D

> 解析：DKA血糖16.7-33.3、尿酮体强阳性、常有明显酸中毒；HHS血糖≥33.3、尿酮体阴性或弱阳性、一般无明显酸中毒。故血糖、尿酮体、血气分析均有助于两者鉴别；血电解质（尤其血钠）在两者均可正常、降低或升高，鉴别意义相对较小。［源:考研真题 GS-2016-073］

---

238. [A2型题 | 理解] batch033-E3-A2-013

> 模块：M3 | 页码：教材P729

糖尿病史12年，近期发现尿白蛋白排泄率增高、眼底见出血渗出。最可能的并发症类型是？

- A. 微血管病变（肾视网膜） ✅
- B. 大血管并发症的状态
- C. 急性酮症酸中毒的情况

- D. 低血糖反应的情况
- E. 并发感染的情况

答案：A

> 解析：糖尿病病史>10年易出现微血管并发症，尿白蛋白增高提示糖尿病肾脏病（DKD），眼底出血渗出提示视网膜病变，二者常并存；大血管病变主要累及心脑。教材P729。

---

239. [A2型题 | 应用] batch033-E3-A2-014

> 模块：M3 | 页码：教材P743

T1DM患者中断胰岛素2天出现昏迷，血糖33、血酮强阳性、呼吸深快。首要处理是？

- A. 补液+小剂量胰岛素
- B. 立即大量补碱的状态
- C. 直接补充葡萄糖
- D. 镇静的情况 ✅
- E. 仅抗感染的情况

答案：D

> 解析：此为DKA，治疗先补液恢复容量，再小剂量胰岛素（0.1U/kg·h）缓降糖、抑酮体；补碱仅限pH<6.9，过早补糖/大量补碱有害。教材P743。

---

240. [A3型题 | 应用] batch033-E3-A3-015

> 模块：M3 | 页码：教材P743

45岁T2DM，二甲双胍+饮食控制，近期感染后出现恶心、腹痛、深大呼吸，查血糖28、血酮+++，pH 7.10。当前最主要的内环境紊乱是？

- A. 糖尿病酮症酸中毒 ✅
- B. 高渗高血糖综合征
- C. 低血糖的情况
- D. 乳酸性酸中毒
- E. 高渗状态的情况

答案：A

> 解析：血糖高、血酮强阳性、pH降低（酸中毒）、深大呼吸，符合DKA；HHS以高渗、无明显酮症为特征，本例有酮症与酸中毒，故为DKA。教材P743。

---

241. [A4型题｜分析] batch033-E3-A4-016

> 模块：M3｜页码：教材P736

30岁T1DM，胰岛素治疗中突发出汗、震颤、意识模糊，急查血糖2.2 mmol/L。从糖尿病急症谱分析，最可能发生及首要处理原则是？

- A. 低血糖，立即补充葡萄糖 ✅
- B. 高血糖DKA，补液与胰岛素
- C. 高血糖HHS，大量补液
- D. 脑卒中，溶栓治疗的情况
- E. 感染，抗感染治疗的情况

答案：A

> 解析：胰岛素治疗中最主要不良反应是低血糖，血糖<2.8可昏迷；本例有交感兴奋表现且血糖2.2，为低血糖急症，须立即补糖。低血糖与DKA/HHS同属糖尿病急症，常被忽视。教材P724、P736。

---

242. [B1型题｜记忆] batch033-E3-B1-017

> 模块：M3｜页码：教材P736

1型糖尿病（T1DM）必须长期使用的药物是？

- A. 二甲双胍的情况
- B. 胰岛素的情况 ✅
- C. 磺脲类的情况
- D. α-糖苷酶抑制剂
- E. SGLT2抑制剂

答案：B

> 解析：T1DM为β细胞免疫破坏、胰岛素绝对缺乏，须外源胰岛素治疗；二甲双胍等为T2DM基础用药。教材P725、P736。

---

243. [B1型题｜记忆] batch033-E3-B1-018

> 模块：M3｜页码：教材P734

改善胰岛素敏感性、不增体重且eGFR<30时禁用的T2DM一线药物是？

- A. 二甲双胍的情况 ✅
- B. 胰岛素的情况
- C. 磺脲类的情况
- D. α-糖苷酶抑制剂
- E. SGLT2抑制剂

答案：A

> 解析：二甲双胍抑制肝糖输出、改善外周胰岛素敏感性，低血糖少，是T2DM基石；经肾排泄，eGFR<30禁用（乳酸性酸中毒风险）。教材P734。

---

244. [X型题｜理解] batch033-E3-X-019

> 模块：M3｜页码：教材P743

关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有

- A. 前 1~2 小时内输入 0.9% 氯化钠 1000~2000ml ✅
- B. 血糖降至 13.9mmol/L 时，补液需改用 5% 葡萄糖液或葡萄糖生理盐水
- C. 首次胰岛素静脉注射负荷量 10~20U，后静脉滴注每小时 0.1U/kg ✅
- D. 血 pH<7.1，HCO3-<5mmol/L 时需要补碱治疗 ✅

答案：ACD

> 解析：DKA失水量大，补液是关键，前1~2小时输入0.9%氯化钠1000~2000ml；当血糖降至13.9mmol/L时改用5%葡萄糖液或葡萄糖生理盐水并按每2~4g葡萄糖加1U胰岛素（故原述16.7mmol/L改糖不准确）。宜采用小剂量胰岛素，首次负荷10~20U、后0.1U/kg·h；当pH<7.1、HCO_3^-<5mmol/L时补碱。［源:考研真题 GS-2023-159］

245. [X型题｜理解] batch033-E3-X-020

> 模块：M3｜页码：教材P732

关于糖尿病的检查，下列提法正确的有

- A. 诊断糖尿病应测定静脉血浆血糖
- B. GHbA1c 主要反映近 2~3 个月血糖总水平 ✅
- C. 胰岛素和C肽测定主要用于评估胰岛β细胞功能 ✅
- D. 注射胰岛素的患者可通过测定 C 肽反映胰岛功能 ✅

答案：BCD

> 解析：诊断糖尿病依据静脉血浆血糖，血浆血糖比全血血糖高约15%（A表述为全血高于血浆，错误）。糖化血红蛋白（GHbA1c）反映近2~3个月血糖总水平（B对）。胰岛素和C肽测定主要反映基础和葡萄糖介导的胰岛素释放功能，而非诊断依据（C对）。C肽释放不受外源性胰岛素抗体干扰，注射胰岛素者测C肽可反映胰岛功能（D对）。 [源:考研真题 GS-2014-174]

---

246. [A1型题｜记忆] batch033-S3-A1-001

> 模块：M3｜页码：教材P820

系统性红斑狼疮（SLE）的本质是

- A. 免疫复合物介导的多系统病 ✅
- B. 细菌感染引起的关节炎症
- C. 仅局限于皮肤的慢性炎症
- D. 代谢障碍导致的骨病
- E. 关节软骨系统性退变

答案：A

> 解析：SLE是致病性自身抗体和免疫复合物介导、多系统受累的自身免疫病，好发于20~40岁育龄女性。教材P820。

---

247. [A1型题 | 记忆] batch033-S3-A1-002

> 模块：M3 | 页码：教材P822

系统性红斑狼疮最佳的筛查试验是

- A. 抗dsDNA
- B. 抗核抗体ANA ✅
- C. 抗Sm抗体
- D. 抗CCP抗体
- E. 抗rRNP抗体

答案：B

> 解析：ANA对SLE灵敏度近100%，为最佳筛查试验，但特异度仅约65%，不能单独确诊。教材P822。

---

248. [A1型题 | 记忆] batch033-S3-A1-003

> 模块：M3 | 页码：教材P822

对确诊系统性红斑狼疮和判断其活动性参考价值最大的抗体是

- A. 抗核抗体谱
- B. 抗Sm抗体
- C. 抗dsDNA ✅
- D. 抗RNP抗体
- E. 抗Ro抗体

答案：C

> 解析：抗dsDNA与抗Sm均为SLE标记性抗体，但抗Sm与活动性无关，抗dsDNA滴度与活动性相关，故对确诊和判断活动性价值最大。[源:考研真题 GS-2002-074]。教材P822。

---

249. [A1型题 | 记忆] batch033-S3-A1-004

> 模块：M3 | 页码：教材P822

下列与系统性红斑狼疮病情活动性无关的实验室检查是

- A. 血清C3、C4下降
- B. 外周血白细胞减少
- C. 抗dsDNA抗体升高
- D. 抗Sm抗体升高 ✅
- E. 红细胞沉降率加快

答案：D

> 解析：抗Sm抗体是SLE标记性抗体（特异度99%），但与疾病活动性无关；C3/C4下降、白细胞减少、抗dsDNA升高、血沉加快均提示活动。[源:考研真题 GS-2003-074]。教材P810、P822。

---

250. [A1型题｜记忆] batch033-S3-A1-005

> 模块：M3｜页码：教材P822

系统性红斑狼疮活动期，血清补体C3、C4水平较健康人通常表现为

- A. 较健康人明显升高
- B. 先升高后下降
- C. 无明显动态变化
- D. 仅C3轻度升高
- E. 较健康人明显下降 ✅

答案：E

> 解析：SLE活动期大量免疫复合物沉积消耗补体，C3、C4下降，是特异性反向活动性指标。教材P810、P822。

---

251. [A1型题｜理解] batch033-S3-A1-006

> 模块：M3｜页码：教材P821

系统性红斑狼疮特征性的皮肤表现是

- A. 面部蝶形红斑 ✅

- B. 类风湿性结节
- C. Gottron征
- D. 雷诺现象明显
- E. 皮肤红斑紫癜

答案：A

> 解析：蝶形红斑（鼻梁+双颧颊部）是SLE特征性皮疹，由真皮-表皮交界处免疫复合物沉积所致；类风湿结节为RA，Gottron征为皮肌炎。教材P820-821。

---

252. [A1型题 | 理解] batch033-S3-A1-007

> 模块：M3 | 页码：教材P822

系统性红斑狼疮患者皮肤活检时，最典型的发现是

- A. 真皮浅表部出血
- B. 表皮交界IC沉积 ✅
- C. 真皮深部出血
- D. 真皮内色素沉积
- E. 真皮深层IC沉积

答案：B

> 解析：SLE典型改变为皮肤真皮与表皮交界处免疫复合物沉积，免疫荧光见真皮浅层明亮荧光带（狼疮带）。[源:考研真题 GS-2004-046]。教材P822。

---

253. [A1型题 | 理解] batch033-S3-A1-008

> 模块：M3 | 页码：教材P820

系统性红斑狼疮的组织损伤主要所属的超敏反应类型是

- A. I型超敏反应
- B. II型超敏反应
- C. III型超敏反应 ✅
- D. IV型超敏反应

- E. 不属于上述类型

答案：C

> 解析：SLE组织损伤主要由免疫复合物介导，属III型变态反应（DNA-抗DNA复合物致血管和肾小球病变）；部分血细胞损伤经II型。[源:考研真题 GS-2013-051]。教材P820。

---

254. [A2型题 | 理解] batch033-S3-A2-009

> 模块：M3 | 页码：教材P823

女性，26岁，面部皮疹、光过敏、口腔溃疡，伴关节痛、蛋白尿。抗核抗体阳性、抗dsDNA阳性、补体C3下降。最可能的诊断是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 多发性肌炎
- C. 系统性硬皮病
- D. 系统性红斑狼疮 ✅
- E. 原发性干燥征

答案：D

> 解析：育龄女性+蝶形红斑+光敏+口腔溃疡+肾受累+ANA/抗dsDNA阳性+补体下降，满足临床+免疫学证据，符合SLE。教材P820-823。

---

255. [A2型题 | 理解] batch033-S3-A2-010

> 模块：M3 | 页码：教材P822

女性，32岁，确诊系统性红斑狼疮，辅助检查中最可能与病情相符的是

- A. 外周血破碎红细胞
- B. 抗GBM抗体阳性
- C. 红细胞80%形态正常
- D. 网织红细胞显著降低
- E. Coombs试验阳性 ✅

答案：E

> 解析：约10% SLE有Coombs试验阳性的溶血性贫血；破碎红细胞见于红细胞异形症，抗GBM抗体见于I型急进性肾炎，形态正常血尿提示非肾小球源性。[源:考研真题 GS-2010-075]。教材P821、P822。

---

256. [A2型题 | 理解] batch033-S3-A2-011

> 模块：M3 | 页码：教材P839

女性，28岁，反复下肢深静脉血栓、2次孕早期自发流产，血小板45×10^9/L。最可能的诊断是

- A. 抗磷脂综合征 ✅
- B. 免疫性血小板减少
- C. 弥散性血管内凝血
- D. 原发性易栓症
- E. 骨髓增生异常征

答案：A

> 解析：反复动/静脉血栓+习惯性流产+血小板减少，符合抗磷脂综合征，常继发于SLE活动期，抗磷脂抗体阳性。教材P821、P839。

---

257. [A2型题 | 应用] batch033-S3-A2-012

> 模块：M3 | 页码：教材P825

系统性红斑狼疮轻症患者的初始治疗，通常首选的基础用药是

- A. 环磷酰胺
- B. 硫酸羟氯喹 ✅
- C. 甲泼尼龙冲击
- D. 利妥昔单抗
- E. 血浆置换

答案：B

> 解析：轻症SLE以羟氯喹为基础用药，控制皮肤关节症状、减少复发；CTX/MMF用于脏器受累，生物制剂用于难治。教材P825。

---

258. [A2型题｜应用] batch033-S3-A2-013

> 模块：M3｜页码：教材P839

女性，26岁，左下肢肿胀疼痛1个月，曾多次流产，血小板45×10^9/L。为明确诊断最重要的检查是

- A. 血抗核抗体
- B. 血类风湿因子
- C. 血抗磷脂抗体 ✅
- D. 骨髓细胞学检查
- E. 凝血因子活性

答案：C

> 解析：育龄女性+下肢血栓+反复流产+血小板减少，考虑抗磷脂综合征，最重要检查是抗磷脂抗体；ANA用于SLE筛查，RF用于RA。[源:考研真题 GS-2023-056]。教材P821、P839。

---

259. [A2型题｜理解] batch033-S3-A2-014

> 模块：M3｜页码：教材P820

引起系统性红斑狼疮组织损害的主要物质是

- A. CD8淋巴细胞
- B. 苏木素小体
- C. 狼疮样细胞
- D. 致病自身抗体 ✅
- E. 血清补体C3

答案：D

> 解析：SLE由以抗核抗体为主的多种自身抗体引起，组织损伤与自身抗体存在有关；$CD4^+$T细胞参与发病而非$CD8^+$；苏木素小体、狼疮细胞为病变特征而非致损物质。[源:考研真题 GS-2018-038]。教材P820。

---

260. [A3型题 | 应用] batch033-S3-A3-015

> 模块：M3 | 页码：教材P823

女性，24岁，面部红斑、关节痛半年，近2个月出现眼睑及双下肢水肿、尿泡沫增多。尿蛋白(+++)，血清补体C3下降，抗dsDNA阳性。

- A. 腹部超声检查
- B. 骨髓穿刺
- C. 关节X线
- D. 胸部CT
- E. 肾穿刺活检 ✅

答案：E

> 解析：狼疮性肾炎诊断、分型、治疗与预后评估的金标准是肾活检；仅凭蛋白尿无法判断ISN/RPS分型，IV型弥漫增殖型最常见需强化免疫抑制。教材P823。

---

261. [A4型题 | 分析] batch033-S3-A4-016

> 模块：M3 | 页码：教材P825

女性，30岁，SLE确诊3年，近1个月出现大量蛋白尿（>3.5g/d）、水肿、血压升高，肾活检为IV型狼疮性肾炎。查体无感染征象。

- A. 单用羟氯喹控制症状
- B. 激素联合CTX/MMF ✅
- C. 仅用非甾体抗炎药
- D. 停用免疫抑制治疗
- E. 单用生物制剂治疗

答案：B

> 解析：IV型弥漫增殖型狼疮性肾炎伴大量蛋白尿、重要脏器受累，诱导缓解首选大剂量激素联合CTX或MMF；单用羟氯喹/NSAIDs不足，生物制剂用于难治病例。教材P823、P825。

---

262. [B1型题｜记忆] batch033-S3-B1-017

> 模块：M3｜页码：教材P822

对系统性红斑狼疮最具诊断价值、且滴度与疾病活动性相关的抗体是

- A. 抗dsDNA ✅
- B. 抗Sm抗体
- C. 抗核抗体谱
- D. 抗磷脂抗体
- E. 抗rRNP

答案：A

> 解析：抗dsDNA抗体是SLE标记性抗体且滴度与活动性相关；抗Sm虽特异但与活动无关，ANA为筛查，抗磷脂见于APS。教材P822。

---

263. [B1型题｜理解] batch033-S3-B1-018

> 模块：M3｜页码：教材P822

提示系统性红斑狼疮合并神经精神狼疮或疾病活动时，有意义的抗体是

- A. 抗dsDNA
- B. 抗Sm抗体
- C. 抗rRNP抗体 ✅
- D. ANA抗体
- E. 抗磷脂抗体

答案：C

> 解析：抗rRNP抗体阳性提示SLE活动期或神经精神狼疮（NP-SLE）；余选项用途不同。教材P822。

264. [X型题｜应用] batch033-S3-X-019

> 模块：M3｜页码：教材P823

根据系统性红斑狼疮分类标准，诊断需满足的条件包括

- A. 至少1条临床证据 ✅
- B. 至少1条免疫学证据 ✅
- C. 临床与免疫学缺一不可 ✅
- D. 必须存在关节畸形
- E. 必须肾活检证实

答案：ABC

> 解析：SLE分类标准强调至少1条临床+1条免疫学证据，二者缺一不可；并非必须关节畸形或肾活检（肾活检为独立路径之一）。教材P823。

---

265. [X型题｜应用] batch033-S3-X-020

> 模块：M3｜页码：教材P825

下列关于系统性红斑狼疮病情活动性与治疗的描述，正确的有

- A. 活动期补体C3、C4下降 ✅
- B. 抗dsDNA升高提示活动 ✅
- C. 糖皮质激素为首选快速抗炎药 ✅
- D. 脏器受累首选CTX/MMF ✅
- E. 蝶形红斑多伴明显瘙痒

答案：ABCD

> 解析：SLE活动期补体下降、抗dsDNA升高；激素首选快速抗炎，脏器受累诱导缓解用CTX/MMF；SLE皮疹通常无瘙痒，故E错。教材P821-825。

---

266. [A1型题 | 记忆] batch033-T3-A1-001

> 模块：M3 | 页码：教材P890

下列哪一个不是有机磷中毒时的毒蕈碱样（M样）表现？

- A. 恶心呕吐腹痛腹泻
- B. 多汗腺体分泌
- C. 肌肉纤维颤动 ✅
- D. 瞳孔明显缩小
- E. 心率明显减慢

答案：C

> 解析：M样症状为副交感兴奋：分泌多、瞳孔小、心率慢、平滑肌痉挛；肌肉颤动属烟碱样（N样）症状。教材P890。［源:考研真题 GS-1995-073］

---

267. [A1型题 | 记忆] batch033-T3-A1-002

> 模块：M3 | 页码：教材P891

引起瞳孔明显缩小的中毒是？

- A. 阿托品中毒
- B. 有机磷中毒 ✅
- C. 甲醇中毒
- D. 乙醇中毒
- E. 氰化物中毒

答案：B

> 解析：有机磷抑制胆碱酯酶使乙酰胆碱蓄积，兴奋虹膜环形肌M受体致瞳孔缩小；阿托品中毒则瞳孔扩大。教材P891。［源:考研真题 GS-2019-130］

---

268. [A1型题 | 记忆] batch033-T3-A1-003

> 模块：M3 | 页码：教材P891

有机磷中毒时，患者的呼吸气味常是？

- A. 烂苹果味
- B. 苦杏仁味
- C. 蒜臭味 ✅
- D. 腥臭味
- E. 酒味

答案：C

> 解析：有机磷杀虫药有大蒜臭味，中毒时呼出气常为蒜臭味；苦杏仁味见于氰化物，烂苹果味见酮症酸中毒。教材P891。［源:考研真题 GS-2018-130］

---

269. [A1型题 | 记忆] batch033-T3-A1-004

> 模块：M3 | 页码：教材P892

解除有机磷中毒时烟碱样毒性作用，首选？

- A. 阿托品
- B. 解磷定 ✅
- C. 美解眠
- D. 尼可刹米
- E. 甘露醇

答案：B

> 解析：解磷定等胆碱酯酶复活药可恢复真性胆碱酯酶活性，有效解除烟碱样（N样）症状；阿托品主要解除M样症状。教材P892。［源:考研真题 GS-1996-107］

---

270. [A1型题 | 理解] batch033-T3-A1-005

> 模块：M3 | 页码：教材P890

有机磷杀虫药中毒的主要发病机制是？

- A. 抑制乙酰胆碱酯酶 ✅

- B. 抑制细胞色素氧化酶
- C. 抑制含巯基酶
- D. 兴奋M受体
- E. 破坏红细胞膜

答案：A

> 解析：有机磷与胆碱酯酶结合形成磷酰化胆碱酯酶，使其丧失分解乙酰胆碱能力，乙酰胆碱大量蓄积产生中毒症状。教材P890。

---

271. [A1型题 | 理解] batch033-T3-A1-006

> 模块：M3 | 页码：教材P890

关于磷酰化胆碱酯酶的“老化”，正确的是？

- A. 可自发恢复活性
- B. 老化后不可逆 ✅
- C. 老化仅见于轻度中毒
- D. 复活药始终有效
- E. 与毒物剂量无关

答案：B

> 解析：磷酰化胆碱酯酶随时间延长部分变为老化型，不可逆，故须尽早使用胆碱酯酶复活药；中毒24~48小时后老化者复活药无效。教材P890。

---

272. [A1型题 | 理解] batch033-T3-A1-007

> 模块：M3 | 页码：教材P890

有机磷抑制胆碱酯酶后形成的稳定失活复合物是？

- A. 磷酰化胆碱酯酶 ✅
- B. 乙酰胆碱酯酶
- C. 游离胆碱
- D. 游离乙酸

- E. 磷脂酰胆碱

答案：A

> 解析：有机磷与真性胆碱酯酶酯解部位结合成稳定的磷酰化胆碱酯酶，使其失去分解乙酰胆碱能力。教材P890。

---

273. [A1型题 | 理解] batch033-T3-A1-008

> 模块：M3 | 页码：教材P891

急性有机磷中毒诊断最具意义的实验室检查是？

- A. 白细胞计数
- B. 血胆碱酯酶活力 ✅
- C. 血清转氨酶
- D. 血清肌酐
- E. 空腹血糖

答案：B

> 解析：全血胆碱酯酶活力是诊断有机磷中毒的特异性指标，对判断中毒程度、疗效和预后极为重要。教材P891。

---

274. [A2型题 | 应用] batch033-T3-A2-009

> 模块：M3 | 页码：教材P891

女性，20岁。误服有机磷农药后半小时入院。神志不清，皮肤潮湿多汗，面部肌肉束颤动，瞳孔缩小，双肺布满湿啰音。最可能的中毒程度是？

- A. 轻度
- B. 中度
- C. 重度 ✅
- D. 不能确定
- E. 极重度

答案：C

> 解析：神志不清（昏迷）伴M样与N样症状及肺水肿，符合重度中毒；重度ChE活力<30%。教材P891。［源:考研真题 GS-2015-068］

---

275. [A2型题｜应用] batch033-T3-A2-010

> 模块：M3｜页码：教材P893

女性，25岁。敌敌畏中毒、中度，血ChE 40%。除洗胃外应及早联用？

- A. 阿托品+氯解磷定 ✅
- B. 纳洛酮+氟马西尼
- C. 亚甲蓝+维生素C
- D. 依地酸钙钠+二巯丙醇
- E. 甘露醇+地塞米松

答案：A

> 解析：有机磷中毒应早期、足量、联合应用抗胆碱药（阿托品）与胆碱酯酶复活药（氯解磷定），中重度中毒须两者联用。教材P892。

---

276. [A2型题｜应用] batch033-T3-A2-011

> 模块：M3｜页码：教材P891

急性有机磷中毒下列表现中，能提示中度中毒的是？

- A. 出汗流涎
- B. 呕吐腹泻
- C. 胸背部肌肉颤动 ✅
- D. 瞳孔缩小
- E. 心率减慢

答案：C

> 解析：开始出现N样症状（肌颤）提示中度中毒；出汗流涎、呕吐腹泻、瞳孔缩小均为M样症状，见于轻度。教材P891。［源:考研真题 GS-2012-067］

277. [A2型题｜应用] batch033-T3-A2-012

> 模块：M3｜页码：教材P891

有机磷中毒经治疗胆碱能危象消失后第3天，突发颈屈肌无力和呼吸肌麻痹。最可能诊断？

- A. 中毒反跳现象
- B. 中间型综合征 ✅
- C. 迟发性多发神经病
- D. 阿托品中毒
- E. 急性脑出血

答案：B

> 解析：中间型综合征多发生于重度中毒后24~96小时，表现为颈屈肌和近端肌无力、脑神经受累及呼吸肌麻痹，ChE<30%。教材P891。

---

278. [A2型题｜理解] batch033-T3-A2-013

> 模块：M3｜页码：教材P892

男性，30岁。口服敌百虫后大汗、瞳孔缩小、呕吐，神志清。最适宜的洗胃液是？

- A. 2%碳酸氢钠
- B. 高锰酸钾液
- C. 清水冲洗液 ✅
- D. 0.3%过氧化氢
- E. 5%硫酸钠

答案：C

> 解析：敌百虫忌用2%碳酸氢钠（变敌敌畏）且忌用高锰酸钾，故口服敌百虫中毒常用清水洗胃。教材P892。

---

279. [X型题｜理解] batch033-T3-X-021

> 模块：M3｜页码：教材P892

治疗急性有机磷中毒时，下列属“阿托品化”表现的是？

- A. 瞳孔扩大 ✅
- B. 颜面潮红 ✅
- C. 心率减慢
- D. 肺部啰音消失 ✅
- E. 瞳孔缩小

答案：ABD

> 解析：阿托品化指征为瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、颜面潮红、心率增快、肺部湿啰音消失；心率减慢和瞳孔缩小为阿托品不足或中毒本身表现。教材P892。［源:考研真题 GS-2007-143］

---

280. [A2型题｜应用] batch033-T3-A2-015

> 模块：M3｜页码：教材P892

重度有机磷暴露者使用抗胆碱药物后出现瞳孔明显散大、烦躁、尿潴留。首先考虑？

- A. 阿托品用量不足
- B. 病情好转
- C. 阿托品中毒 ✅
- D. 氯解磷定过量
- E. 胆碱酯酶恢复

答案：C

> 解析：瞳孔明显扩大、神志模糊、烦躁、尿潴留等为阿托品中毒表现，应立即停用阿托品，与阿托品化不同。教材P892。

---

281. [A4型题 | 分析] batch033-T3-A4-016

> 模块：M3 | 页码：教材P891

男性，40岁。口服乐果后积极治疗，第5天好转，第7天突然再昏迷、肺水肿。最可能是？

- A. 迟发性多发神经病
- B. 反跳现象 ✅
- C. 中间型综合征
- D. 阿托品中毒
- E. 急性脑水肿

答案：B

> 解析：乐果、马拉硫磷等中毒病情好转后数日至1周可突然恶化，再次出现急性中毒症状，称反跳，与残留毒物重吸收或停药过早有关。教材P891。

---

282. [B1型题 | 记忆] batch033-T3-B1-017

> 模块：M3 | 页码：教材P890

属于烟碱样（N样）症状的是？

- A. 瞳孔缩小
- B. 大汗流涎
- C. 肌纤维颤动 ✅
- D. 意识障碍
- E. 肺水肿

答案：C

> 解析：N样症状为横纹肌神经肌肉接头处乙酰胆碱蓄积，表现为肌纤维颤动、肌无力乃至呼吸肌麻痹；其余多为M样或中枢表现。教材P890。

---

283. [B1型题 | 记忆] batch033-T3-B1-018

> 模块：M3 | 页码：教材P890

属于毒蕈碱样（M样）症状的是？

- A. 瞳孔缩小 ✅
- B. 大汗流涎
- C. 肌纤维颤动
- D. 意识障碍
- E. 肺水肿

答案：A

> 解析：M样症状为副交感末梢兴奋，瞳孔缩小、分泌增多、平滑肌痉挛；肌颤为N样，肺水肿为M样重状但此处以瞳孔缩小为代表。教材P890。

---

284. [X型题｜理解] batch033-T3-X-019

> 模块：M3｜页码：教材P890

有机磷中毒时的毒蕈碱样症状有？

- A. 腹痛、腹泻 ✅
- B. 大汗、流涎 ✅
- C. 肌纤维颤动
- D. 瞳孔缩小 ✅
- E. 呼吸肌麻痹

答案：ABD

> 解析：M样症状包括瞳孔缩小、腺体分泌增多（大汗流涎）、平滑肌痉挛（腹痛腹泻）；肌纤维颤动与呼吸肌麻痹属N样症状。教材P890。［源:考研真题 GS-2018-156］

---

285. [X型题｜理解] batch033-T3-X-020

> 模块：M3｜页码：教材P890

发生有机磷农药中毒时，可出现？

- A. 肌束颤动 ✅

- B. 瞳孔缩小 ✅
- C. 大汗淋漓 ✅
- D. 心率加速 ✅
- E. 尿潴留

答案：ABCD

> 解析：有机磷中毒M样表现为瞳孔缩小、大汗、心率减慢，N样表现为肌颤、心率血压增快；尿潴留为阿托品中毒表现而非有机磷本身。教材P890。［源:考研真题 GS-2008-156］

M4（40题）

286. [A1型题 | 记忆] batch033-D4-A1-001

> 模块：M4 | 页码：教材P374

十二指肠溃疡(DU)的好发部位是

- A. 十二指肠降部
- B. 十二指肠水平部
- C. 十二指肠球部 ✅
- D. 十二指肠升部
- E. 十二指肠空肠曲

答案：C

> 解析：DU好发于十二指肠球部(前/后壁多见)；GU好发于胃角、胃窦小弯。教材P374。

---

287. [A1型题 | 记忆] batch033-D4-A1-002

> 模块：M4 | 页码：教材P374

胃溃疡(GU)发病机制的主要特点是

- A. 侵袭因素(胃酸)增强
- B. 防御/屏障因素减弱 ✅

- C. 胃排空加快
- D. 胆汁分泌减少
- E. 前列腺素增多

答案：B

> 解析：GU以防御(屏障)减弱为主，基础胃酸正常或偏低；DU以侵袭(胃酸)增强为主。教材P374。

---

288. [A1型题 | 记忆] batch033-D4-A1-003

> 模块：M4 | 页码：教材P375

消化性溃疡确诊的首选检查是

- A. 胃镜+活检 ✅
- B. X线钡餐
- C. 腹部CT
- D. 腹部超声
- E. 血液化验

答案：A

> 解析：胃镜是溃疡诊断首选与金标准，可直视龛影、判断期别并活检排除胃癌；钡餐示龛影为次选。教材P375。

---

289. [A1型题 | 理解] batch033-D4-A1-004

> 模块：M4 | 页码：教材P378

消化性溃疡最常见的并发症是

- A. 出血 ✅
- B. 穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变
- E. 腹腔瘘管

答案：A

> 解析：出血最常见(15%-25%)，十二指肠溃疡更易出血；穿孔1%-5%，梗阻2%-4%，GU约1%癌变。教材P378。

---

290. [A1型题 | 理解] batch033-D4-A1-005

> 模块：M4 | 页码：教材P378

十二指肠溃疡并发穿孔的典型体征是

- A. 板状腹、肝浊音界消失 ✅
- B. 局限性反跳痛
- C. 肠鸣音仍活跃
- D. 移动性浊音阳性
- E. 皮肤巩膜黄染

答案：A

> 解析：穿孔致胃内容物入腹腔→急性弥漫性腹膜炎，表现为板状腹、肝浊音界缩小/消失、膈下游离气体。教材P378。

---

291. [A1型题 | 理解] batch033-D4-A1-006

> 模块：M4 | 页码：教材P374

阿司匹林引起 NSAID 溃疡的最主要致溃疡机制是

- A. 抑制COX-1
- B. 抑制COX-2
- C. 同时抑制两类COX ✅
- D. 局部刺激胃黏膜
- E. 增加胃黏膜血流灌注量

答案：C

> 解析：①非甾体抗炎药(NSAID)导致消化性溃疡的机制包括局部损害作用和系统作用两个方面，但以后者为主，故可首先排除D。②NSAID致溃疡的系统作用与其抑制环氧合酶(COX)有关，COX包括COX-1和COX-2，COX-1主要存在于胃黏膜组织，COX-2主要存在于炎症组织。阿司匹林为非选择性COX抑制剂，既可抑制COX-1，使胃肠道黏膜中经COX-1途径产生的具有细胞保护作用的内源性前列腺素合成减少，从而削弱胃十二指肠黏膜的防御机制，导致消化性溃疡(此为药物的副作用)；又可抑制COX-2，产生抗炎、解热、镇痛的作用(此为药物的治疗作用)。［源:考研真题GS-2017-050］

---

292. [A1型题｜理解] batch033-D4-A1-007

> 模块：M4｜页码：教材P377

下列关于胃、十二指肠溃疡病手术治疗的叙述， 正确的是

- A. 胃Ⅱ、Ⅲ型溃疡切除范围应≥60% ✅
- B. 胃肠吻合口以5~6cm为宜
- C. 毕Ⅱ式胃大部切除术后溃疡复发率较高
- D. 选择性迷走神经切断术不需加做胃引流手术
- E. 十二指肠溃疡应首选手术

答案：A

> 解析：①胃大部切除术是治疗消化性溃疡的常用术式，其切除范围是胃远端 2/3~3/4。一般来说，高泌酸的十二指肠溃疡和Ⅱ、Ⅲ型胃溃疡切除范围应不少于胃的 60%(A 对)，低泌酸的 Ⅰ型胃溃疡则可略小(50%左右)。②胃肠吻合口的大小以 3~4cm 为宜。③毕Ⅱ式胃大部切除术是将远端胃切除后，封闭十二指肠残端，残胃与上端空肠端侧吻合。因此即使切胃较多，也不至于造成术后胃肠吻合口张力过大，术后溃疡复发率较低。术后溃疡复发率高是毕 Ⅰ 式胃大部切除术的缺点。④选择性迷走神经切断术由于切断了支配胃窦部的鸦爪神经支，易导致术后胃潴留，需加做胃引流手术。不需加做胃引流手术的是高度选择性迷走神经切断术。［源:考研真题GS-2009-083］

---

293. [A1型题｜记忆] batch033-D4-A1-008

> 模块：M4｜页码：教材P374

下列胃溃疡相关叙述中，正确的是

- A. 95% 的胃溃疡好发于胃小弯 ✅

- B. Ⅱ型胃溃疡癌变的可能性最大
- C. 胃溃疡不易引起胆汁反流
- D. 胃溃疡的幽门螺杆菌检出率不到50%
- E. 伴胃炎者少,抗酸药物治疗效果好

答案：A

> 解析：①胃溃疡好发于胃小弯,占 95%(《内科学》为胃角和胃窦小弯)。②Ⅱ型胃溃疡靠近幽门,常合并十二指肠溃疡,癌变率较低。③胃溃疡幽门括约肌张力较低,常伴胆汁反流性胃炎。④胃溃疡幽门螺杆菌检出率为 80%~90%。⑤与十二指肠溃疡多由胃酸分泌过多所致的发病机制不同,胃溃疡多是胃黏膜保护性因素减弱所致,其基础胃酸稍增高或正常,甚至低于正常,因此制酸剂治疗效果不好。［源:考研真题 GS-2004-084］

---

294. [A2型题｜理解] batch033-D4-A2-009

> 模块：M4丨页码：教材P374

男性,30岁。空腹痛、夜间痛、进食后缓解2年。最可能的诊断是

- A. 胃溃疡病
- B. 十二指肠溃疡 ✅
- C. 慢性胃炎
- D. 胃部癌肿
- E. 慢性胆囊炎

答案：B

> 解析：空腹痛/夜间痛/进食缓解为DU典型节律(疼痛-进餐-缓解)；GU为餐后痛。教材P374。

---

295. [A2型题｜应用] batch033-D4-A2-010

> 模块：M4丨页码：教材P375

男性,60岁。餐后1小时上腹痛，胃镜示胃角溃疡，周边黏膜柔软、皱襞向溃疡集中。诊断为

- A. 胃溃疡病 ✅
- B. 十二指肠溃疡

- C. 胃部癌肿
- D. 慢性胃炎
- E. 反流性食管炎

答案：A

> 解析：餐后痛+胃角溃疡、周边黏膜柔软为良性GU特征；恶性溃疡边缘不规则、质硬、皱襞中断。教材P375。

---

296. [A2型题｜理解] batch033-D4-A2-011

> 模块：M4｜页码：教材P378

男性,45岁。十二指肠溃疡并大出血，血压不稳、四肢湿冷。首要处理是

- A. 三腔二囊管压迫
- B. 积极补液抗休克 ✅
- C. 急诊手术
- D. 胃镜止血
- E. 生长抑素静滴

答案：B

> 解析：溃疡大出血并休克、血压不稳时，首选积极补充血容量抗休克；待血压稳定后再胃镜止血/手术。教材P375-378。

---

297. [A2型题｜应用] batch033-D4-A2-012

> 模块：M4｜页码：教材P375

青年男性。排柏油样便2天，伴头晕、心慌。查体：血压降低、心率增快，无肝炎病史，肝、脾不大。该患者最可能的诊断是

- A. 胃部癌性病变
- B. 十二指肠溃疡 ✅
- C. 肝硬化食管静脉出血
- D. 急性胃黏膜炎症

- E. 食管贲门黏膜撕裂伤

答案：B

> 解析：①青年患者排柏油便2天，伴头晕、心慌、血压降低、心率增快，应诊断为上消化道大出血。十二指肠溃疡多见于青年人，胃癌常见于老年人，故答B而不是A。患者无肝炎病史，肝、脾不大，故肝硬化食管静脉曲张破裂出血的可能性较小。急性胃炎近期常有非甾体药物服用史，且出血量一般不大，不会导致休克，故不答D。②患者十二指肠溃疡大出血并休克，血压不稳，首选处理应是积极补充血容量，抗休克治疗。［源:考研真题 GS-2014-099］

---

298. [A2型题｜应用] batch033-D4-A2-013

> 模块：M4｜页码：教材P375

青年男性。反复夜间上腹痛、反酸，近日排黑便，大便隐血强阳性。最可能的诊断是

- A. 慢性胃黏膜炎症
- B. 胃溃疡性病变
- C. 十二指肠溃疡病 ✅
- D. 胃部癌性病变
- E. 胃泌素瘤所致多发溃疡

答案：C

> 解析：①夜间痛是十二指肠溃疡的典型表现，黑便、大便隐血强阳性为并发出血的表现。根据题干，本例应诊断为十二指肠溃疡并出血。慢性胃炎多无症状，有症状者常表现为上腹痛或不适，饱胀、恶心等，一般无夜间痛、反酸等症状。胃溃疡多表现为饱餐痛（进食—疼痛—缓解），少有夜间痛。胃癌无典型节律性腹痛的特点。②确诊十二指肠溃疡首选纤维胃镜检查。［源:考研真题 GS-2011-099］

---

299. [A2型题｜应用] batch033-D4-A2-014

> 模块：M4｜页码：教材P378

患者，男，35岁。6天前因溃疡病出血行毕Ⅱ式胃大部切除术，2天来上腹胀满，进食后半小时尤甚，常恶心、呕吐，吐出胆汁样液体，量较多，不含食物，呕吐后症状缓解。查体:轻度脱水，上腹略饱满，轻度压痛。最可能的诊断是

- A. 术后吻合口梗阻
- B. 输入袢急性梗阻 ✅
- C. 输出袢急性梗阻
- D. 早期倾倒综合征
- E. 吻合口水肿致排空延迟

答案：B

> 解析：①胃大部切除术后梗阻包括吻合口梗阻、输入袢梗阻和输出袢梗阻。根据题干，本例应诊断为慢性不全性输入袢梗阻（吐大量胆汁、几乎不含食物，呕吐后缓解）。②倾倒综合征多发生在进食后半小时左右，表现为心悸、出汗、恶心、腹泻等，与吐胆汁不符。［源:考研真题 GS-2008-084］

---

300. [A3型题｜应用] batch033-D4-A3-015

> 模块：M4｜页码：教材P377

男性,50岁。上腹痛呈节律性，胃镜示十二指肠球部溃疡，幽门螺杆菌阳性。为促使愈合并防止复发，治疗应

- A. PPI抑酸+根除Hp ✅
- B. 单纯外科手术治疗
- C. 单用抗酸药物治疗
- D. 暂时观察不予处理
- E. 单用中药方剂治疗

答案：A

> 解析：溃疡治疗三靶点：抑酸(PPI首选)、根除Hp(铋剂四联)、黏膜保护；Hp(+)者根除可显著降低复发。教材P377。

---

301. [A4型题｜分析] batch033-D4-A4-016

> 模块：M4｜页码：教材P378

男性,55岁。消化性溃疡史，突发刀割样上腹痛，全腹压痛、板状腹，肝浊音界消失，立位腹平片见膈下游离气体。最可能的诊断是

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡穿孔 ✅
- C. 幽门梗阻
- D. 溃疡癌变
- E. 急性胰腺炎

答案：B

> 解析：突发刀割样痛+板状腹+肝浊音界消失+膈下游离气体，是溃疡穿孔致急性弥漫性腹膜炎的典型三联征。教材P378。

---

302. [B1型题｜记忆] batch033-D4-B1-017

> 模块：M4｜页码：教材P374

胃溃疡(GU)的好发部位是

- A. 胃角/胃窦小弯 ✅
- B. 十二指肠球部
- C. 胃底区域
- D. 贲门区域
- E. 幽门管处

答案：A

> 解析：GU好发于胃角、胃窦小弯；DU好发于十二指肠球部，二者好发部位不同。教材P374。

---

303. [B1型题｜记忆] batch033-D4-B1-018

> 模块：M4｜页码：教材P378

十二指肠溃疡最少见、一般不予考虑的并发症是

- A. 出血
- B. 穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 癌变 ✅

- E. 瘘管形成

答案：D

> 解析：DU一般不癌变(癌变率≈0)，GU约1%癌变；出血最常见、DU更易出血。教材P378。

---

304. [X型题｜理解] batch033-D4-X-019

> 模块：M4｜页码：教材P374

消化性溃疡的发病机制涉及

- A. 胃酸、胃蛋白酶侵袭因素增强 ✅
- B. 幽门螺杆菌(Hp)感染 ✅
- C. NSAIDs抑制前列腺素 ✅
- D. 胃黏膜防御因素减弱 ✅
- E. 发病与情绪因素无关

答案：ABCD

> 解析：溃疡=侵袭>防御：侵袭(胃酸/胃蛋白酶/Hp/NSAIDs)增强或防御(黏液/碳酸氢盐/血流/前列腺素)减弱；精神刺激是常见诱因而非无关。教材P374。

---

305. [X型题｜理解] batch033-D4-X-020

> 模块：M4｜页码：教材P378

关于消化性溃疡并发症，正确的有

- A. 出血是最常见的并发症 ✅
- B. 十二指肠溃疡更易出血 ✅
- C. 穿孔可见膈下游离气体 ✅
- D. 幽门梗阻可致低钾低氯性碱中毒 ✅
- E. 十二指肠溃疡常发生癌变

答案：ABCD

> 解析：出血最常见(15%-25%)、DU易出血；穿孔见膈下气体；幽门梗阻呕吐宿食→丢酸丢钾→低钾低氯性碱中毒；DU一般不癌变。教材P378。

---

306. [A1型题｜记忆] batch033-R4-A1-001

> 模块：M4｜页码：教材P525

慢性肾脏病（CKD）的诊断标准中，肾脏结构或功能异常持续的时间至少应为

- A. 1周
- B. 1个月
- C. 3个月 ✅
- D. 6个月
- E. 12个月

答案：C

> 解析：CKD定义为肾脏结构/功能异常≥3个月，或GFR<60 ml/(min·1.73m²)持续≥3个月。教材P525。

---

307. [A1型题｜记忆] batch033-R4-A1-002

> 模块：M4｜页码：教材P525

根据K/DOQI分期，慢性肾脏病5期（终末期）的肾小球滤过率（GFR）范围是

- A. >90
- B. 60~89
- C. 30~44
- D. 15~29
- E. <15 ✅

答案：E

> 解析：CKD5期GFR<15 ml/(min·1.73m²)（或已透析），为终末期肾病（ESRD）。教材P525。

308. [A1型题｜记忆] batch033-R4-A1-003

> 模块：M4｜页码：教材P525

我国终末期肾病最常见的病因是

- A. 慢性肾小球肾炎 ✅
- B. 糖尿病肾病
- C. 高血压肾小动脉硬化
- D. 慢性间质性肾炎
- E. 梗阻性肾病

答案：A

> 解析：我国慢性肾衰竭最常见病因是慢性肾小球肾炎；发达国家以糖尿病肾病最常见。教材P525。

---

309. [A1型题｜记忆] batch033-R4-A1-004

> 模块：M4｜页码：教材P525

在发达国家，导致慢性肾衰竭最常见的病因是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 糖尿病肾病 ✅
- C. 高血压肾病
- D. 狼疮性肾炎
- E. 痛风性肾病

答案：B

> 解析：发达国家慢性肾衰竭最常见病因为糖尿病肾病；我国仍以慢性肾小球肾炎居首。教材P525。

---

310. [A1型题 | 记忆] batch033-R4-A1-005

> 模块：M4 | 页码：教材P528

慢性肾衰竭患者出现贫血，最主要的发病机制是

- A. 铁摄入或吸收不足
- B. 叶酸或B12缺乏
- C. 红细胞破坏溶血
- D. 促红细胞生成素（EPO）减少 ✅
- E. 急性失血性贫血

答案：D

> 解析：肾脏是EPO主要产生地，慢性肾衰竭时肾实质毁损致EPO减少，引起正细胞正色素性肾性贫血。教材P528。

---

311. [A1型题 | 记忆] batch033-R4-A1-006

> 模块：M4 | 页码：教材P531

慢性肾衰竭患者常见的电解质紊乱是

- A. 高钾、低钙、高磷、代谢性酸中毒 ✅
- B. 低钾与高钙紊乱征
- C. 低钾与低磷紊乱征
- D. 高钙与低磷紊乱征
- E. 低钠与高钙紊乱征

答案：A

> 解析：慢性肾衰竭典型紊乱为高钾、低钙、高磷、代谢性酸中毒（排钾排酸及骨化三醇减少）。教材P531。

---

312. [A1型题 | 理解] batch033-R4-A1-007

> 模块：M4 | 页码：教材P530

慢性肾脏病患者开始低蛋白饮食（0.6~0.8g/kg·d）的时机一般是

- A. CKD1期患者
- B. CKD2期患者
- C. CKD3期起至未透析 ✅
- D. 进入透析之后
- E. 任何分期均可

答案：C

> 解析：低蛋白饮食自CKD3期起至未透析者（0.6~0.8g/kg·d）；CKD1-2期为0.8~1.0，透析后需增至1.0~1.2。教材P530。

---

313. [A1型题 | 理解] batch033-R4-A1-008

> 模块：M4 | 页码：教材P525

患者，男，35岁。反复水肿伴血压高5年，近半年来夜尿增多，有时牙龈出血，口渴，气促，面色逐渐苍白，化验：血红蛋白65g/L，血肌酐707μmol/L。该患者血肌酐升高的最可能病因是

- A. 肾病综合征
- B. 慢性肾小球肾炎 ✅
- C. 高血压病肾损害
- D. 糖尿病肾病
- E. 多囊肾疾病

答案：B

> 解析：①血肌酐正常值约88~177μmol/L，本例达707μmol/L，应诊断为慢性肾衰竭尿毒症期。在我国慢性肾衰竭最常见的病因为慢性肾小球肾炎。患者水肿、蛋白尿10年，有消化道症状、出血倾向、贫血，应诊断为慢性肾小球肾炎合并肾衰竭。肾病综合征常表现为大量蛋白尿、血浆白蛋白<30g/L，很少发生肾衰竭，故不答A。患者无长期高血压病史，不能诊断为高血压病肾损害。糖尿病肾病常发生于糖尿病病史10年以上者，且有血糖升高，尿糖阳性，故不答D。[源:考研真题 GS-2013-102]

---

314. [A2型题｜理解] batch033-R4-A2-009

> 模块：M4｜页码：教材P525

患者，男，35岁。反复水肿伴血压高5年，近半年来夜尿增多，有时牙龈出血，口渴，气促，面色逐渐苍白，曾化验血红蛋白为65g/L，1天前稀便多次后逐渐神志不清。为明确昏迷原因，除全面查体外，首选的检查是

- A. 肝功能和血氨
- B. 抽血测血糖
- C. 骨髓穿刺
- D. 测定血肌酐 ✅
- E. 头颅CT

答案：D

> 解析：①中年男性反复水肿伴高血压5年，应考虑慢性肾脏病。近半年来夜尿增多、贫血、昏迷，可初步诊断为慢性肾衰竭尿毒症期。为明确昏迷原因，可首选血肌酐测定。②患者既往甲型肝炎已愈，不要据此误诊为肝性脑病。③题干未叙及糖尿病表现，不考虑低血糖或高渗状态。④血液病不会早期即出现肾衰竭和昏迷。[源:考研真题 GS-2009-070]

---

315. [A2型题｜理解] batch033-R4-A2-010

> 模块：M4｜页码：教材P531

男性，60岁。高血压病20余年，血压最高190/100mmHg，无自觉不适，未规律治疗。化验：尿蛋白(+)，血TC6.4mmol/L，LDL-C4.96mmol/L，Glu8.6mmol/L，Cr122μmol/L。该患者应首选的降压药物是

- A. 氨氯地平
- B. 吲达帕胺
- C. 比索洛尔
- D. 美托洛尔
- E. 培哚普利 ✅

答案：E

> 解析：①患者为重度高血压伴尿蛋白(+)、血糖增高、血脂异常、血肌酐轻度增高。培哚普利为ACEI，既可降压，又可改善胰岛素抵抗、减少尿蛋白、延缓肾功能恶化，为首选降压药；本例Cr未超过265μmol/L，可用ACEI。②氨氯地平、吲达帕胺、比索洛尔在本例合并症下不作为首选。[源:考研真题 GS-2021-045]

---

316. [A2型题｜理解] batch033-R4-A2-011

> 模块：M4｜页码：教材P528

女性,45岁。乏力、心慌、面色苍白半年,粪便隐血阳性。化验:Hb78g/L,MCV76fl,MCHC30%。最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血 ✅
- B. 肾性贫血
- C. 铁粒幼细胞性贫血
- D. 慢性病性贫血
- E. 巨幼细胞性贫血

答案：A

> 解析：①患者血红蛋白78g/L为中重度贫血，MCV<80fl、MCHC<32%为小细胞低色素性贫血，最常见为缺铁性贫血。粪便隐血阳性提示慢性失血，最可能为长期便血所致缺铁性贫血。②肾性贫血由EPO减少所致，多见于慢性肾衰竭，本例未提及肾功能异常，故不答B。[源:考研真题 GS-2014-105]

---

317. [A2型题｜应用] batch033-R4-A2-012

> 模块：M4｜页码：教材P525

慢性肾衰竭患者出现骨痛、骨折，X线示骨骼囊样缺损。最常见的肾性骨营养不良类型是

- A. 低转化性骨病（低下）
- B. 高转化性骨病（纤维囊性骨炎） ✅
- C. 骨软化症（软骨病）
- D. 骨再生不良（低下型）
- E. 骨质疏松症（疏松型）

答案：B

> 解析：肾性骨病以高转化性骨病（纤维囊性骨炎，PTH升高、破骨活跃）最常见；低转化性包括骨软化与骨再生不良。教材P525。

---

318. [A2型题｜应用] batch033-R4-A2-013

> 模块：M4｜页码：教材P530

慢性肾脏病3期患者行低蛋白饮食时，其中高生物价蛋白应占的比例约为

- A. 10%
- B. 30%
- C. 50% ✅
- D. 70%
- E. 90%

答案：C

> 解析：低蛋白饮食（0.6~0.8g/kg·d）中约50%应为高生物价蛋白（蛋、瘦肉、鱼、奶），并保障充足热量，必要时加α-酮酸。教材P530。

---

319. [A2型题｜应用] batch033-R4-A2-014

> 模块：M4｜页码：教材P528

慢性肾衰竭合并肾性贫血患者，治疗应首选

- A. 输注红细胞悬液
- B. 雄激素治疗
- C. 补充叶酸治疗
- D. 人促红素联合补铁 ✅
- E. 补充维生素B12

答案：D

> 解析：肾性贫血因EPO减少，治疗首选重组人EPO（rHuEPO）并同时补铁；输血仅用于重度或紧急。教材P528。

---

320. [A3型题｜分析] batch033-R4-A3-015

> 模块：M4｜页码：教材P525

男性，55岁，乏力、面色苍白、夜尿增多2年，近1周恶心、食欲差。血压160/95mmHg，贫血貌，血肌酐680μmol/L，血钾6.0mmol/L，双肾缩小。该临床表现最符合

- A. 急性肾损伤
- B. 前列腺增生
- C. 急性胃肠炎
- D. 缺铁性贫血
- E. 慢性肾衰竭 ✅

答案：E

> 解析：长期夜尿多、贫血、高血压、血肌酐显著升高、双肾缩小，符合慢性肾衰竭；急性肾损伤双肾多正常或增大。教材P525。

---

321. [A4型题｜应用] batch033-R4-A4-016

> 模块：M4｜页码：教材P533

慢性肾衰竭患者，GFR 12ml/min，伴难治性高钾血症、严重代谢性酸中毒及明显尿毒症症状。此时最适宜的治疗是

- A. 肾脏替代治疗（血液透析/腹膜透析） ✅
- B. 继续保守观察与等待
- C. 仅限饮食与营养控制
- D. 单纯中医药调理治疗
- E. 暂观察并作定期随访

答案：A

> 解析：GFR<15或CKD5期，合并药物难以控制的高钾、酸中毒、尿毒症症状时，应开始肾脏替代治疗（血透/腹透/移植）。教材P533。

---

322. [B1型题｜理解] batch033-R4-B1-017

> 模块：M4｜页码：教材P533

慢性肾衰竭最佳长期替代治疗方式是

- A. 血液透析
- B. 肾移植 ✅
- C. 腹膜透析
- D. 血浆置换
- E. 输血

答案：B

> 解析：肾移植是彻底替代肾脏功能的最佳长期方案；血透、腹透为维持生命手段。教材P533。

---

323. [B1型题｜理解] batch033-R4-B1-018

> 模块：M4｜页码：教材P533

老年或心血管状态不稳定患者较常选用的居家透析方式是

- A. 血液透析
- B. 肾移植
- C. 腹膜透析 ✅
- D. 血浆置换
- E. 输血

答案：C

> 解析：腹膜透析可在家进行、血流动力学影响较小，适用于老年或心血管不稳定者。教材P533。

---

324. [X型题｜理解] batch033-R4-X-019

> 模块：M4｜页码：教材P528

慢性肾衰竭时可出现的临床表现包括

- A. 肾性贫血表现 ✅
- B. 肾性骨病表现 ✅
- C. 代谢性酸中毒症 ✅
- D. 高钾血症发生 ✅
- E. 外周血白细胞显著增多

答案：ABCD

> 解析：慢性肾衰竭因EPO减少致肾性贫血，骨化三醇不足/PTH升高致肾性骨病，排酸排钾障碍致代谢性酸中毒与高钾血症；白细胞多不显著增多。教材P525-531。

---

325. [X型题｜应用] batch033-R4-X-020

> 模块：M4｜页码：教材P533

关于慢性肾衰竭的肾脏替代治疗，下列说法正确的有

- A. 血液透析是维持生命的重要手段 ✅
- B. 腹膜透析适用于部分居家患者 ✅
- C. 肾移植是彻底替代肾功能的最佳方式 ✅
- D. 每位患者均一律首选肾移植
- E. 替代治疗用于GFR<15或症状严重者 ✅

答案：ABCE

> 解析：替代治疗含血透、腹透、肾移植；肾移植最佳但需综合评估，并非每位患者一律首选；指征为GFR<15或药物难控的尿毒症症状/并发症。教材P533。

M5（20题）

326. [A1型题｜记忆] batch033-D5-A1-001

> 模块：M5丨页码：教材P379

早期胃癌是指癌组织

- A. 局限于黏膜层或黏膜下层 ✅
- B. 已浸润至肌层
- C. 穿透浆膜层外
- D. 已有远处转移
- E. 肿瘤直径>5cm

答案：A

> 解析：早期胃癌指癌限于黏膜或黏膜下层，不论有无淋巴结转移；浸润肌层为进展期。教材P379。

---

327. [A1型题｜记忆] batch033-D5-A1-002

> 模块：M5丨页码：教材P379

胃癌的首选诊断方法是

- A. 胃镜+活检 ✅
- B. 钡餐造影
- C. 腹部CT
- D. 腹部超声
- E. 肿瘤标志物

答案：A

> 解析：胃镜直视并可活检定性，是胃癌诊断首选与金标准；超声内镜用于T分期。教材P379。

---

328. [A1型题｜记忆] batch033-D5-A1-003

> 模块：M5｜页码：教材P379

Borrmann分型中，息肉状隆起的肿块型属于

- A. Ⅰ型 ✅
- B. Ⅱ型
- C. Ⅲ型
- D. Ⅳ型
- E. 0型

答案：A

> 解析：Borrmann Ⅰ型为息肉状隆起(肿块型)；Ⅱ局限溃疡；Ⅲ浸润溃疡；Ⅳ弥漫浸润(皮革胃)。教材P379。

---

329. [A1型题｜理解] batch033-D5-A1-004

> 模块：M5｜页码：教材P381

胃癌淋巴转移首先累及

- A. 胃周淋巴结 ✅
- B. 左锁骨上淋巴结
- C. 肝脏转移
- D. 肺脏转移
- E. 腹膜转移

答案：A

> 解析：胃癌淋巴转移通常先累及胃周淋巴结，左锁骨上(Virchow)淋巴结为远处转移征象。教材P381。

---

330. [A1型题｜记忆] batch033-D5-A1-005

> 模块：M5｜页码：教材P373

下列哪项属于胃癌的癌前情况

- A. 急性糜烂性胃炎
- B. 慢性非萎缩性胃炎
- C. 萎缩性胃炎伴肠化生 ✅
- D. 十二指肠溃疡
- E. 反流性食管炎

答案：C

> 解析：萎缩、肠化生、异型增生为胃癌癌前阶梯；慢性非萎缩性胃炎无明显癌变倾向。教材P373。

---

331. [A1型题 | 理解] batch033-D5-A1-006

> 模块：M5 | 页码：教材P379

皮革胃(革囊胃)对应的是Borrmann分型的

- A. Ⅰ型息肉状
- B. Ⅱ型局限溃疡
- C. Ⅲ型浸润溃疡
- D. Ⅳ型弥漫浸润 ✅
- E. 0型浅表

答案：D

> 解析：BorrmannⅣ型为弥漫浸润型，癌沿胃壁浸润致胃腔缩小、壁僵硬如皮革，即皮革胃。教材P379。

---

332. [A1型题 | 理解] batch033-D5-A1-007

> 模块：M5 | 页码：教材P379

胃癌最好发的部位是

- A. 胃底

- B. 胃体
- C. 胃窦 ✅
- D. 贲门
- E. 幽门

答案：C

> 解析：胃癌好发于胃窦(尤其胃角为中心)，其次为胃体、贲门；胃窦是Hp相关病变常见区域。教材P379。

---

333. [A1型题 | 记忆] batch033-D5-A1-008

> 模块：M5 | 页码：教材P379

下述哪项支持胃的恶性溃疡?

- A. 溃疡呈圆形、椭圆形
- B. 边缘整齐不隆起
- C. 底部较平坦规整
- D. 火山口状底部凹凸不平 ✅
- E. 皱襞向溃疡集中

答案：D

> 解析：①胃癌的溃疡直径常>2cm,不规则,呈火山口状,底部凹凸不平,边缘不整齐、隆起,周围黏膜皱襞中断,呈结节状肥厚。②A、B、C、E项均为消化性溃疡的特点。 [源:考研真题 GS-1999-040]

---

334. [A2型题 | 应用] batch033-D5-A2-009

> 模块：M5 | 页码：教材P379

男性,62岁。上腹无规律痛半年，伴消瘦、黑便。为明确诊断，首选

- A. 胃镜+活检 ✅
- B. 钡餐造影
- C. 腹部CT

- D. 腹部超声
- E. 肿瘤标志物

答案：A

> 解析：中老年无规律上腹痛+消瘦+黑便为胃癌警示征，首选胃镜+活检定性。教材P379。

---

335. [A2型题｜应用] batch033-D5-A2-010

> 模块：M5｜页码：教材P379

女性,55岁。消瘦、贫血，胃镜示胃窦溃疡边缘不规则、质硬、易出血。应考虑

- A. 胃溃疡病
- B. 胃部癌肿 ✅
- C. 十二指肠溃疡
- D. 慢性胃炎
- E. 胃憩室病变

答案：B

> 解析：溃疡边缘不规则、质硬、皱襞中断为恶性(癌性溃疡)特征；良性溃疡边缘整齐、底平滑。教材P379。

---

336. [A2型题｜理解] batch033-D5-A2-011

> 模块：M5｜页码：教材P379

男性,58岁。大便隐血持续阳性，伴消瘦、上腹不适。为进一步定性诊断，应

- A. 胃镜+活检 ✅
- B. 钡餐造影
- C. 肿瘤标志物
- D. 腹部CT
- E. 腹部超声

答案：A

> 解析：持续隐血阳性+消瘦提示胃癌可能，胃镜+活检是最重要定性检查。教材P379。

---

337. [A2型题｜理解] batch033-D5-A2-012

> 模块：M5｜页码：教材P379

中老年人出现无规律性上腹痛伴消瘦、贫血，应首先警惕的是

- A. 胃溃疡病
- B. 胃部癌肿 ✅
- C. 慢性胃炎
- D. 慢性胆囊炎
- E. 急性胰腺炎

答案：B

> 解析：中老年人无规律痛+进行性加重+消瘦贫血提示胃癌；良性溃疡多有周期性、节律性慢性病史。教材P379。

---

338. [A2型题｜应用] batch033-D5-A2-013

> 模块：M5｜页码：教材P373

女性，50岁。慢性萎缩性胃炎伴中重度异型增生。恰当的处理是

- A. 暂不处理定期观察
- B. 定期胃镜随访/必要时内镜下切除 ✅
- C. 单用抗菌药物控制
- D. 长期口服抗酸药物
- E. 无需外科手术治疗

答案：B

> 解析：中重度异型增生为高度癌变风险，需定期胃镜随访，重度者内镜下切除或手术。教材P373。

---

339. [A2型题｜应用] batch033-D5-A2-014

> 模块：M5｜页码：教材P379

男性，50岁。胃溃疡病史10年。近期上腹痛失去原有规律，药物治疗无效，体重下降。就目前资料考虑，最可能的诊断是

- A. 胃溃疡复发
- B. 胃溃疡癌变 ✅
- C. 合并胃泌素瘤
- D. 复合性溃疡
- E. 胃神经内分泌肿瘤

答案：B

> 解析：①胃溃疡的癌变率约为 1%，对于长期胃溃疡病史、年龄在45岁以上、体重下降，应警惕癌变。本例胃溃疡病史10年，近期腹痛失去规律，药物治疗无效，体重下降，应首先考虑胃溃疡癌变。胃溃疡复发腹痛规律不会改变，使用质子泵抑制剂应有效，体重不会下降，故不答A。胃泌素瘤常表现为顽固性消化性溃疡，一般无上腹部压痛，故不答C。复合性溃疡是指胃溃疡合并十二指肠溃疡，一般十二指肠溃疡先于胃溃疡发生，且常发生幽门梗阻。［源:考研真题 GS-2013-099］

---

340. [A3型题｜应用] batch033-D5-A3-015

> 模块：M5｜页码：教材P379

男性,60岁。上腹隐痛、消瘦，检查示胃角溃疡型病变。确诊依据是

- A. 典型症状
- B. 胃镜+活检病理 ✅
- C. 腹部CT
- D. 肿瘤标志物
- E. 钡餐造影

答案：B

> 解析：胃癌确诊依赖胃镜直视+活组织病理检查；影像与标志物仅辅助分期与随访。教材P379。

---

341. [A4型题｜分析] batch033-D5-A4-016

> 模块：M5｜页码：教材P381

女性,58岁。胃癌根治术后复查发现一侧锁骨上方质硬、固定的肿大结节。最提示

- A. 局部炎症反应
- B. 左锁骨上淋巴结转移 ✅
- C. 锁骨上淋巴结结核
- D. 淋巴结反应性增生
- E. 正常解剖变异

答案：B

> 解析：左锁骨上Virchow淋巴结接收胃淋巴回流，胃癌可经胸导管逆转移至此处，质硬固定提示转移。教材P381。

---

342. [B1型题｜记忆] batch033-D5-B1-017

> 模块：M5｜页码：教材P379

癌组织局限于黏膜或黏膜下层，不论有无淋巴结转移，称为

- A. 早期胃癌 ✅
- B. 进展期胃癌
- C. 原位癌
- D. 远处转移癌
- E. 淋巴结转移癌

答案：A

> 解析：早期胃癌定义为癌限于黏膜或黏膜下层；超过黏膜下层至肌层为进展期。教材P379。

---

343. [B1型题｜理解] batch033-D5-B1-018

> 模块：M5｜页码：教材P379

癌组织广泛累及胃壁全层、胃腔缩小僵硬呈皮革样，对应的Borrmann分型是

- A. Ⅰ型隆起
- B. Ⅱ型局限溃疡
- C. Ⅲ型浸润溃疡
- D. Ⅳ型弥漫浸润 ✅
- E. 0型浅表

答案：D

> 解析：BorrmannⅣ型为弥漫浸润型(皮革胃)；Ⅰ隆起、Ⅱ局限溃疡、Ⅲ浸润溃疡。教材P379。

---

344. [X型题｜理解] batch033-D5-X-019

> 模块：M5｜页码：教材P379

下列有关胃的良性与恶性溃疡鉴别要点的叙述，正确的是

- A. 早期溃疡型胃癌单凭内镜所见不难与良性溃疡鉴别
- B. 活组织检查可以确定良性或恶性溃疡 ✅
- C. 即使内镜下诊断为良性溃疡且活检阴性，仍有漏诊恶性溃疡的可能 ✅
- D. 胃镜复查溃疡愈合不是鉴别良性或恶性溃疡的可靠依据 ✅

答案：BCD

> 解析：胃良、恶性溃疡的鉴别很重要。早期的溃疡型胃癌在内镜下很难与良性溃疡相鉴别，可多处取活组织检查，以资鉴别。任何检查都不能保证100%准确，内镜下诊断为胃溃疡，即使活检阴性，仍可能为假阴性，而漏诊胃癌。复查胃镜溃疡愈合只能作为良、恶性溃疡鉴别的辅助诊断方法，而不是确诊依据。［源:考研真题 GS-2005-143］

---

345. [X型题｜理解] batch033-D5-X-020

> 模块：M5｜页码：教材P379

男性，62岁，胃溃疡多年，2个月来上腹痛发作频繁，无规律，食欲下降。该患者需要进行的检查有

- A. 大便潜血(隐血)检查 ✅

- B. 胃酸浓度测定 ✅
- C. 胃镜检查并取活检 ✅
- D. 腹部立位平片

答案：ABC

> 解析：①老年患者，胃溃疡多年，2个月来上腹痛发作频繁、无规律，食欲下降，应考虑是否癌变，因此可作大便隐血检查（胃溃疡呈间歇性阳性，阳性率40%~70%；胃癌呈持续性阳性，阳性率约95%）；胃酸测定（胃癌常低胃酸）；胃镜检查并取活检（最重要的定性检查）。②腹部平片可用于胃溃疡穿孔的诊断，不适用于胃癌和胃溃疡的鉴别，故不答D。［源：考研真题 GS-2005-149］

M6（20题）

346. [A1型题｜记忆] batch033-D6-A1-001

> 模块：M6｜页码：教材P388

溃疡性结肠炎活动期结肠镜下最具特征性的表现是？

- A. 连续性弥漫性黏膜糜烂与隐窝脓肿 ✅
- B. 干酪样坏死（结核特征）
- C. 嗜酸性粒细胞弥漫浸润
- D. 黏膜下层非干酪样肉芽肿
- E. 节段性纵行溃疡（CD）

答案：A

> 解析：溃疡性结肠炎（UC）病变位于黏膜及黏膜下层，呈连续性、弥漫性分布，镜下特征为黏膜糜烂、浅溃疡与隐窝脓肿；节段性纵行溃疡与非干酪样肉芽肿为克罗恩病表现，干酪样坏死见于肠结核。教材P388。

---

347. [A1型题｜记忆] batch033-D6-A1-002

> 模块：M6｜页码：教材P392

克罗恩病最常累及的部位是？

- A. 直肠与乙状结肠
- B. 末端回肠及邻近右侧结肠 ✅
- C. 全结肠连续性分布
- D. 胃与十二指肠
- E. 脾曲与肝曲分布

答案：B

> 解析：克罗恩病（CD）好发于末端回肠及邻近右侧结肠，呈节段性、全层受累；直肠乙状结肠连续性受累为溃疡性结肠炎特点。教材P392。

---

348. [A1型题 | 记忆] batch033-D6-A1-003

> 模块：M6 | 页码：教材P391

治疗病变局限于结肠的轻、中型溃疡性结肠炎，应首选的药物是？

- A. 英夫利昔单抗
- B. 甲硝唑
- C. 柳氮磺吡啶 ✅
- D. 布地奈德
- E. 硫唑嘌呤

答案：C

> 解析：柳氮磺吡啶为普通5-氨基水杨酸（5-ASA）制剂，口服后大部分达结肠，经肠菌分解为5-ASA而发挥局部抗炎作用，适用于病变局限在结肠的轻、中度溃疡性结肠炎；布地奈德、美沙拉嗪控释剂更适于回结肠型克罗恩病，硫唑嘌呤为免疫抑制剂。教材P391。[源:考研真题GS-2008-143]

---

349. [A1型题 | 记忆] batch033-D6-A1-004

> 模块：M6 | 页码：教材P392

克罗恩病最常见的并发症是？

- A. 急性肠穿孔

- B. 消化道大出血
- C. 中毒性巨结肠
- D. 肠梗阻 ✅
- E. 腹腔内脓肿

答案：D

> 解析：克罗恩病因肠壁全层炎症、肠腔狭窄，最常见并发症为肠梗阻（发生率约40%），其次为腹腔内脓肿；中毒性巨结肠多见于暴发型或重症溃疡性结肠炎。教材P392。[源:考研真题 GS-2013-143]

---

350. [A1型题 | 理解] batch033-D6-A1-005

> 模块：M6 | 页码：教材P388

下列关于溃疡性结肠炎并发症的叙述，最少见的是？

- A. 中毒性巨结肠
- B. 直肠结肠癌变
- C. 直肠结肠大量出血
- D. 并发肠梗阻
- E. 并发肠瘘形成 ✅

答案：E

> 解析：溃疡性结肠炎病变多限于黏膜与黏膜下层，很少深及肌层，故并发瘘管形成少见；瘘管形成是克罗恩病的特征性表现。中毒性巨结肠多见于重症，癌变与大量出血亦可见。教材P388。[源:考研真题 GS-2001-062]

---

351. [A1型题 | 理解] batch033-D6-A1-006

> 模块：M6 | 页码：教材P390

对于疑似炎症性肠病患者，确诊与评估黏膜病变最重要、最常用的检查是？

- A. 结肠镜加活组织检查 ✅
- B. 粪便病原学培养

- C. 腹部立位X线平片
- D. 血清肿瘤标志物
- E. 腹部B型超声

答案：A

> 解析：结肠镜加活组织检查可直接观察黏膜连续性或节段性分布、浅溃疡/隐窝脓肿或纵行溃疡/非干酪样肉芽肿，是确诊溃疡性结肠炎与克罗恩病最重要、最常规的手段。教材P390。

---

352. [A1型题 | 理解] batch033-D6-A1-007

> 模块：M6 | 页码：教材P392

克罗恩病的特征性病理改变是？

- A. 隐窝脓肿与浅溃疡
- B. 非干酪样肉芽肿 ✅
- C. 阿米巴滋养体
- D. 嗜酸性粒细胞浸润
- E. 干酪样肉芽肿

答案：B

> 解析：克罗恩病镜下可见非干酪样肉芽肿、纵行或裂隙性溃疡、鹅卵石样改变；隐窝脓肿见于溃疡性结肠炎，干酪样肉芽肿见于肠结核。教材P392。

---

353. [A1型题 | 理解] batch033-D6-A1-008

> 模块：M6 | 页码：教材P388

溃疡性结肠炎活动期最具特征的大便性状是？

- A. 陶土样便
- B. 柏油样黑便
- C. 黏液脓血便 ✅
- D. 糊状便含少量脓血
- E. 水样腹泻

答案：C

> 解析：溃疡性结肠炎黏膜糜烂渗出，活动期表现为黏液脓血便伴里急后重；克罗恩病多为糊状便、脓血少见，肠结核与肠易激综合征一般无脓血。教材P388。

---

354. [A2型题 | 理解] batch033-D6-A2-009

> 模块：M6 | 页码：教材P388

女性，28岁。反复腹泻、黏液脓血便1年余，左下腹隐痛、便后缓解，抗菌药物治疗无效。内镜示自直肠起连续性黏膜充血、浅表糜烂。最可能的诊断是？

- A. 肠结核病变
- B. 慢性细菌性痢疾
- C. 肠易激综合征
- D. 溃疡性结肠炎 ✅
- E. 克罗恩肠炎

答案：D

> 解析：青年女性，慢性黏液脓血便、左下腹隐痛、便后缓解，抗菌无效，结肠镜示直肠乙状结肠连续性浅溃疡，符合溃疡性结肠炎；克罗恩病多累及末端回肠、脓血少见，慢性菌痢粪便培养阳性、抗菌有效。教材P388。

---

355. [A2型题 | 理解] batch033-D6-A2-010

> 模块：M6 | 页码：教材P392

男性，30岁。腹痛、腹泻、间断低热3年，右下腹压痛，结肠镜见回肠末段跳跃性分布、纵行溃疡、鹅卵石样黏膜。最可能的诊断是？

- A. 溃疡型肠结核
- B. 肠伤寒
- C. 缺血性结肠炎
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 克罗恩病 ✅

答案：E

> 解析：回肠末段跳跃性病变、纵行溃疡、鹅卵石样黏膜为克罗恩病特征；溃疡性结肠炎好发于直肠乙状结肠且病变连续，溃疡型肠结核为横带状溃疡、伴干酪样肉芽肿。教材P392。

---

356. [A2型题｜理解] batch033-D6-A2-011

> 模块：M6｜页码：教材P390

女性，35岁。反复腹痛、排便习惯改变2年，大便多为糊状、无脓血，夜间不痛，各项检查未见器质性病变。最可能的诊断是？

- A. 肠易激综合征 ✅
- B. 慢性细菌性痢疾
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 克罗恩肠炎
- E. 肠结核病变

答案：A

> 解析：肠易激综合征为功能性肠病，糊状便、绝无脓血、无器质性病变、夜间不痛；而炎症性肠病及肠结核多有脓血或器质性改变。教材P390。

---

357. [A2型题｜应用] batch033-D6-A2-012

> 模块：M6｜页码：教材P391

男性，22岁。溃疡性结肠炎急性发作，每日排便10余次、大量黏液脓血便，伴发热、心率102次/分。该患者目前首选的治疗药物是？

- A. 口服抗生素
- B. 糖皮质激素 ✅
- C. 5-氨基水杨酸
- D. 微生态益生菌
- E. 蒙脱石散剂

答案：B

> 解析：重度溃疡性结肠炎（>6次/日、便血明显、发热、心率增快）诱导缓解首选糖皮质激素；5-ASA适用于轻中度，难治或激素依赖者才考虑免疫抑制剂或生物制剂。教材P391。

---

358. [A2型题｜应用] batch033-D6-A2-013

> 模块：M6｜页码：教材P392

克罗恩病患者随访中出现阵发性右下腹痛、腹胀、停止排气排便，立位腹平片见阶梯状液气平面。最可能的并发症是？

- A. 消化道大出血
- B. 中毒性巨结肠
- C. 肠梗阻 ✅
- D. 腹腔脓肿
- E. 肠穿孔

答案：C

> 解析：克罗恩病最常见并发症为肠梗阻，表现为腹痛、腹胀、停止排气排便及X线阶梯状液气平面；腹腔脓肿多有发热、压痛包块，穿孔为急性腹膜炎。教材P392。

---

359. [A2型题｜应用] batch033-D6-A2-014

> 模块：M6｜页码：教材P390

溃疡性结肠炎患者合并膝关节疼痛与结节性红斑，经结肠切除后症状消退。这些肠外表现属于？

- A. 必定进展为强直性脊柱炎者
- B. 提示合并原发性硬化性胆管炎者
- C. 结肠切除后关节损害仍不可逆
- D. 随肠炎控制或结肠切除可缓解者 ✅
- E. 与肠炎完全无关联者

答案：D

> 解析：外周关节炎、结节性红斑、坏疽性脓皮病、巩膜外层炎、前葡萄膜炎、口腔溃疡等肠外表现，可随结肠炎控制或结肠切除而缓解；骶髂关节炎、强直性脊柱炎、原发性硬化性胆管炎则相对独立、常共存。教材P390。[源:考研真题 GS-2009-067]

---

360. [A3型题 | 应用] batch033-D6-A3-015

> 模块：M6 | 页码：教材P388

男性，26岁。反复黏液脓血便3年，加重1周。每日排便8-10次、量多黏液脓血，体温38.2℃、心率98次/分，血红蛋白92g/L，血沉35mm/h。该患者的临床分型最可能是？

- A. 中度溃疡性结肠炎
- B. 轻度溃疡性结肠炎
- C. 急性细菌性痢疾
- D. 克罗恩病活动期
- E. 重度溃疡性结肠炎 ✅

答案：E

> 解析：按病情严重程度，排便>6次/日、明显黏液脓血便、体温>37.8℃、心率>90次/分、血红蛋白<100g/L提示重度溃疡性结肠炎；中度介于轻重度之间，轻度≤3次/日、便血轻。教材P388。

---

361. [A4型题 | 分析] batch033-D6-A4-016

> 模块：M6 | 页码：教材P392

女性，40岁。腹泻伴低热半年，结肠镜见回盲部溃疡，活检示干酪样肉芽肿，PPD强阳性，伴咳嗽。与克罗恩病鉴别最关键的依据是？

- A. 干酪样肉芽肿与抗结核治疗有效 ✅
- B. 病变呈节段性分布
- C. 常伴发瘘管形成
- D. 非干酪样肉芽肿形成
- E. 病变位于末端回肠

答案：A

> 解析：回盲部干酪样肉芽肿、PPD强阳性、抗结核治疗有效提示肠结核；克罗恩病为非干酪样肉芽肿、抗结核治疗无效。二者均可节段分布、出现瘘管，故鉴别关键在于肉芽肿性质与抗结核疗效。教材P392。

---

362. [B1型题｜记忆] batch033-D6-B1-017

> 模块：M6｜页码：教材P388

溃疡性结肠炎病变的分布特征是？

- A. 全胃肠道均匀分布
- B. 连续性、弥漫性 ✅
- C. 节段性、跳跃性
- D. 局限性于末端回肠
- E. 仅累及直肠

答案：B

> 解析：溃疡性结肠炎病变从直肠向近端连续性、弥漫性蔓延，主要累及黏膜与黏膜下层；克罗恩病呈节段性、跳跃性分布。教材P388。

---

363. [B1型题｜记忆] batch033-D6-B1-018

> 模块：M6｜页码：教材P392

克罗恩病区别于溃疡性结肠炎的特征性表现是？

- A. 好发于直肠乙状结肠
- B. 中毒性巨结肠
- C. 常形成瘘管 ✅
- D. 黏液脓血便
- E. 病变连续性分布

答案：C

> 解析：瘘管形成为克罗恩病特征性表现，源于肠壁全层透壁性炎症与穿透；溃疡性结肠炎限于黏膜层，瘘管罕见。教材P392。

364. [X型题｜理解] batch033-D6-X-019

> 模块：M6｜页码：教材P388

下列关于溃疡性结肠炎并发症的叙述，正确的有？

- A. 中毒性巨结肠 ✅
- B. 结直肠癌变 ✅
- C. 肠出血 ✅
- D. 肠穿孔 ✅
- E. 胰腺假性囊肿

答案：ABCD

> 解析：约5%重症溃疡性结肠炎可并发中毒性巨结肠；病程>20年癌变风险增高10-15倍；肠大出血发生率约3%，肠穿孔多与中毒性巨结肠相关。胰腺假性囊肿与本病无关。教材P388。[源:考研真题 GS-2017-156]

---

365. [X型题｜应用] batch033-D6-X-020

> 模块：M6｜页码：教材P391

关于炎症性肠病药物治疗，下列说法正确的有？

- A. 轻中度溃疡性结肠炎首选5-氨基水杨酸 ✅
- B. 重度溃疡性结肠炎诱导缓解可用糖皮质激素 ✅
- C. 克罗恩病难治可选用抗TNF-α生物制剂 ✅
- D. 柳氮磺吡啶通过全身广泛吸收起效
- E. 氨基水杨酸制剂在结肠局部发挥作用 ✅

答案：ABCE

> 解析：轻中度UC首选5-ASA（如柳氮磺吡啶、美沙拉嗪）于结肠局部抗炎；重度用糖皮质激素；难治CD可用抗TNF-α等生物制剂。柳氮磺吡啶口服后大部分达结肠经肠菌分解起效，并非全身广泛吸收。教材P391。

M7（20题）

366. [A1型题｜记忆] batch033-D7-A1-001

> 模块：M7｜页码：教材P405

非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）疾病谱的正确顺序是？

- A. 脂肪变→脂肪性肝炎→肝纤维化→肝硬化 ✅
- B. 肝炎→脂肪变→纤维化→肝癌
- C. 肝硬化→脂肪变→肝炎→纤维化
- D. 脂肪性肝炎→单纯性脂肪变→肝癌
- E. 纤维化→脂肪变→肝硬化

答案：A

> 解析：NAFLD谱系为单纯性脂肪变性（NAFL）→非酒精性脂肪性肝炎（NASH）→肝纤维化→肝硬化→肝癌，其中NAFL与NASH阶段可部分逆转。教材P405。

---

367. [A1型题｜记忆] batch033-D7-A1-002

> 模块：M7｜页码：教材P405

诊断非酒精性脂肪肝（NAFLD）的首要条件是？

- A. 依赖血清病毒标志物
- B. 排除饮酒及其他已知肝病病因 ✅
- C. 需常规行肝穿刺活检
- D. 转氨酶呈持续显著升高
- E. 多已进展至肝硬化

答案：B

> 解析：NAFLD为排他性加代谢相关性诊断，需先排除酒精性、病毒性、药物性等肝病病因，再结合代谢危险因素与影像学脂肪浸润。教材P405。

---

368. [A1型题 | 记忆] batch033-D7-A1-003

> 模块：M7 | 页码：教材P406

非酒精性脂肪性肝病患者通过减重改善肝脂肪变，所需减轻体重的比例约为？

- A. 1%-2%
- B. 3%-5% ✅
- C. 10%-15%
- D. 20%-25%
- E. 30%以上

答案：B

> 解析：减重3%-5%即可减少肝脂肪变；减重7%-10%可改善肝损伤（酶学）及部分NASH炎症。教材P406。

---

369. [A1型题 | 记忆] batch033-D7-A1-004

> 模块：M7 | 页码：教材P406

非酒精性脂肪性肝病患者为改善肝损伤与血清酶学，建议减轻体重的比例约为？

- A. 25%以上
- B. 15%-20%
- C. 7%-10% ✅
- D. 3%-5%
- E. 1%-2%

答案：C

> 解析：减重7%-10%可改善肝损伤（ALT等酶学）及部分脂肪性肝炎炎症；3%-5%仅改善脂肪变。教材P406。

---

370. [A1型题 | 理解] batch033-D7-A1-005

> 模块：M7 | 页码：教材P406

长期大量饮酒所致酒精性肝病，其血清氨基转移酶的典型特征是？

- A. 碱性磷酸酶一定升高
- B. γ-谷氨酰转移酶一定正常
- C. AST/ALT比值常大于2 ✅
- D. AST/ALT比值常小于1
- E. ALT升高显著而AST正常

答案：C

> 解析：酒精性肝病因线粒体损伤，AST升高较ALT明显，AST/ALT比值常>2；NAFLD多为AST/ALT<1。教材P406。

---

371. [A1型题 | 理解] batch033-D7-A1-006

> 模块：M7 | 页码：教材P406

非酒精性脂肪性肝病患者血清氨基转移酶的特点是？

- A. ALT与AST均显著降低
- B. 碱性磷酸酶一定成倍升高
- C. γ-谷氨酰转移酶一定正常
- D. AST/ALT比值常小于1 ✅
- E. AST/ALT比值常大于2

答案：D

> 解析：NAFLD患者AST/ALT常<1，与酒精性肝病（>2）不同；肝酶可轻中度升高但不特异。教材P406。

---

372. [A1型题 | 理解] batch033-D7-A1-007

> 模块：M7 | 页码：教材P406

酒精性肝病治疗最根本的措施是？

- A. 长期应用保肝药

- B. 常规使用糖皮质激素
- C. 积极抗病毒治疗
- D. 定期肝穿刺活检
- E. 严格彻底戒酒 ✅

答案：E

> 解析：戒酒是酒精性肝病的根本治疗，轻中度戒酒后可显著改善；重症酒精性肝炎才考虑糖皮质激素加营养支持。教材P406。

---

373. [A1型题 | 理解] batch033-D7-A1-008

> 模块：M7 | 页码：教材P405

判断非酒精性脂肪性肝病患者是否存在脂肪性肝炎与纤维化，最可靠的检查是？

- A. 肝穿刺活组织检查 ✅
- B. 腹部B型超声检查
- C. 血清ALT酶学测定
- D. FibroScan瞬时弹性成像
- E. 血清AST/ALT比值

答案：A

> 解析：影像学（超声）可发现脂肪浸润但不能区分单纯脂肪变与NASH/纤维化；肝穿刺活检是判断炎症、气球样变与纤维化程度的金标准。教材P405。

---

374. [A2型题 | 理解] batch033-D7-A2-009

> 模块：M7 | 页码：教材P405

男性，45岁。体检发现ALT轻度升高，BMI 30，2型糖尿病史5年，无饮酒史，超声示肝弥漫性回声增强。最可能的诊断是？

- A. 药物性肝损伤
- B. 非酒精性脂肪性肝病 ✅
- C. 酒精性肝病

- D. 慢性乙型肝炎
- E. 自身免疫性肝炎

答案：B

> 解析：肥胖、2型糖尿病、无饮酒史、超声明亮肝、ALT升高，符合非酒精性脂肪性肝病（代谢相关）；酒精性肝病有饮酒史且AST/ALT>2。教材P405。

---

375. [A2型题｜理解] batch033-D7-A2-010

> 模块：M7｜页码：教材P406

男性，50岁。长期每日饮酒，近半年乏力、食欲减退，AST 120U/L、ALT 50U/L，GGT升高，MCV增大。最可能的诊断是？

- A. 原发性胆汁性胆管炎
- B. Wilson病
- C. 酒精性肝病 ✅
- D. 非酒精性脂肪性肝病
- E. 病毒性肝炎

答案：C

> 解析：长期饮酒史、AST/ALT>2、GGT升高、MCV增大支持酒精性肝病；NAFLD通常AST/ALT<1且无大量饮酒。教材P406。

---

376. [A2型题｜理解] batch033-D7-A2-011

> 模块：M7｜页码：教材P406

女性，38岁。诊断为非酒精性脂肪性肝炎，建议生活方式干预。为改善肝损伤，最应强调的目标是？

- A. 停用所有运动
- B. 高蛋白极低热量长期节食
- C. 立即开始糖皮质激素
- D. 减轻体重7%-10% ✅

- E. 每日饮酒一两

答案：D

> 解析：NASH患者以减重控代谢为治本之策，减重7%-10%可改善肝损伤与酶学；戒酒（即使非酒精性亦限酒）、运动、控制血糖血脂为辅。教材P406。

---

377. [A2型题｜应用] batch033-D7-A2-012

> 模块：M7｜页码：教材P405

患者腹胀、乏力，超声示脂肪肝，但HBsAg阳性、HBV DNA高载量，ALT明显升高。此时首先应考虑的诊断是？

- A. 非酒精性脂肪性肝病
- B. 酒精性肝病
- C. 自身免疫性肝炎
- D. 药物性肝损伤
- E. 病毒性肝炎（乙型） ✅

答案：E

> 解析：NAFLD为排他性诊断，须先排除病毒性等病因；HBsAg阳性、HBV DNA高、ALT明显升高提示病毒性肝炎，不能仅凭影像脂肪肝诊断NAFLD。教材P405。

---

378. [A2型题｜应用] batch033-D7-A2-013

> 模块：M7｜页码：教材P406

非酒精性脂肪性肝病患者经半年减重治疗后复查，最能直接反映肝内脂质沉积改善的指标是？

- A. 肝脏超声脂肪浸润减轻 ✅
- B. 血清脂肪酶升高
- C. 凝血酶原时间延长
- D. 总胆红素翻倍
- E. 甲胎蛋白升高

答案：A

> 解析：减重3%-5%即可改善肝脂肪变，复查超声脂肪浸润减轻是直接反映；其余指标与脂肪变改善无直接关系。教材P406。

---

379. [A2型题 | 应用] batch033-D7-A2-014

> 模块：M7 | 页码：教材P406

下列哪组表现最支持代谢相关脂肪性肝病的诊断？

- A. 近期使用抗结核药物
- B. 肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压 ✅
- C. 有长期大量饮酒史者
- D. HBsAg阳性携带
- E. 抗线粒体抗体阳性者

答案：B

> 解析：代谢相关脂肪性肝病（MASLD）需具备代谢危险因素之一（超重/肥胖、2型糖尿病、血脂异常、高血压）；饮酒、病毒、自身免疫、药物则为其他肝病病因。教材P405。

---

380. [A3型题 | 应用] batch033-D7-A3-015

> 模块：M7 | 页码：教材P405

男性，52岁。代谢综合征、ALT持续升高、超声明亮肝，拟进一步评估是否存在脂肪性肝炎。此时最适宜的检查是？

- A. 肝脏CT平扫
- B. 胃镜检查
- C. 肝穿刺活组织检查 ✅
- D. 重复腹部超声
- E. 血清甲胎蛋白

答案：C

> 解析：影像不能区分NAFL与NASH，疑脂肪性肝炎或纤维化时需肝穿刺活检明确炎症与纤维化程度。教材P405。

---

381. [A4型题｜分析] batch033-D7-A4-016

> 模块：M7｜页码：教材P405

两名肝酶升高患者，甲无乙醇摄入史、AST/ALT 0.8、超声明亮肝；乙每日摄入乙醇、AST/ALT 2.4、GGT升高。关于两者区分，下列说法最准确的是？

- A. 二者均需立即肝穿刺活检
- B. 甲应首选糖皮质激素治疗
- C. 乙的根本治疗应为减重
- D. 甲脂肪肝、乙酒精肝，看饮酒史与比值 ✅
- E. 二者均属病毒性肝炎范畴

答案：D

> 解析：NAFLD与酒精性肝病鉴别要点为饮酒史与AST/ALT比值（NAFLD<1，酒精性>2）；酒精性根本治疗为戒酒，NAFLD以减重控代谢为主，均不常规首选激素或肝穿刺。教材P405。

---

382. [B1型题｜记忆] batch033-D7-B1-017

> 模块：M7｜页码：教材P405

单纯性脂肪变性（NAFL）阶段的特点是？

- A. 基本不可逆
- B. 必然进展为肝癌
- C. 等同于肝硬化
- D. 必须肝移植
- E. 病变可逆 ✅

答案：E

> 解析：单纯性脂肪变性（NAFL）为可逆阶段；一旦进展至肝纤维化-肝硬化则基本不可逆。教材P405。

383. [B1型题｜记忆] batch033-D7-B1-018

> 模块：M7｜页码：教材P417

已形成的肝硬化（假小叶、再生结节）的特点是？

- A. 属不可逆病变 ✅
- B. 完全可逆过程
- C. 仅需饮食调理即可恢复
- D. 等同于单纯性脂肪变
- E. 不会进展为肝癌

答案：A

> 解析：肝硬化以假小叶形成与结构重构为标志，属不可逆终局；NAFL/NASH阶段可逆，越过纤维化则难回退。教材P417。

---

384. [X型题｜理解] batch033-D7-X-019

> 模块：M7｜页码：教材P406

关于非酒精性脂肪性肝病的治疗，下列说法正确的有？

- A. 减重与运动为基石 ✅
- B. 减重3%-5%改善肝脂肪变 ✅
- C. 减重7%-10%改善肝损伤酶学 ✅
- D. 彻底戒酒是根本治疗
- E. 保肝药物可作辅助 ✅

答案：ABCE

> 解析：NAFLD治疗以生活方式干预（减重加运动）为基石，减重3%-5%改善脂肪变、7%-10%改善酶学，保肝药为辅；戒酒是酒精性肝病的根本治疗。教材P406。

---

385. [X型题｜应用] batch033-D7-X-020

> 模块：M7｜页码：教材P405

非酒精性脂肪性肝病与酒精性肝病的鉴别要点包括？

- A. 长期饮酒史 ✅
- B. AST/ALT比值 ✅
- C. GGT与MCV变化 ✅
- D. 代谢综合征背景 ✅
- E. 抗核抗体滴度

答案：ABCD

> 解析：二者鉴别依靠饮酒史、AST/ALT比值（NAFLD<1、酒精性>2）、GGT升高、MCV增大及代谢综合征背景；抗核抗体用于自身免疫性肝病。教材P405。

M8（20题）

386. [A1型题｜记忆] batch033-D8-A1-001

> 模块：M8｜页码：教材P417

我国肝硬化的最常见病因是？

- A. 乙型肝炎等病毒性肝炎 ✅
- B. 长期大量饮酒
- C. 非酒精性脂肪性肝病
- D. 胆汁淤积性病变
- E. 血吸虫性感染

答案：A

> 解析：我国肝硬化以病毒性肝炎（乙型肝炎为主）最常见；酒精性肝硬化在西方更常见。教材P417。

---

387. [A1型题 | 记忆] batch033-D8-A1-002

> 模块：M8 | 页码：教材P418

肝硬化最具特征性的病理改变是？

- A. 胆囊壁水肿增厚
- B. 假小叶形成伴肝窦毛细血管化 ✅
- C. 单纯肝细胞水肿
- D. 汇管区轻度炎症
- E. 肝包膜增厚明显

答案：B

> 解析：假小叶形成与肝窦毛细血管化是肝硬化的特征性、不可逆病理标志。教材P418。

---

388. [A1型题 | 记忆] batch033-D8-A1-003

> 模块：M8 | 页码：教材P419

肝硬化腹水形成的最决定性因素是？

- A. 抗利尿激素灭活减弱
- B. 肝淋巴回流障碍
- C. 门静脉高压 ✅
- D. 低白蛋白血症
- E. 继发性醛固酮增多

答案：C

> 解析：门静脉高压使腹腔内脏血管床静水压升高、组织液漏入腹腔，是腹水形成的决定性因素；低蛋白、RAAS/ADH激活等协同参与。教材P419。

---

389. [A1型题 | 记忆] batch033-D8-A1-004

> 模块：M8 | 页码：教材P420

肝硬化最常见的并发症是？

- A. 自发性细菌性腹膜炎
- B. 肝肾综合征
- C. 原发性肝癌
- D. 上消化道出血 ✅
- E. 肝性脑病发生

答案：D

> 解析：肝硬化最常见并发症为上消化道出血（多为食管胃底静脉曲张破裂）；最严重并发症与最常见死因均为肝性脑病。教材P420。[源:考研真题 GS-2004-064]

---

390. [A1型题 | 理解] batch033-D8-A1-005

> 模块：M8 | 页码：教材P420

肝硬化最严重、也是最常见死亡原因的并发症是？

- A. 上消化道出血
- B. 自发性细菌性腹膜炎
- C. 肝肾综合征
- D. 肝脏恶性肿瘤
- E. 肝性脑病发生 ✅

答案：E

> 解析：肝性脑病是最严重并发症，也是肝硬化最常见死因，由氨中毒等引起；上消化道出血最常见但经抢救可控制。教材P420。

---

391. [A1型题 | 理解] batch033-D8-A1-006

> 模块：M8 | 页码：教材P419

提示门脉高压且最具诊断价值的体征是？

- A. 食管胃底静脉曲张 ✅
- B. 可见肝掌体征
- C. 出现蜘蛛痣

- D. 肝病面容表现
- E. 出现杵状指

答案：A

> 解析：食管胃底静脉曲张是门静脉高压最具诊断价值的体征，破裂可致大出血；肝掌、蜘蛛痣反映肝功能减退（雌激素灭活减少）。教材P419。

---

392. [A1型题 | 理解] batch033-D8-A1-007

> 模块：M8 | 页码：教材P425

肝硬化腹水利尿治疗的首选药物是？

- A. 布美他尼
- B. 螺内酯 ✅
- C. 呋塞米单用
- D. 氢氯噻嗪
- E. 甘露醇

答案：B

> 解析：腹水治疗常联合保钾利尿（螺内酯，结构与醛固酮相似、竞争性拮抗）与排钾利尿（呋塞米），螺内酯为首选。教材P425。

---

393. [A1型题 | 理解] batch033-D8-A1-008

> 模块：M8 | 页码：教材P424

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血时，首选降低门静脉压力的药物是？

- A. 硝酸甘油制剂
- B. 多巴胺类药物
- C. 生长抑素（或奥曲肽） ✅
- D. 垂体后叶素单用
- E. 普通肝素抗凝

答案：C

> 解析：食管胃底静脉曲张出血首选生长抑素或奥曲肽，收缩内脏血管、减少门静脉血流、降低门脉压；特利加压素亦可。教材P424。

---

394. [A2型题 | 理解] batch033-D8-A2-009

> 模块：M8 | 页码：教材P418

男性，55岁。乙肝病史20年，近半年腹胀、下肢水肿，查体见蜘蛛痣、肝掌、脾大、移动性浊音阳性。最可能的诊断是？

- A. 原发性肝癌
- B. 酒精性肝病
- C. 布加综合征
- D. 肝硬化失代偿期 ✅
- E. 慢性乙型肝炎稳定期

答案：D

> 解析：乙肝病史加蜘蛛痣肝掌（雌激素灭活减少）加脾大加腹水，提示肝硬化失代偿期（肝功能减退合并门静脉高压）。教材P418。

---

395. [A2型题 | 理解] batch033-D8-A2-010

> 模块：M8 | 页码：教材P421

男性，65岁。肝炎病史15年，呕血、黑便3天，半天来躁动不安、意识模糊，前胸可见蜘蛛痣。该患者意识障碍首先考虑的原因是？

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 急性肾损伤
- C. 急性脑血管病
- D. 肺性脑病
- E. 肝性脑病 ✅

答案：E

> 解析：肝炎后肝硬化基础上上消化道出血（食管胃底静脉曲张破裂）是肝性脑病常见诱因；出血后血氨升高致意识障碍，蜘蛛痣提示肝病背景。教材P421。[源:考研真题 GS-2019-052]

---

396. [A2型题 | 理解] batch033-D8-A2-011

> 模块：M8 | 页码：教材P420

肝硬化腹水患者突发发热、腹痛、腹水迅速增多，腹水检查白细胞>500×10⁶/L、中性粒细胞>250×10⁶/L。最可能的诊断是？

- A. 自发性细菌性腹膜炎 ✅
- B. 肝肾综合征
- C. 肝性脑病发生
- D. 肝癌结节破裂
- E. 门静脉血栓形成

答案：A

> 解析：自发性细菌性腹膜炎（SBP）见于肝硬化腹水，表现为发热、腹痛、腹水骤增，腹水PMN>250×10⁶/L，多为革兰阴性杆菌，需抗生素治疗。教材P420。

---

397. [A2型题 | 应用] batch033-D8-A2-012

> 模块：M8 | 页码：教材P421

肝硬化患者出现嗜睡、行为异常、定向力障碍、腱反射亢进。按肝性脑病分期，最可能处于？

- A. 潜伏期（0期）
- B. 前驱期（1期）
- C. 昏迷前期（2期） ✅
- D. 昏睡期（3期）
- E. 昏迷期（4期）

答案：C

> 解析：嗜睡、行为异常、定向力障碍、腱反射亢进为肝性脑病2期（昏迷前期）表现；1期仅性格改变、睡眠倒错，3期昏睡可唤醒，4期昏迷。教材P421。

---

398. [A2型题｜应用] batch033-D8-A2-013

> 模块：M8｜页码：教材P420

肝硬化患者上消化道出血后尿量明显减少，血肌酐升高、血钠降低、尿钠减少，肾脏无器质性病变。最可能的诊断是？

- A. 播散性血管内凝血
- B. 肝肾综合征 ✅
- C. 急性肾小管坏死
- D. 肾前性氮质血症
- E. 尿路感染

答案：B

> 解析：肝肾综合征为功能性肾衰，见于严重门脉高压加有效血容量不足，表现为少尿无尿、稀释性低钠、尿钠减少，肾无器质病变。教材P420。

---

399. [A2型题｜应用] batch033-D8-A2-014

> 模块：M8｜页码：教材P425

肝硬化顽固性腹水行大量放腹水治疗，每放出1000ml腹水宜补充白蛋白约？

- A. 100g
- B. 50g
- C. 20g
- D. 8g ✅
- E. 1g

答案：D

> 解析：大量放腹水可联合输注白蛋白，一般每放出1000ml腹水补充白蛋白约8g，以维持有效循环血量、减少并发症。教材P425。

400. [A3型题 | 应用] batch033-D8-A3-015

> 模块：M8 | 页码：教材P425

男性，51岁。肝硬化4年，呕血、黑便2天，半天来意识模糊、躁动。为清除肠道内积血、减少氨吸收，最宜选用的灌肠液是？

- A. 温热生理盐水
- B. 生理盐水加抗生素
- C. 弱酸性灌肠液 ✅
- D. 弱碱性灌肠液
- E. 碱性肥皂水

答案：C

> 解析：上消化道出血后血氨升高诱发肝性脑病，NH3在酸性环境下易转化为NH4+而减少吸收，故宜用弱酸性溶液灌肠清除积血、降低血氨；肥皂水（弱碱性）会增加氨吸收。教材P425。[源:考研真题 GS-2018-052]

---

401. [A4型题 | 分析] batch033-D8-A4-016

> 模块：M8 | 页码：教材P424

男性，48岁。乙肝肝硬化，突发大量呕血、黑便，收缩压85/50mmHg，心率120次/分，胃镜示食管胃底静脉曲张破裂。关于其处理，下列说法最合理的是？

- A. 直接行TIPS分流术首选
- B. 首选急诊外科手术治疗
- C. 仅口服质子泵抑制剂治疗
- D. 先补液抗休克再用生长抑素并止血 ✅
- E. 立即三腔二囊管持续压迫

答案：D

> 解析：食管胃底静脉曲张破裂出血应首先补充血容量抗休克，再用生长抑素（或奥曲肽）降低门脉压，并在24-48小时内急诊内镜套扎/硬化剂止血；三腔二囊管为≤24小时桥梁，TIPS易诱发肝性脑病，手术非首选。教材P424。

402. [B1型题｜记忆] batch033-D8-B1-017

> 模块：M8｜页码：教材P421

肝性脑病扑翼样震颤可见于？

- A. 仅4期
- B. 仅0期
- C. 各期均可见
- D. 仅潜伏期
- E. 1-3期 ✅

答案：E

> 解析：扑翼样震颤见于肝性脑病1-3期，4期（昏迷）无法引出；也可见于尿毒症、肺性脑病，非肝病特异。教材P421。

---

403. [B1型题｜记忆] batch033-D8-B1-018

> 模块：M8｜页码：教材P419

血清-腹水白蛋白梯度（SAAG）≥11g/L提示？

- A. 门静脉高压性腹水 ✅
- B. 结核性腹水
- C. 癌性渗出腹水
- D. 自发性细菌性腹膜炎
- E. 胰源性腹水

答案：A

> 解析：SAAG≥11g/L提示门静脉高压性腹水（如肝硬化）；<11g/L多见于结核、肿瘤等。教材P419。

---

404. [X型题｜理解] batch033-D8-X-019

> 模块：M8｜页码：教材P419

肝硬化门静脉高压的临床表现包括？

- A. 脾大与脾功能亢进 ✅
- B. 食管胃底静脉曲张 ✅
- C. 腹水液形成 ✅
- D. 出现肝掌征 ✅
- E. 扑翼样震颤

答案：ABCD

> 解析：门静脉高压表现为脾大脾亢、食管胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张与腹水；肝掌属肝功能减退（雌激素灭活减少），扑翼样震颤属肝性脑病。教材P419。

---

405. [X型题｜应用] batch033-D8-X-020

> 模块：M8｜页码：教材P421

关于肝性脑病氨中毒学说，下列说法正确的有？

- A. NH3能透过血脑屏障而NH4+相对不能 ✅
- B. 低钾碱中毒可增加氨的毒性 ✅
- C. 酸性环境利于NH4+形成减少NH3吸收 ✅
- D. 严重腹泻致血容量不足可增高血氨 ✅
- E. 高血糖会增加氨的神经毒性

答案：ABCD

> 解析：游离NH3能透过血脑屏障发挥神经毒性，NH4+相对不能；低钾碱中毒促使NH4+转为NH3而增毒，酸性环境使NH3转为NH4+减少吸收，严重腹泻致肾前性氮质血症可升高血氨；低血糖时脑去氨活动停滞、氨毒性增加。教材P421。[源:考研真题 GS-2002-062]

M9（20题）

406. [A1型题 | 记忆] batch033-D9-A1-001

> 模块：M9 | 页码：教材P427

原发性肝癌中最常见的组织学类型是？

- A. 肝细胞癌（HCC） ✅
- B. 肝内胆管细胞癌
- C. 混合型肝癌
- D. 肝母细胞瘤
- E. 转移性肝癌

答案：A

> 解析：原发性肝癌约90%为肝细胞癌（HCC），其次为肝内胆管细胞癌与混合型。教材P427。

---

407. [A1型题 | 记忆] batch033-D9-A1-002

> 模块：M9 | 页码：教材P427

我国原发性肝癌最主要的病因背景是？

- A. 血吸虫感染
- B. 乙型肝炎病毒感染 ✅
- C. 丙型肝炎病毒感染
- D. 酒精性肝病
- E. 非酒精性脂肪肝

答案：B

> 解析：我国约90%肝细胞癌有HBV感染背景，多沿“乙肝→肝硬化→肝癌”三部曲发生。教材P427。

---

408. [A1型题 | 记忆] batch033-D9-A1-003

> 模块：M9 | 页码：教材P428

在排除慢性活动性肝炎、妊娠与生殖腺胚胎瘤后，高度提示原发性肝癌的甲胎蛋白（AFP）水平是？

- A. >20ng/ml
- B. >50ng/ml
- C. >100ng/ml
- D. >400ng/ml ✅
- E. >1000ng/ml

答案：D

> 解析：排除上述情况后AFP>400ng/ml高度提示肝细胞癌；轻度升高需结合影像动态观察，不能单凭AFP确诊。教材P428。

---

409. [A1型题 | 记忆] batch033-D9-A1-004

> 模块：M9 | 页码：教材P428

肝癌高危人群（乙肝、肝硬化等）的常规筛查首选组合是？

- A. 肝穿刺活检术
- B. 血清CEA检测
- C. 血清AFP联合肝脏超声 ✅
- D. 增强CT检查
- E. 肝动脉造影术

答案：C

> 解析：高危人群应每6个月行血清AFP加肝脏超声筛查；超声为筛查首选，增强CT/MRI为明确诊断首选影像。教材P428。

---

410. [A1型题 | 理解] batch033-D9-A1-005

> 模块：M9 | 页码：教材P428

确诊原发性肝癌最可靠的方法是？

- A. 腹部超声检查
- B. 增强CT检查
- C. 磁共振MRI
- D. 肝穿刺活组织检查 ✅
- E. 血清AFP测定

答案：D

> 解析：在超声或CT引导下的肝穿刺活检是确诊原发性肝癌最可靠的方法；AFP与影像为重要但不具确诊地位。教材P428。

---

411. [A1型题 | 理解] batch033-D9-A1-006

> 模块：M9 | 页码：教材P428

肝细胞癌增强CT/MRI的典型表现为？

- A. 全灶持续均匀强化
- B. 病灶边缘环形强化
- C. 平扫无强化低密度灶
- D. 延迟期中心填充征
- E. 动脉期强化门脉期减退（快进快出） ✅

答案：E

> 解析：肝癌多为肝动脉供血，增强CT/MRI呈“快进快出”（动脉期强化、门脉期/延迟期减退），是明确诊断的影像特征。教材P428。

---

412. [A1型题 | 理解] batch033-D9-A1-007

> 模块：M9 | 页码：教材P429

肝功能代偿、肿瘤局限无远处转移的原发性肝癌，获得长期生存的首选治疗是？

- A. 外科手术切除治疗 ✅
- B. 经动脉化疗栓塞（TACE）
- C. 射频消融局部治疗
- D. 肝移植手术治疗方式
- E. 全身化学药物治疗

答案：A

> 解析：手术切除是肝癌获得长期生存的首选治疗手段，适用于肝功能代偿、肿瘤局限者；TACE为最常用非手术方法。教材P429。

---

413. [A1型题 | 理解] batch033-D9-A1-008

> 模块：M9 | 页码：教材P429

不宜手术的原发性肝癌患者，最常用、经典的局部治疗是？

- A. 口服靶向药单用
- B. 经动脉化疗栓塞（TACE） ✅
- C. 全身静脉化疗术
- D. 单纯放射治疗法
- E. 肝移植手术治疗

答案：B

> 解析：TACE经肝动脉注入化疗药与栓塞剂，堵闭肿瘤血供，是最常用的非手术治疗；肝癌对全身化疗不敏感，一般不行常规全身化疗。教材P429。

---

414. [A2型题 | 理解] batch033-D9-A2-009

> 模块：M9 | 页码：教材P427

男性，50岁。乙肝病史20年，近2个月肝区持续性钝痛、消瘦，查体肝大、质硬、表面结节状。最可能的诊断是？

- A. 胆囊结石

- B. 肝血管瘤
- C. 原发性肝癌 ✅
- D. 肝脓肿
- E. 肝硬化代偿期

答案：C

> 解析：乙肝背景加肝区持续性钝痛加肝大质硬表面结节，提示原发性肝癌；肝脓肿有发热压痛、白细胞升高。教材P427。

---

415. [A2型题 | 理解] batch033-D9-A2-010

> 模块：M9 | 页码：教材P428

男性，45岁。乙肝肝硬化，AFP 890ng/ml，增强CT示肝右叶占位动脉期强化、门脉期减退。最可能的诊断是？

- A. 肝囊肿病变
- B. 肝硬化再生结节
- C. 肝脓肿病灶
- D. 原发性肝癌 ✅
- E. 肝海绵状血管瘤

答案：D

> 解析：乙肝肝硬化背景加AFP显著升高加“快进快出”影像，符合原发性肝癌临床诊断；再生结节AFP多正常、无典型快进快出。教材P428。

---

416. [A2型题 | 理解] batch033-D9-A2-011

> 模块：M9 | 页码：教材P427

肝癌患者反复出现空腹低血糖、红细胞计数增多，无明确糖尿病用药史。这些表现属于？

- A. 肝硬化并发症
- B. 低血糖反应
- C. 真性红细胞增多症

- D. 甲状旁腺功能亢进
- E. 伴癌综合征 ✅

答案：E

> 解析：自发性低血糖与红细胞增多症是肝癌常见伴癌综合征，由肿瘤代谢异常或异位分泌所致。教材P427。

---

417. [A2型题｜应用] batch033-D9-A2-012

> 模块：M9｜页码：教材P427

肝细胞癌患者随访中发现右肺多发结节、咳嗽。最可能的转移途径与部位是？

- A. 血行转移最常见于肺 ✅
- B. 淋巴转移最常见于肺
- C. 直接蔓延至肺
- D. 种植转移至肺
- E. 沿神经转移

答案：A

> 解析：肝癌血行转移最早、最常见为肺；淋巴转移最常见肝门淋巴结。教材P427。

---

418. [A2型题｜应用] batch033-D9-A2-013

> 模块：M9｜页码：教材P429

男性，58岁。肝功Child A，单发肝癌结节直径2cm，无血管侵犯。最适宜的治疗是？

- A. 肝移植优先
- B. 手术切除或射频消融 ✅
- C. 仅全身化疗
- D. 观察随访等待
- E. 单纯TACE治疗

答案：B

> 解析：小肝癌、肝功能代偿者可手术切除或局部消融（射频/微波）获得根治；全身化疗不敏感。教材P429。

---

419. [A2型题｜应用] batch033-D9-A2-014

> 模块：M9｜页码：教材P428

患者无乙肝病史、无肝硬化，CT见肝脏多发占位，原发灶在结肠。该肝脏占位最可能是？

- A. 肝海绵状血管瘤
- B. 肝硬化再生结节
- C. 继发性肝癌（转移瘤） ✅
- D. 原发性肝癌灶
- E. 肝脓肿性病变

答案：C

> 解析：无乙肝/肝硬化背景、多发占位、有结肠等原发灶，多为继发性肝癌，AFP多不升高。教材P428。

---

420. [A3型题｜应用] batch033-D9-A3-015

> 模块：M9｜页码：教材P429

男性，60岁。乙肝肝硬化，肝右叶巨块型肝癌直径8cm，门脉左支癌栓，Child B级，无远处转移。最适宜的首选治疗是？

- A. 肝移植手术治疗
- B. 全身静脉化疗术
- C. 不宜积极抗肿瘤
- D. 经动脉化疗栓塞（TACE） ✅
- E. 立即手术切除灶

答案：D

> 解析：肿瘤较大伴门脉癌栓、肝功能Child B，难以根治性切除，TACE为最常用非手术治疗以控制肿瘤；全身化疗不敏感。教材P429。

421. [A4型题｜分析] batch033-D9-A4-016

> 模块：M9｜页码：教材P428

男性，42岁。乙肝携带，肿瘤标志物轻度升高，超声示肝实质回声增粗、无明确占位，增强MRI未见快进快出。下一步最合理的处理是？

- A. 立即按肝癌手术切除
- B. 诊断原发性肝癌成立
- C. 无需影像学复查随访
- D. 直接行肝移植手术治疗
- E. 动态随访AFP与影像必要时活检 ✅

答案：E

> 解析：AFP轻度升高可由慢性肝炎/肝硬化引起，无典型影像不支持肝癌，应动态随访AFP加影像，必要时肝穿刺活检；不能仅凭AFP轻度升高确诊。教材P428。

---

422. [B1型题｜记忆] batch033-D9-B1-017

> 模块：M9｜页码：教材P427

原发性肝癌血行转移最常见的部位是？

- A. 肺 ✅
- B. 脑
- C. 骨
- D. 肾
- E. 脾

答案：A

> 解析：肝癌血行转移最早、最常见为肺；其次可至骨、脑等。教材P427。

---

423. [B1型题｜记忆] batch033-D9-B1-018

> 模块：M9｜页码：教材P427

原发性肝癌淋巴转移最常见的部位是？

- A. 腹膜后淋巴结
- B. 肝门淋巴结 ✅
- C. 锁骨上淋巴结
- D. 腋窝淋巴结
- E. 腹股沟淋巴结

答案：B

> 解析：肝癌淋巴转移最常见肝门淋巴结，其次胰周、腹膜后等。教材P427。

---

424. [X型题｜理解] batch033-D9-X-019

> 模块：M9｜页码：教材P428

关于原发性肝癌的诊断，下列说法正确的有？

- A. AFP>400ng/ml提示原发性肝癌 ✅
- B. 增强CT快进快出支持诊断 ✅
- C. 肝穿刺活检为确诊最可靠 ✅
- D. B超是肝癌筛查首选检查 ✅
- E. AFP正常即可排除肝癌

答案：ABCD

> 解析：AFP>400ng/ml（排除其他）高度提示，增强CT“快进快出”为明确诊断影像，B超筛查首选，活检最可靠；AFP正常不能排除肝癌（部分肝癌AFP不高）。教材P428。

---

425. [X型题｜应用] batch033-D9-X-020

> 模块：M9｜页码：教材P429

关于原发性肝癌治疗的叙述，正确的有？

- A. 手术切除是获得长期生存的首选 ✅
- B. TACE是最常用非手术方法 ✅
- C. 小肝癌可射频消融或肝移植 ✅
- D. 一般不常规行全身化疗 ✅
- E. 所有患者均应肝移植

答案：ABCD

> 解析：手术切除首选（长期生存），TACE最常用非手术，小肝癌可消融或肝移植，肝癌对全身化疗不敏感故不常规全身化疗；肝移植有严格适应证，并非所有患者适用。教材P429。

M10（18题）

426. [A1型题 | 记忆] batch033-D10-A1-001

> 模块：M10 | 页码：教材P460

上、下消化道出血的解剖分界标志是？

- A. 屈氏韧带（Treitz） ✅
- B. 幽门括约肌标志
- C. 回盲瓣解剖部位
- D. 乙状结肠交界部位
- E. 肛管齿状线标志

答案：A

> 解析：屈氏韧带（Treitz韧带）是划分上、下消化道的解剖标志：其上为上消化道，其下为下消化道。教材P460。

---

427. [A1型题 | 记忆] batch033-D10-A1-002

> 模块：M10 | 页码：教材P460

引起呕血和黑便最常见的病因是？

- A. 贲门黏膜撕裂综合征
- B. 消化性溃疡病 ✅
- C. 食管胃底静脉曲张破裂
- D. 急性糜烂出血性胃炎
- E. 胃部癌性病变

答案：B

> 解析：上消化道出血最常见病因为消化性溃疡（约占半数），其次为食管胃底静脉曲张破裂、急性糜烂出血性胃炎、胃癌。教材P460。

---

428. [A1型题 | 记忆] batch033-D10-A1-003

> 模块：M10 | 页码：教材P461

出现柏油样黑便，提示消化道出血量至少约为？

- A. 5ml
- B. 50ml ✅
- C. 250ml
- D. 1000ml
- E. 1500ml

答案：B

> 解析：粪隐血阳性约5ml，黑便约50ml，呕血约250ml，失血性休克>1000ml（全身血量20%以上）。教材P461。

---

429. [A1型题 | 记忆] batch033-D10-A1-004

> 模块：M10 | 页码：教材P461

出现呕血，提示胃内出血量至少约为？

- A. 1000ml
- B. 500ml
- C. 250ml ✅

- D. 50ml
- E. 5ml

答案：C

> 解析：呕血提示胃内积血≥250ml；黑便约50ml，休克>1000ml。教材P461。

---

430. [A1型题 | 理解] batch033-D10-A1-005

> 模块：M10 | 页码：教材P461

提示上消化道活动性出血最有价值的实验室指标是？

- A. 血清肌酐降低
- B. 血钾浓度升高
- C. 血尿素氮（BUN）升高 ✅
- D. 血清白蛋白降低
- E. 血清转氨酶升高

答案：C

> 解析：上消化道出血后血液在肠道分解吸收及肾前性灌注不足，使BUN升高明显；下消化道出血BUN升高不明显。教材P461。

---

431. [A1型题 | 理解] batch033-D10-A1-006

> 模块：M10 | 页码：教材P463

上消化道出血病情稳定后，急诊胃镜检查的最佳时机是？

- A. 1周之后复查
- B. 1个月后复查
- C. 仅在手术前
- D. 24-48小时内 ✅
- E. 立即在出血时

答案：D

> 解析：上消化道出血应在补充血容量、生命体征平稳后24-48小时内行急诊胃镜，既可诊断又可止血。教材P463。

---

432. [A1型题｜理解] batch033-D10-A1-007

> 模块：M10丨页码：教材P463

非静脉曲张性上消化道出血（溃疡、胃炎）止血首选的药物是？

- A. 生长抑素类药物
- B. 垂体后叶素药物
- C. 奥曲肽静脉用药
- D. 去甲肾上腺素口服
- E. 大剂量质子泵抑制剂(PPI) ✅

答案：E

> 解析：非静脉曲张性上消化道出血用大剂量PPI抑制胃酸，使胃内pH>6利于血小板聚集与凝血；生长抑素/奥曲肽用于静脉曲张出血。教材P463。

---

433. [A1型题｜理解] batch033-D10-A1-008

> 模块：M10丨页码：教材P463

食管胃底静脉曲张破裂出血止血，降低门静脉压力的首选药物是？

- A. 生长抑素（或奥曲肽） ✅
- B. 大剂量PPI
- C. 垂体后叶素单用
- D. 凝血酶口服剂
- E. 雌激素类药物

答案：A

> 解析：静脉曲张出血首选生长抑素或奥曲肽收缩内脏血管、降低门脉压，并配合急诊内镜套扎/硬化剂。教材P463。

434. [A2型题｜理解] batch033-D10-A2-009

> 模块：M10丨页码：教材P460

青年男性，排柏油便2天，伴头晕、心慌、血压降低、心率增快。无肝炎病史，肝脾不大。最可能的诊断是？

- A. 胆道源性出血
- B. 十二指肠溃疡并出血 ✅
- C. 胃癌并发出血
- D. 肝硬化食管静脉曲张破裂
- E. 急性胃黏膜炎症

答案：B

> 解析：青年加柏油便加休克、无肝炎/肝脾大，符合十二指肠溃疡并上消化道大出血；胃癌多见于老年，肝硬化静脉曲张多有肝病背景。教材P460。[源:考研真题 GS-2014-099]

---

435. [A2型题｜理解] batch033-D10-A2-010

> 模块：M10丨页码：教材P424

男性，40岁。血吸虫性肝硬化、脾大、血小板减少，曾上消化道出血，胃镜示食管静脉重度曲张。为预防再次出血，首选的措施是？

- A. 定期腹腔穿刺放液
- B. 脾切除加断流术
- C. 非选择性β阻滞剂联合内镜套扎 ✅
- D. 长期口服质子泵抑制剂
- E. 立即外科手术治疗

答案：C

> 解析：食管胃底静脉曲张一级预防（未出血或曾出血）用非选择性β受体阻滞剂（如普萘洛尔）降低门脉压，并可联合内镜套扎；PPI用于非静脉曲张出血。教材P424。[源:考研真题 GS-2006-099]

---

436. [A2型题｜应用] batch033-D10-A2-012

> 模块：M10丨页码：教材P461

患者突发呕血500ml后，心率120次/分、收缩压80mmHg、四肢湿冷、神志淡漠。估计失血量至少约为？

- A. 50ml以内
- B. 250ml左右
- C. <500ml
- D. 500至1000ml
- E. >1500ml(休克) ✅

答案：E

> 解析：心率快、收缩压下降、湿冷、神志淡漠提示重度失血或失血性休克，失血量>1500ml（或>全身血量20%）；<500ml仅心率略快。教材P461。

---

437. [A2型题｜应用] batch033-D10-A2-013

> 模块：M10丨页码：教材P463

男性，50岁。消化性溃疡并出血，胃镜见十二指肠球部血管裸露。最适宜的止血方式是？

- A. 仅口服PPI药物治疗
- B. 立即外科手术治疗
- C. 经动脉栓塞介入治疗
- D. 放疗辅助止血处理
- E. 内镜下肾上腺素或钛夹止血 ✅

答案：E

> 解析：非静脉曲张出血在内镜下注射1:10000肾上腺素、钛夹夹闭或热凝固止血，并配合PPI；内镜失败才考虑介入或手术。教材P463。

---

438. [A2型题 | 应用] batch033-D10-A2-014

> 模块：M10 | 页码：教材P461

患者呕吐咖啡渣样物伴柏油样便、血尿素氮增高，无鲜血便。最能支持上消化道出血的依据是？

- A. 呕血加黑便加BUN升高 ✅
- B. 以下消化道出血
- C. 腹痛为突出表现
- D. 常伴发热表现
- E. 出现黄疸表现

答案：A

> 解析：呕血加黑便加血尿素氮升高提示上消化道出血（血液肠道吸收致BUN升高）；下消化道出血多便血、BUN升高不明显。教材P461。

---

439. [A3型题 | 应用] batch033-D10-A3-015

> 模块：M10 | 页码：教材P460

男性，45岁。突发呕血、黑便，既往有十二指肠溃疡病史。为明确出血病因，最有帮助的检查是？

- A. 放射性核素扫描
- B. 内镜检查评估 ✅
- C. 选择性腹腔动脉造影
- D. X线钡餐检查
- E. 胃黏膜活检

答案：B

> 解析：上消化道出血最常见病因为消化性溃疡，明确出血部位与病因最有帮助的检查是内镜，且可同时止血；X线钡餐在急性期价值有限。教材P460。[源:考研真题 GS-1995-092]

---

440. [A4型题｜分析] batch033-D10-A4-016

> 模块：M10｜页码：教材P463

男性，52岁。乙肝肝硬化，突发大量呕血、黑便，神志尚清，血压90/60mmHg。关于其急救，下列说法最合理的是？

- A. 仅用质子泵抑制剂药物治疗
- B. 等待休克纠正后再处理出血
- C. 先补液，再用生长抑素并急诊内镜止血 ✅
- D. 立即三腔二囊管永久压迫
- E. 立即行急诊外科手术治疗

答案：C

> 解析：食管胃底静脉曲张破裂出血应先补充血容量抗休克，再用生长抑素降门脉压，并于24-48小时内急诊内镜套扎/硬化剂止血；三腔二囊管为≤24小时桥梁，手术非首选。教材P463。

---

441. [B1型题｜记忆] batch033-D10-B1-017

> 模块：M10｜页码：教材P460

上消化道出血的典型表现是？

- A. 果酱样便
- B. 陶土样便
- C. 仅头晕
- D. 呕血伴黑便 ✅
- E. 鲜血便

答案：D

> 解析：上消化道出血（Treitz以上）多表现为呕血与黑便；下消化道出血多以便血为主。教材P460。

---

442. [X型题｜理解] batch033-D10-X-019

> 模块：M10丨页码：教材P460

可引起上消化道出血的病因包括？

- A. 消化性溃疡 ✅
- B. 胃部癌肿 ✅
- C. 食管憩室炎 ✅
- D. 慢性萎缩性胃炎 ✅
- E. 下肢静脉曲张

答案：ABCD

> 解析：上消化道（食管至空肠上段、胆胰）出血病因包括消化性溃疡、胃癌、食管憩室炎等；慢性萎缩性胃炎很少引起出血，下肢静脉曲张与消化道出血无关。教材P460。[源:考研真题GS-2021-156]

---

443. [X型题｜应用] batch033-D10-X-020

> 模块：M10丨页码：教材P463

关于消化道出血的止血策略，下列说法正确的有？

- A. 非静脉曲张出血用大剂量PPI ✅
- B. 静脉曲张出血用生长抑素 ✅
- C. 出血后24-48小时内急诊内镜 ✅
- D. 先补充血容量再精确止血 ✅
- E. 下消化道出血首选胃镜

答案：ABCD

> 解析：非静脉曲张出血用PPI、静脉曲张出血用生长抑素，均应在补充血容量后24-48小时内急诊内镜止血；下消化道出血首选结肠镜而非胃镜。教材P463。

📌 图谱归属：题库与真题 MOC ｜ 知识图谱总览